

# Bunga Rampai **INOVASI** **PRAKTIK KEPERAWATAN** **DI BERBAGAI BIDANG**

MEDIKAL BEDAH, MATERNITAS, ANAK, JIWA, KOMUNITAS, DAN GERONTIK



Sudarso • Sri Martini • Indra Tri Astuti • Mutianingsih  
Aini Alifatin • Ulfa Munawaroh Diniyah • Nina Rizka Rohmawati

Editor : Fahrur Rozi

# **BUNGA RAMPAI**

## **INOVASI PRAKTIK KEPERAWATAN DI BERBAGAI BIDANG: MEDIKAL BEDAH, MATERNITAS, ANAK, JIWA, KOMUNITAS, DAN GERONTIK**

### **Penulis:**

Sudarso, S.Kep., Ns., M.Kep.  
Sri Martini, S.Kep., Ns., M.Kep.  
Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An.  
Ns. Mutianingsih, M.Kep.  
Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.  
Ulfa Munawaroh Diniyah, S.Kep., Ns.  
Nina Rizka Rohmawati, S.Kep., Ns., M.Kep.

### **Editor:**

Fahrur Rozi, S.Kep., Ns., M.Kep.



# **Bunga Rampai Inovasi Praktik Keperawatan di Berbagai Bidang: Medikal Bedah, Maternitas, Anak, Jiwa, Komunitas, dan Gerontik**

## **Penulis:**

Sudarso, S.Kep., Ns., M.Kep.  
Sri Martini, S.Kep., Ns., M.Kep.  
Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An.  
Ns. Mutianingsih, M.Kep.  
Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.  
Ulfa Munawaroh Diniyah, S.Kep., Ns.  
Nina Rizka Rohmawati, S.Kep., Ns., M.Kep.

## **Editor:**

Fahrur Rozi, S.Kep., Ns., M.Kep.

**Desain Sampul:** Ivan Zumarano

**Penata Letak:** Muhamad Ilham

**ISBN:** 978-634-7556-88-2

**Cetakan Pertama:** Maret, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

**Copyright © 2026**

**Penerbit Optimal Untuk Negeri**

*All Right Reserved*

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



## **PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

## PRAKATA

Buku Bunga Rampai Inovasi Praktik Keperawatan di Berbagai Bidang: Medikal Bedah, Maternitas, Anak, Jiwa, Komunitas, dan Gerontik disusun untuk memperkaya wawasan dan keterampilan praktis perawat dalam menghadapi kebutuhan layanan kesehatan yang semakin kompleks. Perkembangan ilmu, tuntutan keselamatan pasien, perubahan profil penyakit, serta kemajuan teknologi menuntut praktik keperawatan yang lebih adaptif, berbasis bukti, dan berorientasi pada mutu. Melalui bunga rampai ini, pembaca diajak memahami ragam inovasi dan strategi praktik keperawatan yang dapat diterapkan di berbagai tatanan pelayanan, baik di rumah sakit maupun komunitas.

Isi buku disusun sesuai daftar isi dengan penekanan pada penguatan praktik klinis dan kolaborasi. Chapter 1 membahas praktik keperawatan medikal bedah yang menyoroti inovasi perawatan luka, manajemen infus, dan perawatan pasca operasi sebagai bagian penting dari pencegahan komplikasi dan pemulihan pasien. Chapter 2 mengangkat praktik keperawatan maternitas yang mencakup ANC, manajemen persalinan, serta dukungan laktasi berbasis bukti untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Chapter 3 membahas keperawatan anak dengan pendekatan family centered care dan manajemen nyeri pediatrik secara holistik. Chapter 4 menyoroti keperawatan jiwa melalui terapi aktivitas kelompok, komunikasi efektif, dan manajemen krisis sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup klien dan keluarga.

Sebagai penguatan sistem pelayanan, Chapter 5 menguraikan kolaborasi interprofesional dalam praktik keperawatan, mulai dari konsep, peran, implementasi, hingga strategi mengatasi hambatan dan dampaknya terhadap mutu layanan. Chapter 6 membahas pemanfaatan teknologi dalam keperawatan seperti tele-nursing, aplikasi mobile, dan peralatan klinis modern yang mendukung efisiensi serta kontinuitas asuhan. Chapter 7 menutup buku ini dengan pengembangan praktik keperawatan berbasis kompetensi klinis dan standar profesi, termasuk strategi penguatan dan dampaknya bagi peningkatan mutu pelayanan. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh penulis dan pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, perawat klinis, pendidik, dan pengelola layanan sebagai referensi aplikatif untuk memperkuat praktik keperawatan yang inovatif, profesional, dan berpusat pada pasien.

**Editor**

# DAFTAR ISI

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>PRAKATA.....</b>    | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b> | <b>iv</b>  |

## **CHAPTER 1 PRAKTIK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH : INOVASI PERAWATAN LUKA, MANAJEMEN INFUS, DAN PERAWATAN PASCA OPERASI .....**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>OPERASI .....</b>             | <b>1</b> |
| Sudarso, S.Kep., Ns., M.Kep..... | 1        |
| A. Pendahuluan.....              | 1        |
| B. Inovasi Perawatan Luka.....   | 3        |
| C. Manajemen Infus.....          | 9        |
| D. Perawatan Pasca Operasi ..... | 11       |
| E. Simpulan.....                 | 15       |
| F. Referensi.....                | 16       |
| G. Glosarium.....                | 17       |

## **CHAPTER 2 PRAKTIK KEPERAWATAN MATERNITAS: ANC, MANAJEMEN PERSALINAN, DAN DUKUNGAN LAKTASI BERBASIS BUKTI .....**

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PERSALINAN, DAN DUKUNGAN LAKTASI BERBASIS BUKTI .....</b>                          | <b>19</b> |
| Sri Martini, S.Kep., Ns., M.Kep. ....                                                 | 19        |
| A. Pendahuluan.....                                                                   | 19        |
| B. Praktik Keperawatan Maternitas Dalam Ante Natal Care (ANC).....                    | 20        |
| C. Praktik Keperawatan Maternitas Dalam Manajemen Persalinan .....                    | 24        |
| D. Praktik Maternitas Keperawatan Dalam Bentuk Dukungan Laktasi Berbasis Laktasi..... | 27        |
| E. Simpulan.....                                                                      | 32        |
| F. Referensi.....                                                                     | 33        |

## **CHAPTER 3 PRAKTIK KEPERAWATAN ANAK: PENDEKATAN FAMILY CENTERED CARE DAN MANAJEMEN NYERI PEDIATRIK .....**

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CENTERED CARE DAN MANAJEMEN NYERI PEDIATRIK .....</b>                   | <b>35</b> |
| Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An. ....                              | 35        |
| A. Pendahuluan.....                                                        | 35        |
| B. <i>Family Cantered Care</i> (FCC) dalam Keperawatan Anak.....           | 36        |
| C. Manajemen Nyeri Pada Anak: Pendekatam Holistik dan Berbasis Bukti ..... | 38        |

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| D. Integrasi <i>Family Cantered Care</i> (FCC) dan Manajemen Nyeri dalam Praktik Keperawatan Anak..... | 41 |
| E. Simpulan.....                                                                                       | 43 |
| F. Referensi.....                                                                                      | 43 |
| G. Glosarium.....                                                                                      | 45 |

#### **CHAPTER 4 PRAKTIK KEPERAWATAN JIWA: TERAPI AKTIFITAS KELOMPOK, KOMUNIKASI EFEKTIF,DAN MANAJEMEN KRISIS.....47**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Ns. Mutianingsih, M.Kep. ....      | 47 |
| A. Pendahuluan.....                | 47 |
| B. Terapi Aktivitas Kelompok ..... | 48 |
| C. Komunitas Efektif .....         | 53 |
| D. Manajemen Krisis.....           | 57 |
| E. Simpulan.....                   | 65 |
| F. Referensi.....                  | 66 |
| G. Glosarium.....                  | 68 |

#### **CHAPTER 5 KOLABORASI INTERPROFESIONAL DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN .....69**

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.....                                                       | 69 |
| A. Pendahuluan.....                                                                    | 69 |
| B. Konsep Dasar Kolaborasi Interprofesional.....                                       | 72 |
| C. Landasan Teoretis Kolaborasi Interprofesional .....                                 | 75 |
| D. Peran Dan Tanggung Jawab Perawat Dalam Kolaborasi Interprofesional .....            | 78 |
| E. Bentuk dan Implementasi Kolaborasi Interprofesional dalam Praktik Keperawatan ..... | 80 |
| F. Tantangan dan Hambatan Kolaborasi Interprofesional.....                             | 84 |
| G. Strategi Penguatan Kolaborasi Interprofesional.....                                 | 87 |
| H. Dampak Kolaborasi Interprofesional Terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan .....        | 90 |
| I. Penutup .....                                                                       | 92 |
| J. Daftar Pustaka .....                                                                | 93 |

#### **CHAPTER 6 PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM KEPERAWATAN: TELE-NURSING, MOBILE APPS, DAN PERALATAN KLINIS MODERN.....97**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Ulfa Munawaroh Diniyah, S.Kep., Ns. ....                     | 97 |
| A. Pendahuluan.....                                          | 97 |
| B. Konsep Dasar Pemanfaatan Teknologi dalam Keperawatan..... | 98 |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| C. Tele-Nursing dalam Berbagai Bidang Keperawatan.....             | 99  |
| D. Pemanfaatan Mobile Applications dalam Praktik Keperawatan ..... | 104 |
| E. Peralatan Klinis Modern dalam Praktik Keperawatan .....         | 107 |
| F. Referensi.....                                                  | 109 |
| G. Glosarium.....                                                  | 111 |

## **CHAPTER 7 PENGEMBANGAN PRAKTIK KEPERAWATAN BERBASIS**

### **KOMPETENSI KLINIS DAN STANDART PROFESI.....113**

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Nina Rizka Rohmawati,S.Kep., Ns., M.Kep. ....           | 113 |
| A. Pendahuluan.....                                     | 113 |
| B. Konsep Dasar Pengembangan Praktik Keperawatan .....  | 114 |
| C. Kompetensi Klinis Perawat.....                       | 116 |
| D. Standar Profesi Keperawatan.....                     | 119 |
| E. Integrasi Kompetensi Klinis dan Standar Profesi..... | 125 |
| F. Strategi Pengembangan Praktik Keperawatan.....       | 129 |
| G. Dampak Pengembangan Praktik Keperawatan.....         | 133 |
| H. Simpulan.....                                        | 135 |
| I. Referensi.....                                       | 136 |
| J. Glosarium.....                                       | 136 |

### **PROFIL PENULIS .....137**

# CHAPTER 1

## PRAKTIK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH : INOVASI PERAWATAN LUKA, MANAJEMEN INFUS, DAN PERAWATAN PASCA OPERASI

Sudarso, S.Kep., Ns., M.Kep.

### A. Pendahuluan

Keperawatan medikal bedah merupakan mata kuliah inti dan area praktik utama dalam pendidikan keperawatan jenjang Sarjana (S1) dan Profesi Ners. Bidang ini berfokus pada pemberian asuhan keperawatan komprehensif kepada pasien dewasa dengan gangguan kesehatan pada berbagai sistem tubuh, baik kondisi akut, kronis, kritis, maupun pasien yang menjalani tindakan pembedahan. Perawat dituntut tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, serta penerapan praktik keperawatan berbasis bukti (*evidence-based nursing*) (Ignatavicius & Workman, 2021; Smeltzer et al., 2019; Potter et al., 2021).

Perawatan luka merupakan komponen kritis dalam proses penyembuhan pasien yang menjalani prosedur bedah medikal. Luka operasi yang tidak dirawat dengan baik dapat menyebabkan infeksi, memperlambat proses penyembuhan, dan meningkatkan risiko komplikasi serius, seperti dehiscence atau bahkan sepsis (Jones & Smith, 2020). Oleh karena itu, manajemen luka yang efektif adalah bagian integral dari perawatan pasca operasi dan dapat berdampak signifikan pada hasil klinis pasien (Miller & Johnson, 2019).

Perawat memainkan peran utama dalam perawatan luka, mulai dari pembersihan dan penggantian balutan hingga pemantauan tanda-tanda infeksi dan komplikasi lainnya. Peran ini tidak hanya memerlukan keterampilan teknis tetapi juga pemahaman yang mendalam tentang proses penyembuhan luka dan kemampuan untuk memberikan edukasi kepada pasien tentang cara merawat luka mereka di rumah (Brown & Green, 2020). Pengetahuan tentang berbagai jenis balutan luka, teknik aseptik, dan perawatan luka khusus sangat penting untuk memastikan bahwa luka sembuh dengan baik tanpa komplikasi (WHO, 2021). Edukasi pasien adalah aspek lain yang sangat penting dalam perawatan luka. Pasien harus diberi pengetahuan yang cukup tentang cara merawat luka mereka sendiri, mengenali tanda-tanda infeksi, dan memahami pentingnya menjaga



kebersihan luka. Edukasi ini harus dilakukan oleh perawat dengan cara yang mudah dipahami dan diterapkan oleh pasien, yang mungkin tidak memiliki latar belakang medis (Smith & Lee, 2018). Pendekatan ini memastikan bahwa pasien dapat berperan aktif dalam proses penyembuhan mereka sendiri, yang dapat meningkatkan hasil klinis dan mengurangi risiko komplikasi (Green & Black, 2017). Selain itu, perawat harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dengan pasien dan keluarga mereka untuk memberikan dukungan emosional dan praktis yang diperlukan selama masa pemulihan. Dukungan keluarga dapat berperan besar dalam keberhasilan perawatan luka, karena mereka sering kali menjadi penolong utama dalam menjaga kebersihan luka dan memastikan bahwa instruksi perawatan diikuti dengan benar (Green & Black, 2017)

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, dan tuntutan mutu pelayanan kesehatan mendorong praktik keperawatan medikal bedah untuk terus berinovasi. Salah satu aspek krusial adalah perawatan luka. Luka pasca operasi, luka traumatik, maupun luka kronis seperti ulkus diabetikum dan luka tekan membutuhkan penanganan yang tepat dan sistematis. Pendekatan inovatif dalam perawatan luka, seperti konsep *moist wound healing*, penggunaan balutan modern, serta penerapan standar asuhan keperawatan berbasis bukti, terbukti mampu mempercepat proses penyembuhan, menurunkan risiko infeksi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien (Guo & DiPietro, 2010; Smeltzer et al., 2019; Wound, Ostomy and Continence Nurses Society [WOCN], 2021).

Manajemen infus juga merupakan kompetensi esensial yang harus dikuasai oleh mahasiswa S1 Keperawatan dan perawat profesi Ners. Terapi infus berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan cairan, elektrolit, pemberian obat-obatan, nutrisi parenteral, serta transfusi darah. Kesalahan dalam manajemen infus dapat menimbulkan komplikasi serius, seperti flebitis, infiltrasi, dan infeksi aliran darah. Oleh karena itu, perawat harus mampu menerapkan prinsip keselamatan pasien, pencegahan infeksi, serta inovasi teknologi dan prosedur sesuai standar pelayanan keperawatan (Infusion Nurses Society [INS], 2021; Potter et al., 2021; World Health Organization [WHO], 2022).

Perawatan pasca operasi merupakan fase kritis yang sangat menentukan keberhasilan tindakan pembedahan. Pada tahap ini, perawat memiliki peran sentral dalam pemantauan kondisi fisiologis pasien, manajemen nyeri, pemenuhan kebutuhan dasar, pencegahan komplikasi, serta edukasi kesehatan. Pendekatan inovatif seperti *Enhanced Recovery After Surgery* (ERAS) menekankan peran aktif perawat dalam mempercepat pemulihan pasien melalui asuhan keperawatan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berpusat pada pasien (Ignatavicius & Workman, 2021; Ljungqvist et al., 2017; Smeltzer et al., 2019).

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai praktik keperawatan medikal bedah yang menitikberatkan pada inovasi perawatan luka, manajemen infus, dan perawatan pasca operasi menjadi sangat relevan bagi mahasiswa S1 Keperawatan dan Profesi Ners sebagai bekal dalam memberikan asuhan keperawatan profesional, aman, dan bermutu

## **B. Inovasi Perawatan Luka**

---

### **1. Konsep Dasar Perawatan Luka**

Perawatan luka merupakan bagian integral dari praktik keperawatan medikal bedah yang bertujuan untuk mendukung proses penyembuhan jaringan, mencegah infeksi, dan meminimalkan komplikasi. Luka dapat diklasifikasikan menjadi luka akut dan luka kronis. Luka akut umumnya terjadi akibat trauma atau tindakan pembedahan dan diharapkan sembuh dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan luka kronis seperti ulkus diabetikum, luka tekan, dan ulkus vena memiliki proses penyembuhan yang lambat dan kompleks. Perawat memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian luka secara komprehensif, meliputi lokasi, ukuran, kedalaman, kondisi jaringan, eksudat, serta tanda-tanda infeksi sebagai dasar penentuan intervensi keperawatan yang tepat (Smeltzer et al., 2019).

Perawatan luka adalah intervensi yang dilakukan oleh perawat untuk mengidentifikasi dan meningkatkan penyembuhan luka serta mencegah terjadinya komplikasi luka (PPNI, 2018). Beberapa factor yang memengaruhi perawatan luka meliputi jenis luka, kondisi kesehatan pasien, lingkungan sekitar, dan teknologi medis yang tersedia.

### **2. Tujuan dan manfaat perawatan luka**

Perawatan luka adalah suatu langkah dalam keperawatan yang bertujuan untuk menghindari infeksi yang dapat masuk melalui lukadan untuk mempercepat penyembuhan luka diabetik (Lailasari dan rekan-rekan, 2022).

Manfaat dari perawatan luka adalah menjaga kebersihan luka dapat mencegah infeksi, memberikan rasa tenang dan nyaman kepada pasien. Mempercepat proses penyembuhan luka, menghindari kerusakan jaringan yang lebih parah, membersihkan luka dari kotoran atau benda asing, mempermudah pengeluaran cairan dari luka, mencegah masuknya mikroba dan kotoran ke dalam luka serta menghindari perdarahan serta pembentukan jaringan parut di sekitar luka (Cahyono dkk., 2021)

### 3. Mekanisme perawatan luka

Menurut Sukmana et al. (2020) perawatan luka secara umum di bagi menjadi 3 tahapan yaitu pencucian, pengkajian dan pemilihan balutan.

#### a. Pencucian Luka

Pencucian luka merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam perawatan luka. Tujuan dilakukan pencucian luka yaitu untuk membersihkan jaringan nekrotik, membuang dan mengurangi jumlah bakteri, membuang eksudat purulent, melembabkan luka dan memelihara kebersihan jaringan kulit sekitar luka. Salah satu jenis cairan yang dapat digunakan untuk perawatan luka diabetes, 9% Cairan normal salin (NS) atau NaCl 0,9% merupakan cairan yang direkomendasi sebagai pembersih luka, karena cairan normal salin memiliki komposisi sama seperti plasma darah sehingga aman bagi tubuh, tidak iritan, melindungi granulasi jaringan dari kondisi kering, menjaga kelembaban sekitar luka dan membantu luka menjalani proses penyembuhan serta mudah di dapat (Lestari & Kunidah, 2020). Menurut Haris (2009) dalam Purnamasari (2021) metode pembersihan luka konvensional yang menggunakan antiseptik seperti hydrogen peroxide, povidone iodine, acetic acid, dan chlorohexidine dapat menghambat proses penyembuhan tubuh karena kandungan antiseptik nya tidak hanya membunuh kuman tetapi juga leukosit yang dapat membunuh bakteri patogen dan fibroblast, yang bertanggung jawab untuk membuat jaringan kulit baru.

#### b. Pengkajian luka

Pemilihan balutan luka yang baik dan benar selalu berdasarkan pengkajian luka. Sehingga pengkajian luka hendaknya dilakukan secara komprehensif dan sistematis, tujuan pengkajian luka, yaitu mendapatkan informasi yang relevan tentang pasien dan luka, memonitor proses penyembuhan luka, menentukan program perawatan luka pada pasien, mengevaluasi keberhasilan perawatan. Menurut sukmana, Aminuddin, dkk (2020) Pengkajian luka meliputi :

##### 1) Jenis luka

- a) Luka akut terdiri dari berbagai jenis luka bedah yang sembuh dengan intensi primer, traumatik, atau sekunder, dan mencapai hasil pemulihan integritas anatomis yang sesuai dengan proses penyembuhan fisiologis.
- b) Luka kronik adalah ketika proses perbaikan jaringan tidak berjalan sesuai rencana dan penyembuhan terhambat oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik yang memengaruhi individu, luka, atau lingkungan. Luka kronis juga disebut sebagai kegagalan penyembuhan luka akut

- 2) Tipe penyembuhan luka
  - a) Primary Intention. Jika terdapat kehilangan jaringan minimal dan kedua tepi luka dirapatkan baik dengan suture (jahitan), clips atau tape (plester). Tipe penyembuhan ini umumnya, jaringan parut yang dihasilkan minimal.
  - b) Delayed Primary Intention. Jika luka terinfeksi atau mengandung benda asing dan membutuhkan pembersihan intensif, selanjutnya ditutup secara primer pada 3-5 hari kemudian.
  - c) Secondary Intention. Penyembuhan luka terlambat dan terjadi melalui proses granulasi, kontraksi dan epitelisasi. Jaringan parut cukup luas.
  - d) Skin Graft. Skin graft tipis dan tebal digunakan untuk mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi resiko infeksi
  - e) Flap. Pembedahan relokasi kulit dan jaringan subcutan pada luka yang berasal dari jaringan terdekat
- 3) Kehilangan jaringan

Kehilangan jaringan menggambarkan kedalaman kerusakan jaringan atau berkaitan dengan stadium kerusakan jaringan kulit

  - a) Superfisial luka sebatas epidermis.
  - b) Parsial (Partial thickness). Luka meliputi epidermis dan dermis.
  - c) Penuh (Full thickness) Luka meliputi epidermis, dermis dan jaringan subcutan. Mungkin juga melibatkan otot, tendon dan tulang atau dapat juga digambarkan melalui beberapa stadium luka (Stadium I – IV).
    - Stage I: Lapisan epidermis utuh, namun terdapat erythema atau perubahan warna.
    - Stage II: Kehilangan kulit superfisial dengan kerusakan lapisan epidermis dan dermis Erythema di jaringan sekitar yang nyeri, panas dan edema. Exudate sedikit sampai sedang mungkin ada.
    - Stage III: Kehilangan sampai dengan jaringan subcutan, dengan terbentuknya rongga (cavity), terdapat exudat sedang sampai banyak.
    - Stage IV: Hilangnya jaringan subcutan dengan terbentuknya rongga (cavity), yang melibatkan otot, tendon dan/atau tulang. Terdapat eksudat sedang sampai banyak.
- 4) Penampilan klinis

Tampilan klinis luka dapat di bagi berdasarkan warna dasar luka antara lain:

- a) Hitam atau nekrotik yaitu eschar yang mengeras dan nekrotik, mungkin kering atau lembab.
  - b) Kuning atau sloughy yaitu jaringan mati yang fibrous, kuning dan slough.
  - c) Merah atau granulasi yaitu jaringan granulasi sehat.
  - d) Pink atau epithellating yaitu terjadi epitelisasi.
  - e) Kehijauan atau terinfeksi yaitu terdapat tanda-tanda klinis infeksi seperti nyeri, panas, bengkak, kemerahan dan peningkatan eksudat.
- 5) Lokasi
- Lokasi luka mempengaruhi waktu penyembuhan dan jenis perawatan yang diberikan. Luka dipersendian sering bergerak dan tergesek, memungkinkan penyembuhan yang lebih lambat karena migrasi dan regenerasi sel yang terkena trauma di area seperti siku, lutut, dan kaki. Area yang rentan terhadap tekanan atau gaya lipatan (shearforce) akan sembuh secara bertahap, seperti pinggul dan bokong. Sebaliknya, area dengan vaskularisasi yang baik akan sembuh lebih cepat.
- 6) Ukuran luka
- Dimensi ukuran meliputi ukuran panjang, lebar, kedalaman atau diameter (lingkaran). Pengkajian dan evaluasi kecepatan penyembuhan luka dan modalitas terapi adalah komponen penting dari perawatan luka
- 7) Eksudasi
- Hal yang perlu dicatat tentang eksudat adalah jenis, jumlah, warna, konsistensi dan bau.
- a) Jenis Eksudat Eksudat memiliki beberapa jenis meliputi: Serous yaitu cairan berwarna jernih, Hemoserous yaitu cairan serous yang berwarna merah terang, Sanguenous yaitu cairan berwarna darah kental/pekat, Purulent yaitu kental mengandung nanah.
  - b) Jumlah, eksudat dapat dikategorikan minimal, sedang dan banyak.
  - c) Warna, ini berhubungan dengan jenis eksudat namun juga menjadi indikator klinik yang baik dari jenis bakteri yang ada pada luka terinfeksi (contoh, pseudomonas aeruginosa yang berwarna hijau/kebiruan)
  - d) Konsistensi. Ini berhubungan dengan jenis eksudat, sangat bermakna pada luka yang edema dan fistula.
  - e) Bau. Ini berhubungan dengan infeksi luka dan kontaminasi luka oleh cairan tubuh seperti faeces terlihat pada fistula
- 8) Kulit sekitar luka

Inspeksi dan palpasi untuk mengetahui apakah ada sellulitis, edema, benda asing, ekzema, dermatitis kontak, atau maserasi kulit sekitar luka. Studi tentang vaskularisasi jaringan sekitar dilakukan, dan batas-batasnya dicatat. Jika luka tekan atau kompresi, catat warna, kehangatan, dan waktu pengisian kapiler. Nadi dipalpasi sebagian besar selama penyelidikan luka ditungkai bawah. Sangat penting untuk memeriksa tepi luka untuk mengidentifikasi epitelisasi dan kontraksi

9) Nyeri

Penyebab nyeri pada luka, baik umum maupun lokal harus dipastikan. Apakah nyeri berhubungan dengan penyakit, pembedahan, trauma, infeksi atau benda asing. Atau apakah nyeri berkaitan dengan praktek perawatan luka atau produk yang dipakai. Nyeri harus diteliti dan dikelola secara tepat

10) Infeksi

Reaksi jaringan tergantung pada daya tahan tubuh host terhadap invasi mikroorganisme. Derajat daya tahan tergantung pada faktor-faktor seperti status kesehatan umum, status nutrisi, pengobatan dan derajat kerusakan jaringan. Infeksi dapat dilihat dari tanda-tanda klinis infeksi dengan peningkatan kadar leukosit atau macrophage

11) Implikasi sosial

Efek psikososial dapat berkembang luas dari pengalaman diperlukaan dan hadirnya luka. Erat kaitannya dengan harga diri dan citra diri, perubahan fungsi tubuh, pemulihan dan rehabilitasi, issue kualitas hidup, peran keluarga dan sosial dan status finansial

c. Fase penyembuhan luka

1) Fase inflamasi

Terjadi hari ke-0 sampai ke-3. Merupakan respon segera setelah cedera berupa pembekuan darah untuk mencegah kehilangan darah. Hemostasis terjadi di fase awal, dan fagositosis terjadi di fase akhir. Jika tidak ada infeksi, fase ini dapat berlangsung singkat. Tanda-tanda infeksi, yaitu tumor, rubor, nyeri, dolor, dan functio laesa

2) Fase proliferasi

Terjadi hari ke-3 sampai ke-14. Disebut juga sebagai fase granulasi karena pembentukan jaringan granulasi ditandai luka tampak merah muda dan mengkilat. Jaringan granulasi terdiri dari fibroblas, sel inflamasi, pembuluh darah baru, ibronektin, dan asam hialuronat. Epitelisasi terjadi pada hari pertama, ditandai dengan penebalan lapisan epidermis padatepian luka.

### 3) Fase maturasi/ remodeling

Merupakan fase akhir dari penyembuhan luka. Bisa berlangsung dari beberapa minggu hingga 2 tahun. Terbentuk kolagen baru, yang mengubah bentuk luka dan meningkatkan kekuatan jaringan. Terbentuk jaringan parut, yang kuatnya 80% dari kulit normal. Berkurangnya aktivitas seluler dan vaskulerisasi jaringan yang mengalami perbaikan

## 4. Inovasi dalam Perawatan Luka

### a. Konsep Moist Wound Healing

Konsep *moist wound healing* merupakan pendekatan inovatif dalam perawatan luka yang menekankan pentingnya menjaga kelembapan luka selama proses penyembuhan. Lingkungan luka yang lembap terbukti dapat mempercepat proses epitelisasi, menurunkan nyeri, dan mengurangi risiko infeksi dibandingkan dengan metode perawatan luka konvensional yang membiarkan luka kering. Penerapan konsep ini menjadi dasar dalam pemilihan balutan modern yang disesuaikan dengan karakteristik luka (Guo & DiPietro, 2010).

### b. Balutan Luka Modern

Perkembangan teknologi kesehatan telah menghasilkan berbagai jenis balutan luka modern, seperti balutan hidrogel, hidrokoloid, alginat, foam, dan film transparan. Balutan modern dirancang untuk mempertahankan kelembapan optimal, menyerap eksudat berlebih, serta melindungi luka dari kontaminasi mikroorganisme. Penggunaan balutan yang tepat terbukti mampu mempercepat penyembuhan luka, mengurangi frekuensi penggantian balutan, dan meningkatkan kenyamanan pasien (Wound, Ostomy and Continence Nurses Society [WOCN], 2021).

### c. Perawatan Luka Berbasis Bukti (Evidence-Based Wound Care)

Perawatan luka berbasis bukti merupakan pendekatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis perawat, serta nilai dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan perawatan. Penerapan *evidence-based wound care* membantu perawat dalam memilih intervensi yang efektif dan aman, serta menurunkan variasi praktik yang tidak sesuai standar. Studi menunjukkan bahwa penerapan perawatan luka berbasis bukti dapat meningkatkan hasil klinis dan kualitas hidup pasien dengan luka kronis maupun akut (Potter et al., 2021).

#### **d. Edukasi Pasien**

Edukasi pasien adalah komponen kunci dalam perawatan luka. Perawat memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif kepada pasien tentang cara merawat luka mereka di rumah. Edukasi ini mencakup cara membersihkan luka, mengganti balutan, dan mengenali tanda-tanda infeksi yang memerlukan perhatian medis segera (Smith & Lee, 2018). Edukasi yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap instruksi perawatan dan secara signifikan mengurangi risiko komplikasi. (Green & Black, 2017)

#### **e. Pencegahan Komplikasi**

Pencegahan komplikasi adalah fokus utama dalam perawatan luka pasca operasi. Perawat bertanggung jawab untuk memantau tanda-tanda vital dan kondisi luka secara teratur, yang memungkinkan deteksi dini komplikasi seperti infeksi, dehiscence, dan nekrosis jaringan (Jones & Smith, 2020). Deteksi dini ini memungkinkan intervensi yang cepat dan tepat, yang dapat mencegah perkembangan komplikasi yang lebih serius dan mempercepat proses penyembuhan (Miller & Johnson, 2019)

#### **f. Peran Perawat dalam Inovasi Perawatan Luka**

Perawat memiliki peran strategis dalam penerapan inovasi perawatan luka, mulai dari pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi asuhan keperawatan. Perawat juga berperan dalam edukasi pasien dan keluarga terkait perawatan luka mandiri, pencegahan infeksi, serta modifikasi gaya hidup yang mendukung proses penyembuhan. Selain itu, perawat dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan agar mampu mengikuti perkembangan inovasi perawatan luka sesuai dengan standar praktik keperawatan profesional (Ignatavicius & Workman, 2021).

### **C. Manajemen Infus**

---

#### **1. Pengertian Manajemen Infus**

Manajemen infus merupakan serangkaian tindakan keperawatan yang meliputi perencanaan, pemasangan, pemantauan, pemeliharaan, dan penghentian terapi infus secara aman dan efektif. Terapi infus digunakan untuk memenuhi kebutuhan cairan, elektrolit, pemberian obat-obatan, nutrisi parenteral, serta transfusi darah pada pasien. Manajemen infus yang tepat menjadi kompetensi esensial bagi perawat profesional karena berkaitan



langsung dengan keselamatan pasien dan kualitas asuhan keperawatan (Infusion Nurses Society [INS], 2021).

Manajemen infus adalah bagian integral dari asuhan keperawatan medikal bedah yang berfokus pada pengelolaan terapi intravena secara sistematis, berbasis bukti, dan sesuai standar praktik untuk mencegah komplikasi seperti flebitis, infiltrasi, dan infeksi aliran darah. **(Ignatavicius & Workman, 2021)**

Manajemen infus adalah serangkaian tindakan keperawatan yang meliputi perencanaan, pemasangan, pemantauan, perawatan, dan penghentian terapi intravena guna memenuhi kebutuhan cairan, elektrolit, obat, nutrisi, serta darah secara aman dan efektif. **(Potter et al., 2021)**

## **2. Tujuan Manajemen Infus**

Tujuan utama manajemen infus adalah untuk mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, memastikan pemberian terapi intravena berjalan efektif, serta mencegah terjadinya komplikasi. Selain itu, manajemen infus bertujuan untuk menjamin kenyamanan pasien dan mendukung proses penyembuhan penyakit secara optimal (Potter et al., 2021).

## **3. Prinsip Dasar Manajemen Infus**

Prinsip dasar manajemen infus meliputi penerapan teknik aseptik, pemilihan jenis cairan dan alat infus yang sesuai, pengaturan kecepatan tetesan yang tepat, serta pemantauan lokasi pemasangan infus secara berkala. Perawat juga harus menerapkan prinsip keselamatan pasien, seperti identifikasi pasien yang benar, pengecekan obat dan cairan secara berlapis, serta dokumentasi keperawatan yang akurat (World Health Organization [WHO], 2022).

## **4. Prosedur Manajemen Infus**

### **a. Pemasangan Infus**

Pemasangan infus dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan alat dan pasien, pemilihan vena yang tepat, penerapan teknik aseptik, pemasangan kanula intravena, serta fiksasi dan pengaturan aliran cairan. Kompetensi perawat dalam pemasangan infus sangat berpengaruh terhadap keberhasilan terapi dan pencegahan komplikasi (INS, 2021).

### **b. Pemantauan dan Pemeliharaan Infus**

Pemantauan infus meliputi observasi lokasi pemasangan terhadap tanda-tanda komplikasi seperti kemerahan, nyeri, pembengkakan, dan keluarnya cairan. Selain itu, perawat harus memantau keseimbangan cairan, kecepatan infus, serta respon pasien terhadap terapi. Pemeliharaan infus

yang baik dapat menurunkan risiko infeksi aliran darah dan meningkatkan keselamatan pasien (O'Grady et al., 2017).

### **c. Penghentian Infus**

Penghentian infus dilakukan setelah terapi selesai atau bila terjadi komplikasi. Prosedur penghentian infus harus dilakukan secara aseptik dan diikuti dengan evaluasi kondisi pasien serta dokumentasi keperawatan yang lengkap (Potter et al., 2021).

## **5. Komplikasi Terapi Infus**

Komplikasi yang dapat terjadi pada terapi infus antara lain flebitis, infiltrasi, ekstrasvasasi, emboli udara, dan infeksi aliran darah. Pengetahuan dan keterampilan perawat dalam manajemen infus berperan penting dalam pencegahan dan deteksi dini komplikasi tersebut. Studi menunjukkan bahwa penerapan standar manajemen infus secara konsisten dapat menurunkan kejadian komplikasi secara signifikan (O'Grady et al., 2017).

## **6. Inovasi dalam Manajemen Infus**

Perkembangan teknologi kesehatan mendorong munculnya inovasi dalam manajemen infus, seperti penggunaan infusion pump elektronik, sistem alarm otomatis, dan integrasi teknologi digital untuk pemantauan terapi intravena. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi pemberian cairan dan obat, serta mengurangi kesalahan medis yang dapat membahayakan pasien (INS, 2021).

## **7. Peran Perawat dalam Manajemen Infus**

Perawat memiliki peran sentral dalam manajemen infus, mulai dari pengkajian kebutuhan pasien, pelaksanaan terapi, pemantauan, hingga edukasi pasien dan keluarga. Perawat juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh tindakan manajemen infus dilakukan sesuai dengan standar praktik keperawatan dan prinsip keselamatan pasien (Ignatavicius & Workman, 2021).

## **D. Perawatan Pasca Operasi**

---

### **1. Pengertian Perawatan Pasca Operasi**

Perawatan pasca operasi adalah rangkaian asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien setelah menjalani tindakan pembedahan dengan tujuan memulihkan fungsi fisiologis, mencegah komplikasi, mengurangi nyeri,

serta meningkatkan proses penyembuhan secara optimal. (*Smeltzer et al., 2019; Ignatavicius & Workman, 2021*)

## **2. Tujuan Perawatan Pasca Operasi**

Tujuan utama perawatan pasca operasi meliputi:

- a. Mempertahankan stabilitas hemodinamik dan fungsi vital pasien
- b. Mengontrol dan mengurangi nyeri
- c. Mencegah komplikasi pasca pembedahan
- d. Memenuhi kebutuhan dasar pasien
- e. Mempercepat proses pemulihan dan rehabilitasi

(*Hinkle & Cheever, 2018*)

## **3. Fase Perawatan Pasca Operasi**

Perawatan pasca operasi dibagi menjadi tiga fase utama :

### **a. Fase Pasca Operasi Segera (Immediate Postoperative Phase)**

Dimulai sejak pasien dipindahkan dari ruang operasi ke ruang pemulihan (PACU). Fokus utama adalah pemantauan jalan napas, pernapasan, sirkulasi, tingkat kesadaran, dan tanda vital. (*Smeltzer et al., 2019*)

### **b. Fase Pasca Operasi Lanjutan (Intermediate Phase)**

Dimulai saat pasien stabil dan dipindahkan ke ruang perawatan. Perawat berfokus pada pemantauan luka operasi, keseimbangan cairan, nutrisi, eliminasi, serta mobilisasi dini. (*Ignatavicius & Workman, 2021*)

### **c. Fase Pasca Operasi Rehabilitatif**

Fase ini bertujuan mengembalikan kemandirian pasien melalui edukasi, Latihan aktivitas, dan persiapan pulang. (*Potter et al., 2021*)

## **4. Asuhan Keperawatan Pasca Operasi**

### **a. Pemantauan Tanda Vital dan Status Fisiologis**

Pemantauan tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, dan saturasi oksigen dilakukan secara berkala untuk mendeteksi dini komplikasi. (*Hinkle & Cheever, 2018*)

### **b. Manajemen Nyeri**

Nyeri adalah bentuk ketidaknyamanan baik sensori maupun emosional yang berhubungan dengan resiko atau aktualnya kerusakan jaringan tubuh, timbul ketika jaringan sedang rusak dan menyebabkan individu tersebut bereaksi untuk menghilangkan rasa nyeri (Faisol, 2022).

Secara fisiologis, nyeri terjadi melalui suatu proses yang disebut **nosisepsi**, yaitu proses saraf yang mendeteksi dan menghantarkan rangsangan nyeri dari jaringan perifer ke sistem saraf pusat. Proses ini terdiri dari empat tahap utama: **transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi**.

Nyeri pasca operasi harus dikelola secara efektif melalui pendekatan farmakologis dan nonfarmakologis agar tidak menghambat proses pemulihan. (*Smeltzer et al., 2019*).

Manajemen nyeri adalah suatu pendekatan terencana dan terintegrasi yang bertujuan untuk mengurangi atau mengendalikan nyeri guna meningkatkan kenyamanan, fungsi, dan kualitas hidup pasien. Manajemen nyeri mencakup pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi intervensi baik farmakologis maupun nonfarmakologis yang disesuaikan dengan kondisi individu pasien.

Tujuan utama manajemen nyeri adalah menurunkan intensitas nyeri, meningkatkan kemampuan fungsional pasien, mencegah komplikasi akibat nyeri yang tidak terkontrol, serta meningkatkan kualitas hidup secara fisik dan psikologis. Manajemen nyeri yang efektif juga berperan penting dalam mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan Kesehatan.

Manajemen nyeri didasarkan pada prinsip bahwa nyeri bersifat subjektif dan hanya dapat dinilai oleh individu yang mengalaminya. Pendekatan manajemen nyeri harus bersifat holistik, berpusat pada pasien, berbasis bukti ilmiah, serta mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya. Kolaborasi antarprofesi kesehatan juga menjadi prinsip penting dalam pengelolaan nyeri yang optimal.

Pengkajian nyeri merupakan langkah awal dan paling penting dalam manajemen nyeri. Pengkajian meliputi lokasi, durasi, intensitas, kualitas nyeri, faktor pencetus dan pereda, serta dampak nyeri terhadap aktivitas sehari-hari. Alat ukur yang umum digunakan antara lain Numeric Rating Scale (NRS), Visual Analog Scale (VAS), dan Wong-Baker FACES Pain Scale.

Manajemen nyeri farmakologis dilakukan dengan pemberian obat-obatan sesuai dengan tingkat keparahan nyeri. Obat yang digunakan meliputi analgesik non-opioid (parasetamol, NSAID), analgesik opioid (morfin, fentanyl), serta adjuvan seperti antidepresan dan antikonvulsan. Pemilihan obat harus mempertimbangkan efektivitas, efek samping, kondisi klinis pasien, serta prinsip keamanan obat.

Manajemen nyeri nonfarmakologis bertujuan untuk mengurangi persepsi nyeri tanpa penggunaan obat. Intervensi ini meliputi teknik relaksasi,

distraksi, kompres hangat atau dingin, pijat, terapi musik, teknik pernapasan dalam, akupresur, dan terapi kognitif-perilaku. Pendekatan ini sering digunakan sebagai terapi pendamping untuk meningkatkan efektivitas manajemen nyeri farmakologis.

Perawat memiliki peran penting dalam manajemen nyeri, mulai dari melakukan pengkajian nyeri secara akurat, memberikan intervensi sesuai rencana asuhan keperawatan, memantau respons pasien terhadap terapi, hingga memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Perawat juga berperan sebagai advokat pasien untuk memastikan nyeri ditangani secara adekuat dan manusiawi.

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan. Evaluasi mencakup penurunan intensitas nyeri, peningkatan fungsi, perubahan perilaku pasien, serta munculnya efek samping terapi. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memodifikasi rencana manajemen nyeri agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasien

#### **c. Perawatan Luka Operasi**

Perawat bertanggung jawab menjaga kebersihan luka, mengganti balutan sesuai prinsip aseptik, serta memantau tanda infeksi. (*Wound, Ostomy and Continence Nurses Society, 2020*)

#### **d. Pencegahan Komplikasi**

Komplikasi pasca operasi meliputi infeksi, perdarahan, tromboemboli, gangguan pernapasan, dan retensi urin. Pencegahan dilakukan melalui mobilisasi dini, latihan napas dalam, dan pemantauan ketat. (*Ignatavicius & Workman, 2021*)

### **5. Inovasi dalam Perawatan Pasca Operasi**

Pendekatan *Enhanced Recovery After Surgery* (ERAS) merupakan inovasi berbasis bukti yang menekankan kolaborasi multidisiplin, mobilisasi dini, manajemen nyeri multimodal, dan nutrisi adekuat untuk mempercepat pemulihan pasien. Perawat berperan penting dalam implementasi protokol ERAS. (*Ljungqvist et al., 2017*)

### **6. Peran Perawat dalam Perawatan Pasca Operasi**

Perawat berperan sebagai pemberi asuhan, edukator, advokat pasien, serta kolaborator dengan tim kesehatan untuk menjamin keselamatan dan kualitas pelayanan pasca pembedahan. (*Potter et al., 2021*)

## E. Simpulan

---

Keperawatan medikal bedah merupakan area praktik inti dalam pendidikan dan pelayanan keperawatan yang menuntut kompetensi komprehensif, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan klinis, maupun sikap profesional. Inovasi dalam praktik keperawatan medikal bedah, khususnya pada perawatan luka, manajemen infus, dan perawatan pasca operasi, memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan dan keselamatan pasien.

Inovasi perawatan luka melalui penerapan konsep *moist wound healing*, penggunaan balutan modern, serta pendekatan berbasis bukti terbukti mampu mempercepat proses penyembuhan, menurunkan risiko infeksi, dan meningkatkan kenyamanan serta kualitas hidup pasien. Keberhasilan perawatan luka sangat bergantung pada pengkajian yang komprehensif, pencegahan komplikasi, serta edukasi pasien dan keluarga yang berkesinambungan, dengan perawat sebagai pelaksana utama asuhan.

Manajemen infus merupakan kompetensi esensial yang harus dikuasai perawat karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan terapi intravena dan keselamatan pasien. Penerapan prinsip aseptik, standar praktik keperawatan, serta pemanfaatan inovasi teknologi dalam manajemen infus dapat meminimalkan risiko komplikasi dan meningkatkan efektivitas terapi.

Perawatan pasca operasi menjadi fase kritis yang menentukan keberhasilan tindakan pembedahan. Asuhan keperawatan yang terencana, sistematis, dan inovatif, termasuk penerapan pendekatan *Enhanced Recovery After Surgery* (ERAS), berkontribusi signifikan dalam mempercepat pemulihan pasien, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kemandirian pasien.

Secara keseluruhan, penguasaan inovasi perawatan luka, manajemen infus, dan perawatan pasca operasi merupakan bekal penting bagi mahasiswa S1 Keperawatan dan Profesi Ners dalam memberikan asuhan keperawatan yang profesional, aman, berbasis bukti, dan bermutu tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan.

## F. Referensi

---

- Brown, L., & Green, P. (2020). *Fundamentals of wound care nursing*. Elsevier.
- Green, A., & Black, S. (2017). Patient and family involvement in wound care management. *Journal of Clinical Nursing*, 26(19–20), 3100–3108.
- Guo, S., & DiPietro, L. A. (2010). Factors affecting wound healing. *Journal of Dental Research*, 89(3), 219–229.
- Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2018). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (14th ed.). Wolters Kluwer.
- Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2023). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing* (15th ed.). Wolters Kluwer.
- Ignatavicius, D. D., & Workman, M. L. (2021). *Medical-surgical nursing: Concepts for interprofessional collaborative care* (10th ed.). Elsevier.
- Ignatavicius, D. D., & Workman, M. L. (2023). *Medical-Surgical Nursing: Concepts for Interprofessional Collaborative Care* (10th ed.). Elsevier
- Infusion Nurses Society. (2021). *Infusion therapy standards of practice*. Journal of Infusion Nursing.
- International Association for the Study of Pain. (2023). *IASP pain clinical updates*.
- Jones, R., & Smith, T. (2020). Postoperative wound complications and nursing management. *International Journal of Nursing Practice*, 26(4), e12845.
- Ljungqvist, O., Scott, M., & Fearon, K. C. H. (2017). Enhanced recovery after surgery: A review. *JAMA Surgery*, 152(3), 292–298.
- McCaffery, M., & Pasero, C. (2023). *Pain: Clinical Manual* (4th ed.). Elsevier.
- Miller, A., & Johnson, D. (2019). Effective wound management in postoperative care. *Nursing Clinics of North America*, 54(3), 401–415.
- O'Grady, N. P., Alexander, M., Burns, L. A., Dellinger, E. P., Garland, J., Heard, S. O., ... Saint, S. (2017). Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. *Clinical Infectious Diseases*, 65(9), e1–e34.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2023). *Fundamentals of Nursing* (11th ed.). Elsevier.
- Smeltzer, S. C., Hinkle, J. L., Cheever, K. H., & Bare, B. G. (2019). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (14th ed.). Wolters Kluwer.
- Smith, J., & Lee, K. (2018). Patient education in wound management. *Journal of Wound Care*, 27(6), 356–362.
- World Health Organization. (2021). *Global guidelines for the prevention of surgical site infection*. WHO.
- World Health Organization. (2022). *Patient safety and infection prevention*

*guidelines. WHO*

World Health Organization. (2023). *WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain.*

Wound, Ostomy and Continence Nurses Society. (2020). *Guideline for management of wounds.* WOCN Society.

Wound, Ostomy and Continence Nurses Society. (2021). *Wound care evidence-based practice guideline.* WOCN Society.

## **G. Glosarium**

---

Asuhan Keperawatan = Pelayanan keperawatan yang diberikan secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan pasien.

Balutan Luka Modern= Balutan berbasis teknologi yang menjaga kelembapan luka dan mendukung penyembuhan.

Evidence-Based Nursing= Praktik keperawatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik.

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) =Pendekatan perawatan pasca operasi untuk mempercepat pemulihan pasien.

Flebitis=Peradangan vena sebagai komplikasi pemasangan infus.

Infeksi Aliran Darah=Infeksi sistemik akibat masuknya mikroorganisme ke dalam darah.

Keperawatan Medikal Bedah=Bidang keperawatan yang menangani pasien dewasa dengan berbagai kondisi medis dan bedah.

Manajemen Infus=Proses pemasangan dan pemantauan terapi cairan intravena secara aman.

Mobilisasi Dini=Upaya menggerakkan pasien sedini mungkin setelah operasi.

Moist Wound Healing=Perawatan luka dengan menjaga lingkungan luka tetap lembap.

Perawatan Luka=Tindakan keperawatan untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah komplikasi.

Perawatan Pasca Operasi=Asuhan keperawatan setelah pembedahan untuk mencegah komplikasi dan mempercepat pemulihan.

Teknik Aseptik=Tindakan pencegahan kontaminasi mikroorganisme dalam prosedur keperawatan.

CPD=Continuing Professional Development (Pengembangan Profesional Berkelanjutan)

ERAS=Enhanced Recovery After Surgery (Pendekatan Pemulihan Pasca Operasi Berbasis Bukti)

EWS=Early Warning Score (Sistem Peringatan Dini Kondisi Klinis Pasien)



ILO=Infeksi Luka Operasi  
INS=Infusion Nurses Society  
IV=Intravena  
MBK=Medikal Bedah Keperawatan  
PACU=Post Anesthesia Care Unit (Ruang Pemulihan Pasca Anestesi)  
SDKI=Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia  
SIKI=Standar Intervensi Keperawatan Indonesia  
SLKI=Standar Luaran Keperawatan Indonesia  
S1=Strata Satu  
TTD=Tablet Tambah Darah  
WHO=World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia)  
WOCN=Wound, Ostomy and Continence Nurses Society

# CHAPTER 2

## **PRAKTIK KEPERAWATAN MATERNITAS: ANC, MANAJEMEN PERSALINAN, DAN DUKUNGAN LAKTASI BERBASIS BUKTI**

Sri Martini, S.Kep., Ns., M.Kep.

### **A. Pendahuluan**

---

Perspektif keperawatan maternitas mencakup pendekatan holistik, pencegahan dan promosi kesehatan, praktik berbasis bukti, perawatan yang berpusat pada individu dan keluarga, serta kolaborasi interdisipliner.

Pendekatan holistik dalam menjaga kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan hingga persalinan dan masa laktasi adalah aspek yang sangat penting. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah aspek fisik, yang mencakup standar antenatal berupa pemantauan kesehatan ibu dan janin. Nutrisi dan gizi seimbang berperan krusial dalam menyediakan asupan yang tepat bagi pertumbuhan janin dan kesehatan ibu. Dukungan emosional dan kesehatan mental menjadi bagian integral, membantu ibu hamil mengatasi kecemasan dan stres, yang berdampak positif pada kesejahteraan psikologis dan kesehatan janin. Peran keluarga tidak kalah pentingnya, terutama dalam memberikan dorongan moral, membantu kegiatan sehari-hari, dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi ibu.

Praktik Keperawatan Maternitas adalah pelayanan profesional untuk wanita usia subur, ibu hamil, melahirkan, pascapersalinan, dan bayi baru lahir, berfokus pada peningkatan kesehatan reproduksi dari aspek bio-psiko-sosial-kultural-spiritual melalui asuhan sistematis (pengkajian, diagnosis, rencana, implementasi, evaluasi) dengan melibatkan keluarga dan kolaborasi multidisiplin, serta mencakup edukasi, promosi kesehatan, penanganan normal dan patologis, serta adaptasi masa reproduksi.

Keperawatan maternitas merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan wanita sepanjang siklus kehidupan, serta subsistem dari pelayanan kesehatan di mana perawat berkolaborasi dengan keluarga dan lainnya untuk membantu beradaptasi pada masa prenatal, intranatal, dan postnatal/postpartum (Pratiwi and Nawangsari, 2020).

## **B. Praktik Keperawatan Maternitas Dalam Ante Natal Care (ANC)**

---

Praktik keperawatan maternitas dalam Ante Natal Care (ANC) merupakan bentuk pelayanan keperawatan profesional yang diberikan kepada ibu hamil dengan tujuan menjaga kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan. ANC tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan rutin, tetapi merupakan upaya komprehensif yang meliputi promotif, preventif, kuratif, edukatif, serta rehabilitatif dalam lingkup kesehatan ibu. Kehamilan pada dasarnya merupakan proses fisiologis, tetapi perubahan anatomi dan fisiologi yang kompleks dapat menimbulkan risiko apabila tidak dipantau secara teratur. Oleh karena itu, ANC menjadi bagian penting dalam sistem pelayanan kesehatan ibu, dan perawat maternitas memiliki peran utama dalam pemantauan kondisi ibu, deteksi dini komplikasi, serta pemberian asuhan yang menyeluruh dan berkesinambungan. (Yulistanti dkk., 2023)

Pelaksanaan ANC dalam praktik keperawatan menggunakan pendekatan proses keperawatan yang sistematis. Tahapan pertama adalah pengkajian, yaitu pengumpulan data secara komprehensif mengenai kondisi ibu hamil. Pengkajian mencakup riwayat kesehatan umum, riwayat obstetri (gravida, para, abortus), riwayat penyakit kronis, riwayat kehamilan sebelumnya, pola nutrisi, pola istirahat, aktivitas sehari-hari, serta kondisi psikologis dan dukungan keluarga. Perubahan fisiologis kehamilan seperti peningkatan volume darah, perubahan sistem kardiovaskular, respirasi, pencernaan, muskuloskeletal, dan endokrin harus dipahami perawat agar dapat membedakan kondisi normal dan patologis. Pendekatan bio-psiko-sosial-spiritual menjadi dasar karena kehamilan memengaruhi seluruh aspek kehidupan ibu. (Yulistanti dkk., 2023)

Setelah pengkajian, perawat menetapkan diagnosis keperawatan. Diagnosis ini merupakan respons ibu terhadap kondisi kehamilan, bukan diagnosis medis. Contohnya meliputi ketidaknyamanan berhubungan dengan perubahan fisiologis kehamilan, risiko ketidakseimbangan nutrisi, gangguan pola tidur, kecemasan menghadapi persalinan, kurang pengetahuan tentang kehamilan, serta risiko infeksi. Diagnosis yang tepat menjadi dasar dalam perencanaan intervensi. Kemampuan analisis perawat sangat menentukan keberhasilan asuhan karena setiap ibu hamil memiliki kebutuhan yang berbeda. (Yulistanti dkk., 2023)

Tujuan utama ANC: dalam praktik keperawatan maternitas adalah menjamin ibu menjalani kehamilan dengan aman, memantau pertumbuhan dan kesejahteraan janin, serta mempersiapkan ibu menghadapi persalinan, masa nifas, dan perawatan bayi baru lahir. Selain itu, ANC bertujuan menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi melalui deteksi dini komplikasi seperti anemia, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, dan gangguan pertumbuhan janin.

Penelitian menunjukkan bahwa ibu dengan kunjungan ANC yang tidak adekuat memiliki risiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), sehingga keteraturan dan kualitas ANC sangat memengaruhi hasil kehamilan. (Ruindungan dkk., 2017)

Salah satu komponen penting dalam praktik keperawatan ANC adalah pemeriksaan fisik ibu hamil. Pemeriksaan ini meliputi pengukuran tekanan darah untuk mendeteksi hipertensi atau preeklamsia, penimbangan berat badan untuk menilai status gizi dan penambahan berat badan selama kehamilan, serta pengukuran tanda vital lainnya. Pemeriksaan abdomen dilakukan untuk mengukur tinggi fundus uteri (TFU) yang menggambarkan pertumbuhan janin dan usia kehamilan. Teknik palpasi Leopold digunakan untuk menentukan letak, posisi, dan presentasi janin. Hasil pemeriksaan ini membantu mendeteksi kelainan seperti pertumbuhan janin terhambat atau malpresentasi. (Yulistanti dkk., 2023)

Selain abdomen, perawat juga melakukan “pemeriksaan payudara” guna menilai kesiapan laktasi, seperti kondisi puting dan jaringan payudara. Pemeriksaan ekstremitas penting untuk mendeteksi edema yang dapat menjadi tanda gangguan hipertensi dalam kehamilan. Pemeriksaan kulit mengidentifikasi perubahan fisiologis seperti linea nigra dan striae gravidarum. Semua temuan dicatat sebagai bagian dari pemantauan kondisi ibu secara menyeluruh. (Yulistanti dkk., 2023)

Pemeriksaan penunjang merupakan bagian integral dalam ANC. Pemeriksaan hemoglobin bertujuan mendeteksi anemia, kondisi yang sering dialami ibu hamil akibat peningkatan kebutuhan zat besi. Anemia dapat menyebabkan komplikasi seperti kelelahan, infeksi, persalinan prematur, hingga BBLR. Pemeriksaan urin dilakukan untuk mendeteksi proteinuria yang dapat menjadi tanda preeklamsia serta infeksi saluran kemih. Pemeriksaan golongan darah dan Rhesus penting untukantisipasi inkompatibilitas rhesus. Skrining infeksi tertentu membantu mencegah dampak buruk pada ibu dan janin. (Yulistanti dkk., 2023)

Intervensi keperawatan dalam ANC meliputi pemberian suplementasi zat besi dan asam folat. Zat besi diperlukan untuk pembentukan hemoglobin, sedangkan asam folat penting dalam pembentukan sel dan pencegahan cacat tabung saraf janin. Kekurangan zat gizi mikro selama kehamilan dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan ibu dan bayi. Oleh karena itu, perawat berperan dalam memastikan kepatuhan ibu mengonsumsi suplemen sesuai anjuran. (Yulistanti dkk., 2023)

Aspek edukasi Kesehatan merupakan pilar penting praktik ANC. Perawat memberikan penyuluhan tentang nutrisi seimbang, kebutuhan kalori dan protein selama kehamilan, pentingnya cairan, serta pembatasan zat berbahaya. Edukasi

juga mencakup kebersihan diri, aktivitas fisik yang aman, serta istirahat yang cukup. Selain itu, ibu diajarkan mengenali tanda bahaya kehamilan seperti perdarahan, nyeri kepala hebat, bengkak berlebihan, demam, dan penurunan gerakan janin. Pengetahuan yang baik mendorong ibu lebih patuh melakukan kunjungan ANC. (Yulianti dkk., 2021)

Perawat juga memberikan dukungan psikologis. Kehamilan sering memunculkan kecemasan, terutama pada ibu yang baru pertama kali hamil. Perubahan bentuk tubuh, ketakutan terhadap persalinan, serta tanggung jawab sebagai orang tua dapat menimbulkan stres. Perawat membantu ibu memahami perubahan yang terjadi dan membangun kesiapan mental. Dukungan emosional ini penting untuk kesejahteraan ibu dan janin. (Yulistanti dkk., 2023)

Faktor aksesibilitas layanan Kesehatan sangat memengaruhi praktik ANC. Jarak ke fasilitas kesehatan, ketersediaan transportasi, biaya, dan kualitas pelayanan menentukan kepatuhan ibu dalam melakukan kunjungan. Ibu dengan akses yang mudah cenderung memiliki praktik ANC yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kesehatan harus memastikan layanan ANC tersedia dan terjangkau. (Yulianti dkk., 2021)

Dalam kondisi tertentu, diperlukan kolaborasi dan rujukan. Bila ditemukan tanda risiko tinggi seperti tekanan darah tinggi, anemia berat, atau gangguan pertumbuhan janin, perawat harus segera merujuk ibu ke fasilitas yang lebih lengkap. Tindakan kolaboratif ini mencegah komplikasi lebih lanjut dan meningkatkan keselamatan ibu serta bayi. (Yulistanti dkk., 2023)

Tahap akhir adalah evaluasi, yaitu menilai respons ibu terhadap intervensi yang telah diberikan. Perawat memantau perkembangan kondisi ibu dan janin pada setiap kunjungan. Evaluasi membantu menyesuaikan rencana asuhan sesuai kebutuhan ibu sehingga pelayanan tetap efektif dan berkesinambungan. (Yulistanti dkk., 2023)

Secara keseluruhan, praktik keperawatan maternitas dalam ANC merupakan pelayanan komprehensif yang meliputi pemantauan klinis, pemeriksaan penunjang, edukasi, dukungan psikologis, serta sistem rujukan. Pelayanan yang berkualitas berkontribusi besar terhadap kesehatan ibu dan bayi, menurunkan risiko komplikasi, serta meningkatkan kualitas generasi mendatang. (Yulistanti dkk., 2023; Ruindungan dkk., 2017; Yulianti dkk., 2021)

# Praktik Keperawatan Maternitas dalam Antenatal Care (ANC)

IBU HAMIL DATANG KE FASILITAS KESEHATAN

## PENGAJIAN (ASSESMENT)

- Identitas ibu
- Riwayat kehamilan sekarang & sebelumnya
- Riwayat kesehatan & obstetri
- Keluhan utama
- Pemeriksaan fisik (umum & obstetri)
- Pemeriksaan penunjang (Hb, urin, dll)

## DIAGNOSA KEPERAWATAN

- Risiko komplikasi kehamilan
- Ketidaknyamanan kehamilan
- Kurang pengetahuan tentang kehamilan
- Risiko anemia, preeklamsia, infeksi

## PERENCANAAN (PLANNING)

- Menentukan tujuan asuhan
- Menyusun intervensi keperawatan
- Menetapkan prioritas masalah
- Kolaborasi dengan bidan/dokter

## IMPLEMENTASI (TINDAKAN)

- Pemeriksaan kehamilan rutin (ANC)
- Edukasi kesehatan ibu hamil
- Pemberian konseling nutrisi & istirahat
- Deteksi dini tanda bahaya kehamilan
- Dukungan psikologis & emosional
- Rujukan bila ditemukan komplikasi

## EVALUASI

- Menilai respon ibu terhadap asuhan
- Menilai pencapaian tujuan
- Revisi rencana asuhan bila perlu

## DOKUMENTASI

- Catatan asuhan keperawatan
- Buku KIA / rekam medis
- Pelaporan hasil ANC



Gambar 2.1: Praktik keperawatan Maternitas dalam Antenatal Care

### **C. Praktik Keperawatan Maternitas Dalam Manajemen Persalinan**

---

Praktik keperawatan maternitas dalam manajemen persalinan merupakan bentuk pelayanan profesional yang diberikan kepada ibu selama proses kelahiran dengan tujuan utama menjamin keselamatan ibu dan janin. Persalinan adalah proses fisiologis, namun dalam pelaksanaannya dapat berkembang menjadi kondisi patologis apabila tidak dipantau secara tepat. Oleh karena itu, perawat maternitas memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pengkajian menyeluruh, pemantauan berkesinambungan, serta intervensi yang cepat dan tepat sesuai perkembangan kondisi ibu. Pendekatan asuhan bersifat komprehensif, mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, sehingga ibu merasa aman dan didukung selama proses persalinan berlangsung (Putri, 2025; Keperawatan Maternitas Vol.2, 2017).

Manajemen persalinan dalam keperawatan maternitas dilakukan berdasarkan tahapan atau kala persalinan. Kala I dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus yang efektif hingga pembukaan serviks lengkap. Kala ini terbagi menjadi fase laten dan fase aktif, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam intensitas nyeri dan kemajuan pembukaan. Kala II berlangsung sejak pembukaan lengkap hingga bayi lahir, yang merupakan fase paling membutuhkan energi ibu. Kala III adalah tahap pengeluaran plasenta, sedangkan kala IV merupakan masa observasi ketat dua jam pertama postpartum yang berisiko tinggi terhadap perdarahan. Pemahaman perawat mengenai pembagian kala ini sangat penting agar asuhan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan ibu pada setiap tahap persalinan (Panduan Praktikum Keperawatan Maternitas, n.d.; Wawasan Ilmu, n.d.).

Pengkajian merupakan langkah awal dalam praktik keperawatan maternitas pada ibu bersalin. Perawat harus mengumpulkan data subjektif dan objektif secara sistematis, meliputi riwayat kehamilan, usia gestasi, frekuensi dan durasi kontraksi, intensitas nyeri, serta kondisi psikologis ibu. Selain itu, pemantauan tanda vital seperti tekanan darah, nadi, suhu, dan respirasi menjadi indikator penting untuk menilai kondisi umum ibu. Pemeriksaan obstetri seperti tinggi fundus uteri, hasil manuver Leopold, pembukaan serviks, penurunan kepala janin, serta kondisi ketuban juga harus dilakukan secara berkala. Data yang lengkap akan membantu perawat menentukan apakah persalinan berjalan normal atau menunjukkan tanda penyimpangan (Keperawatan Maternitas Vol.2, 2017; Putri, 2025).

Kesejahteraan janin menjadi fokus utama selama persalinan. Pemantauan denyut jantung janin (DJJ) secara teratur diperlukan untuk mendeteksi dini adanya gawat janin. Nilai DJJ normal berkisar antara 120–160 kali per menit, dan perubahan di luar rentang tersebut dapat menandakan hipoksia. Warna air ketuban juga memberikan informasi penting; ketuban berwarna hijau kental dapat



mengindikasikan adanya mekonium akibat stres janin. Perawat berperan dalam mengenali perubahan ini lebih awal sehingga tindakan kolaboratif dapat segera dilakukan untuk mencegah komplikasi yang lebih berat (Putri, 2025; Wawasan Ilmu, n.d.).

Selama kala I persalinan, perawat memberikan asuhan yang berfokus pada pemantauan kemajuan persalinan dan pengurangan ketidaknyamanan ibu. Penggunaan partograf menjadi alat bantu penting dalam mendokumentasikan pembukaan serviks, frekuensi kontraksi, serta kondisi ibu dan janin secara terstruktur. Selain pemantauan, perawat juga membantu ibu dalam mengelola nyeri melalui teknik pernapasan, relaksasi, perubahan posisi, serta mobilisasi bila tidak ada kontraindikasi. Dukungan emosional yang diberikan secara terus-menerus terbukti membantu ibu merasa lebih tenang dan meningkatkan kerja sama selama proses persalinan (Panduan Praktikum Keperawatan Maternitas, n.d.; Keperawatan Maternitas Vol.2, 2017).

Nyeri persalinan merupakan pengalaman fisiologis yang intens, namun persepsinya dipengaruhi oleh faktor psikologis dan dukungan lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan nonfarmakologis menjadi bagian penting dalam praktik keperawatan maternitas. Teknik seperti pernapasan ritmis, pijat punggung bawah, kompres hangat, serta terapi distraksi dapat membantu menurunkan persepsi nyeri. Kehadiran pendamping persalinan juga memberikan dampak positif terhadap kondisi emosional ibu. Jika nyeri tidak tertahankan, perawat berkolaborasi dengan tim medis dalam pemberian analgesik atau anestesi sesuai indikasi (Putri, 2025; Keperawatan Maternitas Vol.2, 2017).

Memasuki kala II, fokus asuhan beralih pada proses pengeluaran janin. Perawat membimbing ibu melakukan teknik meneran yang efektif saat kontraksi datang dan mengajarkan waktu istirahat di antara kontraksi. Pemantauan DJJ dilakukan lebih sering karena risiko hipoksia janin meningkat pada tahap ini. Selain itu, perawat menyiapkan alat persalinan, menjaga lingkungan tetap bersih dan aman, serta memberikan dukungan verbal yang meningkatkan kepercayaan diri ibu. Tindakan kolaboratif seperti episiotomi dilakukan hanya bila ada indikasi medis tertentu (Panduan Praktikum Keperawatan Maternitas, n.d.; Wawasan Ilmu, n.d.).

Pada kala III, perhatian utama perawat adalah mencegah perdarahan postpartum melalui manajemen aktif kala III. Perawat mengamati tanda-tanda pelepasan plasenta seperti perubahan bentuk uterus, pemanjangan tali pusat, dan semburan darah mendadak. Kolaborasi dalam pemberian uterotonika membantu uterus berkontraksi dengan baik sehingga mengurangi risiko atonia uteri. Setelah plasenta lahir, kelengkapan plasenta harus diperiksa dengan teliti untuk



memastikan tidak ada bagian yang tertinggal di dalam rahim (Putri, 2025; Wawasan Ilmu, n.d.).

Kala IV merupakan fase observasi kritis karena sebagian besar kasus perdarahan postpartum terjadi dalam dua jam pertama setelah persalinan. Perawat memantau kontraksi uterus, tinggi fundus uteri, jumlah dan warna lochea, serta kondisi umum ibu secara berkala. Uterus yang lembek menandakan atonia dan memerlukan tindakan segera. Selain itu, perawat juga membantu ibu memulai inisiasi menyusui dini yang bermanfaat merangsang pelepasan oksitosin alami sehingga membantu kontraksi uterus dan mengurangi perdarahan (Keperawatan Maternitas Vol.2, 2017; Panduan Praktikum Keperawatan Maternitas, n.d.).

Pencegahan infeksi menjadi aspek penting dalam praktik keperawatan selama persalinan. Perawat wajib menerapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi seperti cuci tangan, penggunaan sarung tangan steril, teknik aseptik saat pemeriksaan dalam, serta pengelolaan alat medis yang benar. Lingkungan persalinan yang bersih dan prosedur yang sesuai standar akan menurunkan risiko infeksi pada ibu maupun bayi baru lahir. Kepatuhan terhadap prosedur ini merupakan bagian dari tanggung jawab profesional perawat (Keperawatan Maternitas Vol.2, 2017; Wawasan Ilmu, n.d.).

Deteksi dini komplikasi merupakan kompetensi krusial dalam manajemen persalinan. Tanda bahaya seperti perdarahan berlebihan, tekanan darah meningkat, demam, persalinan tidak maju, atau DJJ tidak normal harus segera dikenali. Perawat memiliki peran penting dalam melakukan tindakan awal serta melaporkan kondisi tersebut untuk mendapatkan penanganan kolaboratif. Kecepatan dan ketepatan respons dapat mencegah perburukan kondisi yang mengancam nyawa ibu dan janin (Putri, 2025; Wawasan Ilmu, n.d.).

Selain aspek klinis, perawat maternitas juga berperan dalam memberikan dukungan psikologis dan menghormati nilai budaya ibu. Setiap ibu memiliki pengalaman, keyakinan, dan harapan yang berbeda terhadap proses persalinan. Perawat perlu memberikan asuhan yang menghargai privasi, menjaga martabat ibu, serta memastikan adanya persetujuan tindakan medis. Pendekatan yang empatik dan sensitif budaya akan meningkatkan rasa nyaman dan kepuasan ibu terhadap pelayanan yang diterima (Wawasan Ilmu, n.d.; Putri, 2025).

Setelah bayi lahir, perawat melakukan penilaian awal kondisi bayi melalui skor APGAR dan memastikan bayi tetap hangat serta bernapas spontan. Kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi dianjurkan untuk mempererat bonding serta mendukung keberhasilan menyusui dini. Peran perawat dalam fase ini tidak hanya berfokus pada bayi, tetapi juga memastikan kondisi ibu stabil dan tidak mengalami komplikasi awal nifas (Putri, 2025; Keperawatan Maternitas Vol.2, 2017).

Dokumentasi menjadi bagian tak terpisahkan dari praktik keperawatan maternitas. Semua hasil pengkajian, tindakan, respons ibu, serta kondisi bayi harus dicatat secara lengkap dan sistematis. Dokumentasi berfungsi sebagai alat komunikasi antar tenaga kesehatan, bahan evaluasi mutu pelayanan, serta bukti legal apabila diperlukan. Catatan yang akurat mencerminkan profesionalisme perawat dalam memberikan asuhan persalinan (Keperawatan Maternitas Vol.2, 2017; Panduan Praktikum Keperawatan Maternitas, n.d.).

Secara keseluruhan, praktik keperawatan maternitas dalam manajemen persalinan menuntut kompetensi klinis, ketelitian observasi, keterampilan komunikasi, serta kemampuan kolaborasi yang baik. Perawat tidak hanya bertugas membantu proses kelahiran, tetapi juga menjaga keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan ibu serta bayi secara menyeluruh. Dengan asuhan yang tepat, persalinan dapat berlangsung aman dan memberikan pengalaman positif bagi ibu dan keluarganya (Putri, 2025; Keperawatan Maternitas Vol.2, 2017).

#### **D. Praktik Maternitas Keperawatan Dalam Bentuk Dukungan Laktasi Berbasis Laktasi**

---

Manajemen laktasi merupakan bagian integral dari asuhan keperawatan maternitas yang bertujuan membantu ibu dalam mempersiapkan, memulai, dan mempertahankan proses menyusui secara optimal melalui pendekatan sistematis dan berbasis bukti ilmiah. Konsep ini tidak hanya menitikberatkan pada proses fisiologis produksi ASI, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, edukatif, serta dukungan lingkungan yang memengaruhi keberhasilan menyusui. Manajemen laktasi dipandang sebagai intervensi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam rangka meningkatkan cakupan ASI eksklusif dan mendukung tumbuh kembang bayi secara optimal (Rahmawati & Prayogi, 2021).

Secara fisiologis, laktasi terdiri atas tiga tahap utama, yaitu laktogenesis I, laktogenesis II, dan galaktopoiesis. Laktogenesis I terjadi pada masa kehamilan ketika payudara mulai memproduksi kolostrum akibat pengaruh hormon estrogen, progesteron, dan prolaktin. Laktogenesis II terjadi setelah persalinan, ditandai dengan penurunan kadar progesteron dan peningkatan aktivitas prolaktin sehingga produksi ASI meningkat secara signifikan. Galaktopoiesis merupakan fase pemeliharaan produksi ASI yang sangat dipengaruhi oleh frekuensi dan efektivitas pengosongan payudara. Prinsip supply and demand menjadi dasar bahwa semakin sering ASI dikeluarkan, maka produksi akan semakin meningkat (Rahmawati & Prayogi, 2021).

Refleks neurohormonal dalam laktasi melibatkan kerja sama antara sistem saraf dan endokrin. Isapan bayi merangsang ujung saraf pada puting, mengirim

impuls ke hipotalamus yang kemudian merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan prolaktin dan hipofisis posterior untuk melepaskan oksitosin. Prolaktin berperan dalam produksi ASI, sedangkan oksitosin memicu kontraksi sel mioepitel sehingga ASI terdorong keluar. Faktor emosional seperti stres dan kecemasan dapat menghambat pelepasan oksitosin, sehingga kondisi psikologis ibu menjadi aspek penting dalam manajemen laktasi (Rahmawati & Prayogi, 2021).

Pendekatan *evidence-based practice* dalam manajemen laktasi mengintegrasikan bukti penelitian terbaik, keahlian klinis perawat, dan preferensi ibu sebagai penerima asuhan. Pendekatan ini memastikan bahwa intervensi yang diberikan tidak hanya berdasarkan kebiasaan atau pengalaman semata, tetapi didukung oleh data ilmiah yang valid. Implementasi praktik berbasis bukti terbukti meningkatkan efektivitas asuhan, menurunkan angka kegagalan menyusui, dan mencegah komplikasi (Rahmawati & Prayogi, 2021).

Manajemen laktasi dimulai sejak masa antenatal melalui edukasi komprehensif kepada ibu dan keluarga. Materi edukasi meliputi manfaat ASI bagi ibu dan bayi, teknik menyusui yang benar, pentingnya IMD, tanda kecukupan ASI, serta cara mengatasi masalah umum dalam menyusui. Edukasi antenatal membantu membentuk kesiapan mental ibu dan meningkatkan motivasi untuk memberikan ASI eksklusif. Selain itu, skrining kondisi payudara seperti puting datar atau terbenam memungkinkan intervensi dini sebelum persalinan (Rahmawati & Prayogi, 2021).

Pada masa persalinan dan postpartum awal, inisiasi menyusui dini (IMD) menjadi intervensi prioritas. Kontak kulit ke kulit selama minimal satu jam pertama kehidupan bayi merangsang refleks menyusui alami, meningkatkan stabilitas suhu dan pernapasan bayi, serta mempercepat pengeluaran kolostrum. Kolostrum kaya akan imunoglobulin A (IgA), leukosit, dan faktor pertumbuhan yang penting untuk sistem imun dan maturasi saluran cerna bayi. IMD juga meningkatkan pelepasan oksitosin yang membantu involusi uterus dan mengurangi risiko perdarahan postpartum (Rahmawati & Prayogi, 2021).

Pengkajian keperawatan dalam manajemen laktasi mencakup aspek biofisik, psikologis, dan sosial. Pengkajian biofisik meliputi kondisi payudara, bentuk puting, adanya bendungan atau tanda infeksi, serta produksi ASI. Pengkajian psikologis mencakup tingkat kecemasan, kepercayaan diri, dan motivasi ibu. Faktor sosial seperti dukungan keluarga, budaya, dan kondisi ekonomi juga memengaruhi praktik menyusui. Pada bayi, pengkajian meliputi refleks rooting dan sucking, pola menyusui, frekuensi BAK/BAB, serta kenaikan berat badan (Rahmawati & Prayogi, 2021).

Diagnosa keperawatan yang umum ditemukan meliputi ketidakefektifan menyusui, kurangnya pengetahuan ibu tentang teknik menyusui, gangguan integritas kulit pada puting, nyeri akut terkait bendungan ASI, serta risiko ketidakseimbangan nutrisi pada bayi. Penetapan diagnosis dilakukan berdasarkan data objektif dan subjektif yang diperoleh selama pengkajian. Diagnosa ini menjadi dasar dalam menyusun rencana asuhan yang terarah dan individual (Rahmawati & Prayogi, 2021).

Intervensi keperawatan difokuskan pada edukasi teknik pelekatan yang benar (latch on), posisi menyusui yang ergonomis, dan frekuensi menyusui on demand. Pelekatan yang tepat ditandai dengan mulut bayi membuka lebar, sebagian besar areola masuk ke dalam mulut, dan tidak ada rasa nyeri pada ibu. Posisi yang tepat membantu mencegah trauma puting dan memastikan pengosongan payudara optimal sehingga produksi ASI terjaga (Rahmawati & Prayogi, 2021).

Perawatan payudara juga menjadi komponen penting dalam manajemen laktasi. Pijat oksitosin, kompres hangat sebelum menyusui, dan kompres dingin setelah menyusui merupakan intervensi berbasis bukti yang membantu memperlancar aliran ASI dan mengurangi pembengkakan. Kebersihan payudara harus dijaga tanpa penggunaan sabun berlebihan yang dapat menyebabkan kekeringan pada puting (Rahmawati & Prayogi, 2021).

Masalah laktasi seperti bendungan ASI terjadi akibat pengosongan yang tidak adekuat, ditandai dengan payudara terasa keras, nyeri, dan bengkak. Mastitis merupakan inflamasi payudara yang dapat disertai demam dan gejala sistemik. Penatalaksanaan meliputi peningkatan frekuensi menyusui, pengosongan payudara secara efektif, istirahat cukup, hidrasi adekuat, serta pemberian antibiotik sesuai indikasi medis. Edukasi pencegahan sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut seperti abses payudara (Rahmawati & Prayogi, 2021).

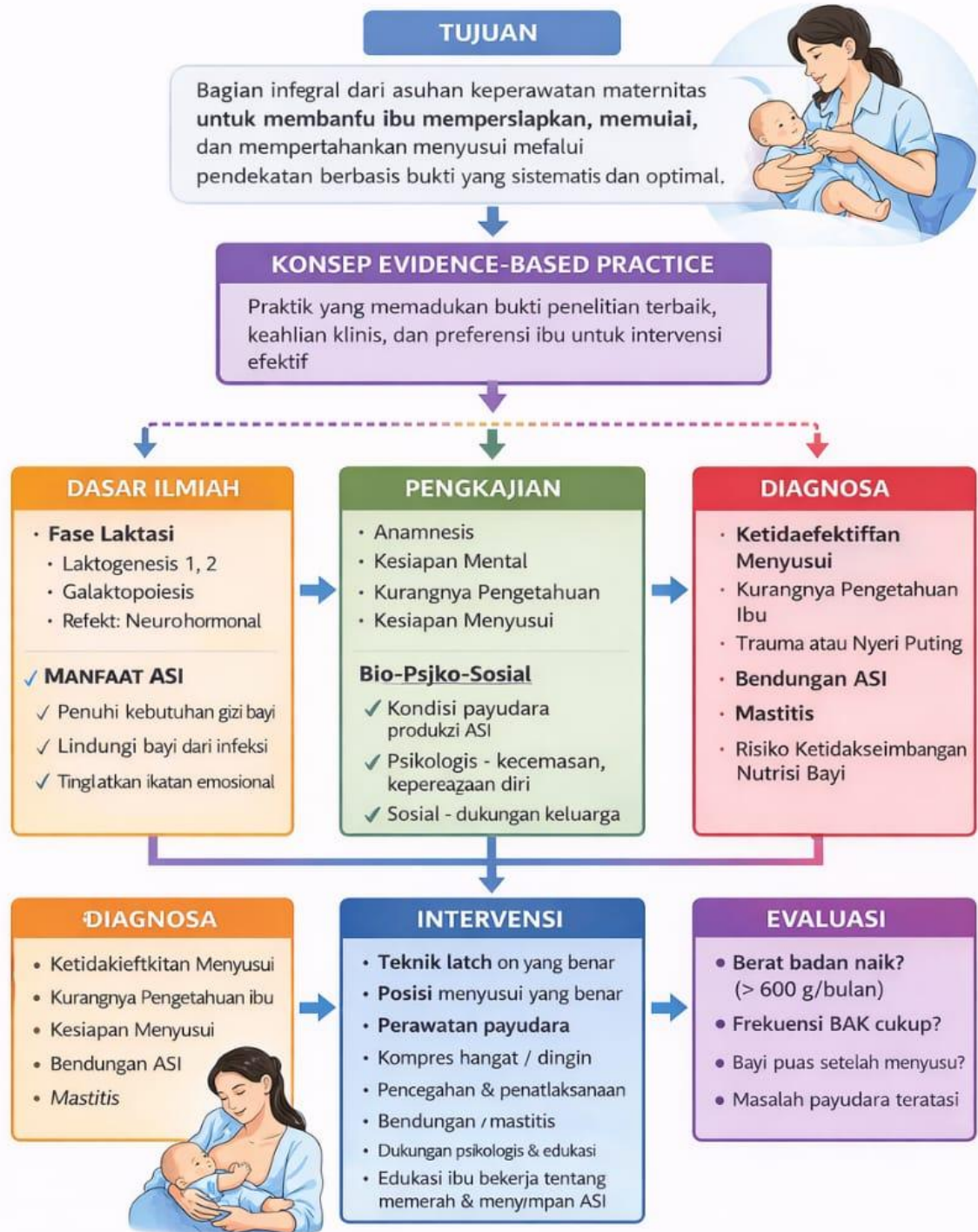
Faktor psikologis memainkan peran besar dalam keberhasilan menyusui. Stres dan kelelahan dapat menghambat refleks oksitosin sehingga ASI sulit keluar meskipun produksi mencukupi. Perawat perlu memberikan dukungan emosional melalui komunikasi terapeutik, konseling, serta melibatkan suami dan keluarga dalam proses menyusui. Dukungan sosial yang kuat meningkatkan rasa percaya diri ibu dan memperpanjang durasi menyusui (Rahmawati & Prayogi, 2021).

Manajemen laktasi pada ibu bekerja memerlukan edukasi khusus mengenai teknik pemerahan ASI, penyimpanan yang aman, dan transportasi ASI perah. ASI dapat disimpan pada suhu ruang, lemari pendingin, atau freezer sesuai durasi tertentu dengan tetap menjaga kebersihan wadah. Edukasi ini memungkinkan ibu tetap memberikan ASI eksklusif meskipun kembali bekerja, sehingga kontinuitas nutrisi bayi tetap terjamin (Rahmawati & Prayogi, 2021).

Evaluasi asuhan keperawatan dilakukan secara berkelanjutan dengan menilai indikator keberhasilan seperti kenaikan berat badan bayi sesuai grafik pertumbuhan, frekuensi BAK minimal 6–8 kali per hari, bayi tampak puas setelah menyusui, serta tidak adanya komplikasi pada payudara. Evaluasi juga mencakup tingkat kenyamanan dan kepuasan ibu terhadap proses menyusui. Jika ditemukan hambatan, rencana asuhan dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan (Rahmawati & Prayogi, 2021).

Secara keseluruhan, asuhan keperawatan manajemen laktasi berbasis bukti merupakan pendekatan komprehensif yang mendukung kesehatan ibu dan bayi secara berkelanjutan. Perawat berperan sebagai edukator, konselor, advokat, dan fasilitator dalam memastikan ibu memperoleh dukungan optimal. Implementasi manajemen laktasi yang sistematis dan berbasis bukti berkontribusi terhadap peningkatan cakupan ASI eksklusif, penurunan angka morbiditas bayi, serta peningkatan kualitas hidup ibu dan keluarga (Rahmawati & Prayogi, 2021).

# ASUHAN KEPERAWATAN MANAJEMEN LAKTASI BERBASIS BUKTI



Sumber : Rahmawati. N. A., & Prayogi. N. B. (2021). Asuhan Keperawatan Manajemen Laktasi dengan Pendekatan Berbasis Bukti: Buku Ajar. Media Nusa Creative, dengan sumber dicantumkan pada setiap paragraf.

**Gambar 2.2: Asuhan Keperawatan Manajemen Laktasi Berbasis Bukti**

## E. Simpulan

---

Praktik keperawatan maternitas yang berbasis bukti (*Evidence-Based Practice/EBP*) pada Antenatal Care (ANC), manajemen persalinan, dan dukungan laktasi merupakan pendekatan krusial untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi. Kesimpulan utamanya adalah bahwa integrasi penelitian terbaik dengan keahlian klinis dan nilai-nilai pasien menghasilkan perawatan yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi.

Antenatal Care (ANC) Berbasis Bukti pada Asuhan Komprehensif ANC terstandar (seperti 10 T di Indonesia) dengan pendekatan *continuity of care* (asuhan berkesinambungan) terbukti efektif memantau kondisi ibu dan janin, mendeteksi risiko tinggi, dan mencegah komplikasi kehamilan. Edukasi & Intervensi: Edukasi berbasis bukti mengenai perawatan mandiri, nutrisi, dan persiapan persalinan meningkatkan kesiapan ibu dan menurunkan angka komplikasi.

Manajemen Persalinan Berbasis Bukti (Intranatal Care) ada Asuhan Sayang Ibu: Praktik berbasis bukti mendorong persalinan yang minim intervensi yang tidak perlu. Ini mencakup penggunaan partograf untuk memantau kemajuan persalinan, pendampingan persalinan, kebebasan posisi, dan manajemen nyeri non-farmakologis. Manajemen Aktif Kala III: Penggunaan AMTSL (Active Management of Third Stage of Labor) terbukti signifikan dalam mengurangi risiko perdarahan postpartum. Asuhan Bayi Baru Lahir: Penerapan *Delayed Cord Clamping* (penundaan pemotongan tali pusat) dan inisiasi *skin-to-skin contact* (kontak kulit ke kulit) segera setelah lahir direkomendasikan untuk meningkatkan kesehatan neonatal.

Dukungan Laktasi Berbasis Bukti ada Inisiasi Menyusu Dini (IMD): Konseling laktasi dini yang terstruktur dan IMD terbukti meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif secara signifikan. Asuhan Nifas & Laktasi: Perawatan nifas yang mencakup perawatan payudara dan edukasi manajemen laktasi secara berkesinambungan memastikan ibu dapat memberikan ASI eksklusif dan mengurangi risiko komplikasi nifas.

Praktik berbasis bukti (*EBP*) dalam keperawatan maternitas, yang mencakup pendampingan intensif dari ANC hingga nifas, secara signifikan meningkatkan kepuasan pasien, meningkatkan kesehatan fisik ibu dan bayi, serta menurunkan intervensi medis yang tidak perlu. Tantangan utamanya adalah konsistensi penerapan standar, pelatihan tenaga kesehatan, dan ketersediaan sarana.

## F. Referensi

---

- ASUHAN KEPERAWATAN MATERNITAS: Gangguan dan Masalah Kesehatan pada Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas. (n.d.). (n.p.): wawasan Ilmu.
- Keperawatan Maternitas Vol.2. (2017). (n.p.): Prenada Media.
- PANDUAN PRAKTIKUM KEPERAWATAN MATERNITAS. (n.d.). (n.p.): Lembaga Chakra Brahmana Lentera.
- Putri, R. H. (2025). Penyulit Persalinan dalam Perspektif Keperawatan Maternitas. Penerbit NEM.
- Rahmawati, N. A., Kep, M., Prayogi, N. B., & Kep, M. (2021). Asuhan Keperawatan Manajemen Laktasi dengan Pendekatan Berbasis Bukti: Buku Ajar. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Ruindungan, R. Y., Kundre, R., & Masi, G. N. M. (2017). Hubungan Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja RSUD Tobelo.e-Journal Keperawatan (e-Kp), 5(1).
- Wati, D. C. A., & Nuzuliana, R. (2021). Manajemen laktasi ibu yang menyusui ASI eksklusif (Lactation management women who exclusively breastfeeding). *Midwifery and Reproduction Journal*, 5(1), 20–28.
- Yelmi, Siska Santya (2022). Asuhan Keperawatan Pada Ibu Post Partum Dengan Masalah Laktasi Di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kota Kota Padang: Karya Tulis Ilmiah.
- Yulianti, E., Syamsulhuda, B. M., & Indraswari, R. (2021). Pengaruh Aksesibilitas terhadap Praktik Antenatal Care pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Bulu Kabupaten Temanggung 2020. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 9(1). Universitas Diponegoro. Buat materi mengenai praktik Keperawatan Maternitas Dalam Ante Natal Care (ANC)
- Yulistanti, Y., dkk. (2023). Keperawatan Maternitas: Antenatal Care. Yayasan Kita Menulis.





# CHAPTER 3

## PRAKTIK KEPERAWATAN ANAK: PENDEKATAN FAMILY CENTERED CARE DAN MANAJEMEN NYERI PEDIATRIK

Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An.

### A. Pendahuluan

Praktik keperawatan anak di Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar dalam mengimplementasikan pendekatan holistik yang secara efektif mengintegrasikan keluarga sebagai mitra kolaboratif dan manajemen nyeri yang berbasis bukti (Lesttari, et al, 2023). Masalah utama berakar pada paradigma yang masih memandang anak sebagai objek pasif perawatan dan keluarha sebagai pengamat, bukan sebagai bagian dari tim asuhan. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya penanganan nyeri pada anak, terutama pada anak yang belum dapat berkomunikasi secara verbal dan kurangnya peran keluarga dalam proses pengambilan keputusan (Permatasari & Setyowati, 2024). Kendala ini diperparah oleh faktor sistemik seperti rasio perawat-anak yang tidak ideal, beban dokumentasi administratif yang tinggi, dan kurangnya panduan klinis standar yang secara eksplisit mengatur intrgrasi *family centered care* (FCC) dengan protokol manajemen nyeri pediatrik.

Data penelitian terkini menunjukkan secara jelas adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam penanganan nyeri dan keterlibatan keluarga. Sebuah survei di rumah sakit pendidikan di Indonesia mengungkapkan bahwa 65% perawat anak masih memiliki keterbatasan kompetensi dalam menilai dan menangani nyeri pada anak, terutama pada anak yang belum mampu berkomunikasi secara verbal (Lestari, et al 2023). Selain itu, tingkat kepuasan keluarga terhadap keterlibatan mereka dalam perawatan anak yang dirawat inap baru mencapai 58%, hal ini menunjukkan bahwa penerapan *family centered care* (FCC) belum optimal (Permatasari & Setyowati, 2024). Pada tingkat global, *The Lancet Child & Adolescent Health Commision* (2023) juga melaporkan bahwa lebih dari setengah anak yang dirawat di rumah sakit di negara berpenghasilan rendah dan menengah mengalami nyeri yang tidak tertangani dengan baik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang, seperti distress psikologis, munculnya ketakutan terhadap layanan kesehatan, serta perubahan sensitivitas nyeri pada masa yang akan datang.

Perkembangan konsep menuju praktik perawatan yang ideal telah mengalami perubahan yang cukup esar. Pada masa sebelumnya, perawatan anak masih berfokus pada tenaga kesehatan (*provide centered*), dimana hampir semua keputusan ditentukan oleh petugas kesehatan. Perubahan cara pandang mulai terjadi pada awal abad ke 21, yang dipengaruhi oleh meningkatnya perhatian terhadap hak-hak anak serta temuan ilmiah mengenai dampak buruk nyeri yang tidak ditangani. Salah satu tonggak penting adalah ketika *The Joint Commission* (2010) menetapkan penilaian dan manajemen nyeri sebagai bagian dari standar akreditasi rumah sakit. Di Indonesia, penerapan prinsip *family centered care* (FCC) berkembang sejalan dengan program nasional *Safe Motherhood and Newborn Care*, meskipun pelaksanaannya belum merata di semua fasilitas kesehatan. Pandemi COVID-19 menjadi momentum refleksi penting, karena pembatasan kunjungan keluarga justru menunjukkan pentingnya peran keluarga dalam mendukung kondisi emosional dan proses penyembuhan anak yang dirawat (Kurniawati & Nursalam, 2023). Guna menjawab tantangan tersebut, diperlukan solusi yang multidimensi dan sistemik.

## **B. *Family Centered Care* (FCC) dalam Keperawatan Anak**

---

FCC merupakan filosofi dan pendekatan dalam asuhan keperawatan yang mengakui keluarga sebagai mitra esensial dalam keperawatan anak, menghargai peran mereka sebagai sumber dukungan utama dan mengintegrasikan kebutuhan serta preferensi keluarga ke dalam perencanaan serta pelaksanaan asuhan kesehatan. (Kuo et al., 2019). FCC didasarkan pada prinsip bahwa kesejahteraan anak tidak terpisahkan dari sistem keluarga, sehingga kolaborasi antara profesional kesehatan dan keluarga menjadi kunci optimalisasi hasil kesehatan (Smith et al, 2022). Dalam konteks keperawatan anak, FCC bergeser dari model paternalistic ke model kemitraan yang memberdayakan keluarga

Menurut *Institute for Patient and Family Centered Care* (2020) dan Coyne et al (2023), prinsip-prinsip FCC meliputi:

1. Penghargaan dan dukungan terhadap peran keluarga: mengakui keahlian unik keluarga mengenai kondisi anak mereka
2. Kolaborasi: berbagi informasi terbuka dan melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan
3. Fleksibilitas: kebijakan dan layanan disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai setiap keluarga
4. Pemberdayaan (*empowerment*): meningkatkan kapasitas keluarga untuk merawat anak melalui edukasi dan dukungan emosional

5. Komunikasi yang edukatif dan penuh hormat: informasi diberikan secara jujur, lengkap, dan tidak bias

Penerapan FCC dalam praktik keperawatan anak meliputi berbagai strategi operasional:

1. Partisipasi dalam perawatan: mengikutsertakan orang tua dalam caregiving langsung (misalnya, pemberian obat, perawatan luka dengan pelatihan yang memadai (Harrison et al., 2023)
2. Fasilitas yang mendukung: desain ruang rawat yang memungkinkan *rooming-in*, akses 24 jam bagi orang tua dan ruang interaksi keluarga.
3. Perencanaan asuhan Bersama: perawat berfungsi sebagai fasilitator, membantu keluarga menetapkan tujuan perawatan yang realistis (Smith et al, 2022)
4. Dukungan psikososial: mengidentifikasi dan menanggapi stress keluarga, menghubungkan dengan kelompok dukungan dan memastikan kontinuitas perawatan pasca pulang.

Penelitian terkini menunjukkan bukti kuat dampak dan manfaat dari penerapan FCC. Berikut merupakan manfaat yang bisa diperoleh dari penerapan FCC:

1. Bagi anak: menurunkan tingkat kesemasan dan nyeri, meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan, mempercepat penyembuhan, dan mengurangi komplikasi (Harrison et al, 2023)
2. Bagi keluarga: meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan, mengurangi stress dan kecemasan orang tua, serta meningkatkan rasa percaya diri dan kompetensi dalam merawat anak (Kuo et al, 2019)
3. Bagi perawat dan institusi: meningkatkan kepuasan kerja perawat, mengurangi konflik, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan secara keseluruhan (Coyne et al, 2023)

Penerapan FCC meskipun memiliki manfaat, tetapi pelaksanaannya menghadapi kendala, seperti berikut ini:

1. Faktor sistem: keterbatasan waktu, sumber daya dan beban kerja tinggi di unit perawatan anak
2. Faktor profesional: resistensi terhadap perubahan, kurangnya pelatihan khusus FCC dan kekhawatiran akan hilangnya kendali (Coyne et al, 2023)
3. Faktor keluarga: keragaman budaya, keyakinan, tingkat pendidikan dan kesiapan emosional keluarga yang bervariasi, menuntut pendekatan yang sangat individual

Peran perawat anak dalam FCC sebagai advokat, edukator, koordinator dan fasilitator. Kompetensi kunci yang diperlukan meliputi kemampuan komunikasi terapeutik, ketrampilan negosiasi, kepekaan budaya (*cultural competence*) dan

kemampuan untuk membangun hubungan saling percaya dengan keluarga (Horrison et al., 2023). Pendidikan dan supervisi klinis diperlukan untuk mengembangkan kompetensi ini secara berkelanjutan.

### **C. Manajemen Nyeri Pada Anak: Pendekatam Holistik dan Berbasis Bukti**

---

Nyeri pada anak Adalah perasaan tidak nyaman, baik fisik maupun emosional, yang timbul akibat adanya cedera atau ancaman cedera pada tubuh. Menangani nyeri ini bukan hanya bagian dari perawatan medis, tetapi juga merupakan hak dasar setiap anak (WHO, 2020). Jika nyeri pada anak tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan dampak buruk, seperti rasa takut dan cemas terhadap tenaga kesehatan dalam jangka pendek, serta meningkatkan sensitivitas terhadap rasa sakit dan masalah kecemasan jangka Panjang (Raffaelli et al, 2023). Oleh karena itu, pendekatan yang hanya mengandalkan obat-obatan sudah dianggap kurang memadai, sehingga ibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh (holistik) dengan menggabungkan berbagai metode berdasarkan bukti ilmiah terkini.

Prinsip dasar dalam manajemen nyeri pada anak terdiri dari empat pilar sebagai berikut:

1. Nyeri dipahamisebagai pengalaman multidimensi yang dipengaruhi secara bersamaan oleh factor biologis, psikologis (seperti perasaan dan pikiran), sosial dan spiritual (Raja etal, 2020)
2. Setiap keluhan nyeri dari anak harus dianggap benar, dan penilaiannya perlu dilakukan secara berkala dengan instrument yang terstandar serta disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak
3. Teknik pengobatan (famakologis) dan non obat (non famakologis) harus digunakan secara bersamaan dan saling memperkuat, bukan sebagai pilihan yang terpisah.
4. Keluarga dilibatkan secara aktif sebagai mitra setara dalam proses penilaian nyeri, pengambilan Keputusan perawatan dan pelaksanaan intervensi (Li et al., 2022)

Penilaian nyeri pada anak harus disesuaikan dengan usia dan kemampuan perkembangan mereka.

1. Pada bayi premature dan bayi baru lahir/ neonates, penilaian dilakukan dengan mengamati perubahan perilaku (seperti instrument *premature Infant Pain Profile-Revised/ PIPP*) dan tanda fisiologis tubuh. Perkembangan terkini termasuk penggunaan teknologi seperti *Near Infrared Spectroscopy* (NIRS) untuk mengukur respons otsk terhadap rangsangan nyeri (Raffaelli et al, 2023)
2. Pada bayi dan balita (1 bulan - 3 tahun), skala *Face, Legs, Activiyy, Cry, Consolability* (FLACC) yang mengamati ekspresi wajah, gerakan kaki, aktivitas

tubuh, tangisan dan kemampuan untuk ditenangkan menjadi pilihan utama. Versi yang telah direvisi (FACC-R) dapat digunakan untuk anak dengan keterlambatan perkembangan.

3. Pada anak usia prasekolah dan sekolah (3 tahun – 12 tahun) umumnya sudah dapat menunjuk gambar ekspresi wajah (seperti skala Wong Baker FACES) atau garis visual pada *Visual Analog Scale* (VAS) untuk menunjukkan tingkat nyeri mereka.
4. Pada remaja (>12 tahun), biasanya mampu menggunakan skala numerik (*Numeric Rating Scale/NRS*) dari 0-10 atau mendeskripsikan nyeri secara verbal. Anak dengan gangguan kognitif atau kesulitan berkomunikasi memerlukan alat observasi khusus seperti *Non Communicating Children's Pain Checklist-Revised* (NCCPC-R) yang menilai nyeri melalui perubahan perilaku spesifik (Li et al, 2022)

Pendekatan holistik dan berbasis bukti dalam manajemen nyeri diperlukan baik secara farmakologi maupun non farmakologi. Manajemen nyeri farmakologi dengan pemberian obat untuk menurunkan nyeri pada anak harus mengikuti dua prinsip utama yaitu prinsip bertahap sesuai anjuran WHO dan prinsip multimodal, yaitu menggabungkan obat dengan mekanisme kerja berbeda untuk hasil yang lebih optimal.

1. Pada nyeri ringan hingga sedang (seperti akibat cedera jaringan), parasetamol dan obat antiinflamasi nonsteroid (NSAID) seperti ibuprofen adalah pilihan pertama. Kombinasi kedua obat tersebut efektif untuk menangani nyeri pascaoperasi (Trottier et al, 2022).
2. Pada nyeri sedang-berat atau nyeri saraf (neuropatik), diperlukan obat-obatan golongan opioid (misalnya morfin) dengan penyesuaian dosis yang hati-hati berdasarkan berat badan. Pada nyeri pascaoperasi berat, pemberian opioid melalui infus yang dapat dikontrol oleh pasien sendiri (atau oleh pengasuhnya) dianggap sebagai metode terbaik (Trottier, et al., 2022).
3. Pemberian obat tambahan (*adjuvan*) seperti gabapentin atau pregabalin semakin sering digunakan, baik nyeri neuropatik maupun sebagai bagian dari terapi kombinasi pascaoperasi, berdasarkan bukti efektivitasnya (Raffaelli et al., 2023).
4. Teknik anestesi lokal dan regional (seperti suntikan blok saraf atau kateter epidural) memberikan efek samping sistemik yang minimal, sehingga perlu dipertimbangkan untuk prosedur yang sesuai

Adapun manajemen nyeri non farmakologis bertujuan mengubah cara anak merasakan nyeri, menurunkan rasa cemas dan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengatasi rasa sakit. Berbagai bukti ilmiah telah mendukung efektivitas

pendekatan ini (Umam et al, 2022); Li et al, 2022). Berikut beberapa jenis intervensi yang terbukti bermanfaat:

1. Intervensi psikologis

- a. Distraksi (pengalihan perhatian): merupakan teknik yang sangat efektif dan praktis, seperti menggunakan realitas virtual, bermain video game, atau meniup gelembung sabun untuk mengalihkan fokus anak dari rasa sakit
- b. Edukasi dan persiapan psikologis: memberikan penjelasan yang sesuai dengan usia anak mengenai prosedur medis yang akan dijalani dapat secara signifikan mengurangi rasa takut dan persepsi nyeri mereka.
- c. Terapi Kognitif Perilaku (CBT): Teknik ini membantu anak mengidentifikasi dan mengubah pola pikir serta respons negatif mereka terhadap nyeri, dan terbukti sangat efektif khususnya dalam menangani nyeri kronis.

2. Intervensi Fisik

- a. **Sentuhan dan Kontak Fisik:** meliputi *Kangaroo Mother Care* (kontak kulit ke kulit) untuk bayi baru lahir, teknik membedong (*swaddling*), pijat, dan sentuhan terapeutik untuk menimbulkan rasa nyaman.
- b. **Stimulasi fisik lainnya:** penggunaan *Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation* (TENS), yaitu stimulasi listrik ringan pada kulit, dapat membantu meredakan nyeri pada kondisi muskuloskeletal tertentu.

3. Intervensi Lainnya

- a. **Pemberian Rasa Manis:** Memberikan larutan gula (sukrosa/glukosa) secara oral terbukti dapat mengurangi respons nyeri pada bayi selama prosedur medis ringan.
- b. **Pengisapan Non-Nutrisi:** Aktivitas mengisap dot atau empeng tanpa disertai pemberian nutrisi (*non-nutritive sucking*) juga efektif dalam menenangkan dan mengurangi rasa tidak nyaman pada bayi.

Dalam pendekatan holistik, perawat memegang peran multifaset sebagai penjaga kepentingan anak terkait nyeri (advokat), pengatur seluruh proses asuhan (koordinator), dan pihak yang secara aktif memberikan tindakan pereda nyeri. Untuk menjalankan peran ini secara efektif, perawat perlu menguasai sejumlah kompetensi inti (Li et al., 2022), yaitu:

1. Kompetensi Klinis: Kemampuan untuk melakukan penilaian nyeri yang menyeluruh dan akurat, serta pengetahuan mendalam tentang obat pereda nyeri dan cara pemberiannya yang tepat dan aman.
2. Kompetensi Intervensi: Keterampilan praktis dalam menerapkan beragam teknik non-obat (non-farmakologis) untuk mengatasi nyeri.

3. Kompetensi Komunikasi dan Kolaborasi: Kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif baik dengan anak maupun keluarganya, guna menyusun bersama sebuah rencana penanganan nyeri yang dipersonalisasi.
4. Kompetensi Manajemen dan Rujukan: Pemahaman mengenai penatalaksanaan nyeri yang berlangsung lama (kronis) dan keahlian dalam menentukan waktu serta cara merujuk pasien ke layanan atau spesialis lain bila diperlukan.

#### **D. Integrasi *Family Centered Care* (FCC) dan Manajemen Nyeri dalam Praktik Keperawatan Anak**

Pendekatan *Family Centered Care* (FCC) yang digabungkan dengan manajemen nyeri pada anak bukan hanya ide yang baik, tetapi sebuah keharusan dalam praktik keperawatan modern. Penggabungan ini didasari oleh prinsip filosofis yang sama dari keduanya, yaitu menghargai hak anak dan keluarganya, serta berfokus pada kesejahteraan anak secara menyeluruh (Kristensen et al., 2023).

Hal ini penting karena nyeri adalah pengalaman pribadi yang kompleks. Untuk benar-benar memahaminya dan mengelolanya dengan baik, perawat perlu melihat anak dalam konteks keluarganya. Sebaliknya, filosofi FCC menjadi sangat nyata dan kritis penerapannya justru dalam situasi nyeri. Di sini, keterlibatan keluarga berubah dari teori menjadi tindakan praktis yang langsung mempengaruhi hasil pengobatan anak (Li et al., 2022). Integrasi ini memperbaiki kelemahan pendekatan lama yang terlalu fokus pada teknis obat-obatan dan mengabaikan peran keluarga sebagai sistem pendukung utama. Hubungan antara FCC dan manajemen nyeri adalah sinergis, saling menguatkan (Smith et al., 2024):

1. FCC sebagai fondasi: suasana perawatan yang menghargai dan memberdayakan keluarga menciptakan kondisi terbaik untuk menilai nyeri secara akurat (karena orang tua paling tahu perilaku normal anaknya) dan menjalankan perawatan dengan konsisten.
2. Manajemen nyeri sebagai medan praktik: Proses mengelola nyeri memberikan kesempatan nyata untuk menerapkan prinsip-prinsip FCC, seperti bekerja sama, berbagi informasi, dan menghormati pilihan keluarga.
3. Anak sebagai fokus utama: kedua pendekatan ini bertemu pada satu tujuan: mengurangi penderitaan anak dan membantu mereka tetap nyaman serta dapat beraktivitas optimal.

Integrasi ini diterapkan dalam semua tahap asuhan:

1. Penilaian bersama: penilaian nyeri dilakukan bersama keluarga, bukan oleh perawat sendiri. Orang tua diajak sebagai mitra penilai yang sah. Perawat melatih orang tua mengenali tanda nyeri pada anak mereka dan menggunakan alat penilaian yang mudah dipahami bersama (Kristensen et al., 2023).



2. Merencanakan dan melakukan perawatan bersama: rencana perawatan dirancang melalui diskusi terbuka yang meliputi:
  - a. Menetapkan target nyeri yang disepakati (misalnya, agar anak bisa tidur atau bermain).
  - b. Memilih metode pereda nyeri (obat dan non-obat) yang sesuai dengan bukti ilmiah, budaya, dan kemampuan keluarga (Smith et al., 2024).
  - c. Memberdayakan keluarga dengan pengetahuan tentang obat, teknik menenangkan, dan kapan harus minta bantuan.
3. Mengevaluasi dan menyesuaikan bersama: keberhasilan rencana dievaluasi berdasarkan umpan balik dari anak dan keluarga. Jika kurang efektif, keluarga diajak berdiskusi untuk menyesuaikan, baik dengan mengubah dosis obat atau mencoba teknik lain (Li et al., 2022).

Penelitian membuktikan manfaat dari integrasi ini:

1. Hasil Lebih Baik untuk Anak: Nyeri setelah operasi menjadi lebih ringan, lebih singkat, dan lebih jarang tidak tertangani (Smith et al., 2024).
2. Keluarga Lebih Terlibat dan Puas: Keluarga merasa lebih punya kendali, lebih tenang, dan lebih puas dengan pelayanan secara keseluruhan (Kristensen et al., 2023).
3. Perawatan Lebih Lanjut dan Konsisten: Rencana perawatan yang dibuat bersama lebih mungkin dilanjutkan di rumah, sehingga mencegah nyeri berkepanjangan (Li et al., 2022).

Tantangan dalam penerapan integrasi ini sebagai berikut:

1. Sistem: keterbatasan waktu, SDM, dan belum ada pedoman standar.
2. Tenaga kesehatan: kekhawatiran memberi tanggung jawab pada keluarga, kurangnya keterampilan membimbing keluarga, dan anggapan bahwa melibatkan keluarga justru merepotkan.
3. Keluarga: tingkat kesiapan, kemampuan, dan keinginan untuk terlibat yang berbeda-beda, serta kecemasan orang tua yang tinggi.

Strategi mengatasi meliputi: membuat pedoman klinis yang jelas, memberikan pelatihan komunikasi dan kolaborasi untuk tenaga kesehatan, serta menata lingkungan fisik agar nyaman untuk keterlibatan keluarga (Smith et al., 2024). Dalam model ini, perawat anak berperan sebagai pengintegrasikan, fasilitator, dan penjaga hak anak. Keterampilan baru yang diperlukan adalah:

1. Mampu mengubah prinsip FCC menjadi tindakan nyata dalam mengelola nyeri.
2. Terampil bernegosiasi untuk menyelaraskan bukti ilmiah, aturan rumah sakit, dan nilai keluarga.

3. Memiliki kepekaan budaya untuk memahami perbedaan cara mengungkapkan dan mengatasi nyeri.
4. Mampu membimbing dan memberi kepercayaan diri pada keluarga untuk terlibat dalam perawatan.

## E. Simpulan

Integrasi *Family Centered Care* (FCC) dengan manajemen nyeri pada anak bukan sekedar menggabungkan ke dua konsep, melainkan sintesis yang menghasilkan paradigma perawatan yang lebih kuat, efektif dan manusiawi. Pendekatan integrative ini mengakui bahwa manajemen nyeri yang optimal adalah proses relasional dan kontekstual yang keberhasilannya sangat bergantung pada kemitraan terapeutik antara perawat, anak dan keluarganya. Penerapannya memerlukan komitmen organisasi, pengembangan kompetensi klinis yang relevan, dan reorientasi praktik dari model "melakukan untuk (*doing to*)" ke model "bekerja bersama dengan" keluarga. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan dan mengevaluasi model intervensi yang spesifik, serta menganalisis dampak jangka panjangnya terhadap kesejahteraan anak dan keluarga.

## F. Referensi

- Coyne, I., O'Neill, C., Murphy, M., Costello, T., & O'Shea, R. (2023). What does family-centred care mean to nurses and how do they apply it in practice? *Journal of Advanced Nursing*, \*79\*(1), 350-362. <https://doi.org/10.1111/jan.15446>
- Harrison, T. M., Steenberg, M., & Gephart, S. M. (2023). Family-centered care in the neonatal intensive care unit: A concept analysis and systematic review. *Journal of Pediatric Nursing*, \*68\*, e1-e9. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2022.10.003>
- Institute for Patient- and Family-Centered Care. (2020). *Core concepts of patient- and family-centered care*. Retrieved from <https://www.ipfcc.org/about/pfcc.html>
- Kristensen, H. N., Larsen, M. H., & Lauridsen, H. H. (2023). Family involvement in paediatric pain management: A integrative review. *Journal of Clinical Nursing*, \*32\*(15-16), 4470-4486. <https://doi.org/10.1111/jocn.16589>
- Kuo, D. Z., Houtrow, A. J., Arango, P., Kuhlthau, K. A., Simmons, J. M., & Neff, J. M. (2019). Family-centered care: Current applications and future directions in pediatric health care. *Maternal and Child Health Journal*, \*23\*(3), 426-430. <https://doi.org/10.1007/s10995-018-2683-y>
- Kurniawati, D. & Nursalam, N. (2023). Model of Implementation of Family Centered Care in Pediatric Unit: A Systematic Review. *Pediatric Nursing Journal*, 5(2), 78-89

- Lestari, S., Wahyuni, S., & Fauziah, R. (2023). Nurses' Knowledge and Barriers in Pediatric Pain Management: A Survey in Tertiary Hospital. *Journal of Pediatric Nursing*, 68, e45-e52
- Li, Y., Wang, J., Li, X., & Jiang, H. (2022). Non-pharmacological interventions for pain management in hospitalized children: An overview of systematic reviews. *Journal of Pediatric Nursing*, \*67\*, e139-e150. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2022.08.012>
- Li, Y., Wang, X., & Zhou, H. (2022). The impact of family-centered care interventions on pediatric pain outcomes: A systematic review and meta-analysis. *Pain Management Nursing*, \*23\*(5), 567-576. <https://doi.org/10.1016/j.pmn.2022.04.002>
- Permatasari, S.S., & Setyowati, S. (2024). Family Satisfaction and Involvement in Decision Making of Hospitalized Children Care: A Correlational Study. *Indonesian Journal of Nursing Practice*, 8 (1), 22-31.
- Raffaelli, G., Orenti, A., Gambino, M., Peves Rios, W., Gulczynska, E., Anna, B., ... & Mosca, F. (2023). Pain management in children: A review of the recent evidence. *Pediatric Drugs*, \*25\*(1), 1-15. <https://doi.org/10.1007/s40272-022-00534-x>
- Raja, S. N., Carr, D. B., Cohen, M., Finnerup, N. B., Flor, H., Gibson, S., ... & Vader, K. (2020). The revised International Association for the Study of Pain definition of pain: Concepts, challenges, and compromises. *Pain*, 161(9), 1976-1982. <https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001939>
- Smith, J., Coyne, I., & O'Neill, C. (2024). Operationalizing family-centered care in pediatric pain practice: A co-design study with clinicians and parents. *Journal of Pediatric Nursing*, \*75\*, e1-e9. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2023.11.010>
- Smith, J., Swallow, V., & Coyne, I. (2022). Involving parents in managing their children's long-term conditions—A concept synthesis of family-centered care and partnership-in-care. *Journal of Pediatric Nursing*, \*62\*, 22-32. <https://doi.org/10.1016/j.pedn.2021.11.003>
- The Lancet Child & Adolescent Health Commission. (2023). The underestimated burden of pediatric pain: A global call to action. *The Lancet Child & Adolescent Health*. 7(5), 313-314
- Trottier, E. D., Ali, S., Le May, S., & Gravel, J. (2022). Treating and preventing pain in children: A practical approach in the emergency department. *Paediatrics & Child Health*, \*27\*(1), 45-52. <https://doi.org/10.1093/pch/pxab090>
- Uman, L. S., Birnie, K. A., Chambers, C. T., & Noel, M. (2022). Psychological interventions for needle-related procedural pain and distress in children and adolescents. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2022(10). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD005179.pub4>
- World Health Organization (WHO). (2020). *WHO guidelines for the pharmacological and radiotherapeutic management of cancer pain in adults and adolescents*. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/279700>

## G. Glosarium

---

FCC = *Family Centered Care*

TENS = *Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation*

NSAID = *Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs*

PIPP-R = *Premature Infant Pain Profile-Revised*

NIRS = *Near Infrared Spectroscopy*

FLACC = *Face, Legs, Activiy, Cry, Consolability*

VAS = *Visual Analog Scale*

NRS = *Numeric Rating Scale*



# CHAPTER 4

## **PRAKTIK KEPERAWATAN JIWA: TERAPI AKTIFITAS KELOMPOK, KOMUNIKASI EFEKTIF, DAN MANAJEMEN KRISIS**

Ns. Mutianingsih, M.Kep.

### **A. Pendahuluan**

---

Kesehatan jiwa merujuk pada kondisi kesejahteraan menyeluruh yang meliputi aspek fisik, psikologis, dan sosial, serta tidak semata-mata diartikan sebagai ketiadaan penyakit atau disabilitas. Dalam kondisi ini, individu mampu menghadapi tekanan kehidupan sehari-hari, menjalankan aktivitas secara produktif, dan berperan aktif dalam masyarakat (WHO, 2022). Dengan demikian, kesehatan jiwa tidak hanya berkaitan dengan absennya gangguan mental, tetapi juga menjadi dasar penting bagi kesejahteraan yang memungkinkan seseorang mengembangkan potensi diri, mengelola stres yang wajar, dan berkontribusi secara positif terhadap lingkungannya. Namun, dalam praktik klinis, gangguan jiwa sering kali memiliki kompleksitas yang menuntut penanganan lebih luas daripada sekadar pendekatan biologis. Oleh karena itu, peran perawat jiwa menjadi sangat penting sebagai penghubung dalam proses pemulihan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Keperawatan jiwa merupakan komponen penting dalam sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada upaya menjaga, meningkatkan, dan memulihkan kesehatan mental individu maupun kelompok. Perawat jiwa dituntut memiliki kompetensi profesional, kepekaan emosional, serta pemahaman yang komprehensif terhadap kondisi psikologis pasien. Peran perawat jiwa tidak terbatas pada pemberian asuhan klinis semata, tetapi juga mencakup fungsi sebagai pendamping yang mendukung individu, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan kesehatan mental. Dalam pelaksanaannya, perawat perlu mengombinasikan pendekatan terapeutik, keterampilan komunikasi yang efektif, serta kemampuan dalam penanganan situasi krisis, sehingga pelayanan yang diberikan mampu menjawab kebutuhan pasien secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Terapi aktivitas kelompok merupakan salah satu bentuk intervensi penting dalam praktik keperawatan jiwa. Melalui aktivitas kelompok yang dirancang secara

terarah, pasien memperoleh kesempatan untuk berlatih berinteraksi, menyalurkan perasaan, serta meningkatkan kemampuan sosial. Selain itu, proses dinamika dalam kelompok dapat menjadi sumber dukungan emosional yang berperan besar dalam menunjang pemulihan.

Selain itu, komunikasi efektif menjadi fondasi utama dalam hubungan terapeutik antara perawat dan klien. Kemampuan perawat dalam membangun komunikasi yang empatik, asertif, dan terapeutik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan asuhan keperawatan jiwa. Komunikasi yang tepat tidak hanya membantu dalam pengkajian dan intervensi, tetapi juga menciptakan rasa aman dan kepercayaan bagi klien.

Di sisi lain, kondisi krisis sering kali muncul secara tiba-tiba dalam praktik keperawatan jiwa, baik berupa perilaku agresif, risiko bunuh diri, maupun reaksi emosional yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pemahaman dan keterampilan dalam manajemen krisis menjadi kompetensi esensial bagi perawat jiwa agar mampu mengambil keputusan cepat, tepat, dan aman, tanpa mengabaikan prinsip etika dan keselamatan klien.

## **B. Terapi Aktivitas Kelompok**

---

### **1. Pengertian Terapi Aktivitas Kelompok**

Kelompok dapat dipahami sebagai sekumpulan individu yang saling berhubungan, memiliki ketergantungan satu sama lain, serta terikat oleh norma yang disepakati bersama. Dalam konteks terapeutik, kelompok berperan sebagai wadah bagi individu untuk saling berbagi tujuan, khususnya dalam membantu anggota yang menunjukkan perilaku destruktif agar mampu berinteraksi secara lebih sehat. Melalui proses kelompok, individu didorong untuk mengenali perilaku yang tidak adaptif serta menemukan alternatif solusi guna mengubahnya menjadi perilaku yang lebih konstruktif dan adaptif. Selain itu, kelompok menjadi sarana berbagi pengalaman dan dukungan timbal balik dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi anggota.

Terapi aktivitas kelompok merupakan salah satu bentuk terapi modalitas yang dirancang untuk memfasilitasi perawat atau psikoterapis dalam memberikan asuhan kepada sejumlah pasien yang memiliki permasalahan keperawatan serupa secara bersamaan (Maulana et al., 2021). Dalam terapi ini, aktivitas tertentu digunakan sebagai media intervensi, sementara kelompok berfungsi sebagai sasaran utama asuhan. Interaksi yang terjadi di dalam kelompok menciptakan dinamika saling ketergantungan dan kebutuhan antar anggota, sehingga menjadi lingkungan yang aman bagi klien untuk mempelajari dan mempraktikkan perilaku baru yang lebih adaptif sebagai pengganti perilaku

lama yang maladaptif. Tujuan utama terapi aktivitas kelompok adalah meningkatkan kemampuan pasien dalam bersosialisasi serta membantu perubahan perilaku ke arah yang lebih adaptif. Manfaat terapi ini sangat signifikan bagi pasien dengan gangguan mental, terutama dalam membantu mereka kembali berinteraksi sosial. Dengan membangun hubungan dengan individu lain yang memiliki pengalaman serupa dalam menghadapi dampak penyakit, pasien dapat menyadari bahwa mereka tidak menghadapi kondisi tersebut sendirian (Tisna Yanti et al., 2022).

## **2. Manfaat Terapi Aktivitas Kelompok**

Terapi aktivitas kelompok memberikan berbagai keuntungan bagi pasien, antara lain membantu meningkatkan kemampuan individu dalam menilai realitas melalui proses komunikasi dan pemberian umpan balik antar anggota kelompok. Terapi ini juga berperan dalam mengembangkan kemampuan bersosialisasi, sehingga individu lebih mengenal lingkungan sosialnya dan mampu menjalin interaksi secara lebih efektif. Selain itu, terapi aktivitas kelompok dapat mendukung peningkatan fungsi kognitif maupun afektif pasien.

Melalui kegiatan yang terstruktur, pasien memperoleh sarana untuk mengekspresikan emosi secara positif dan terkendali, sehingga dapat mengurangi risiko munculnya perilaku destruktif. Terapi ini juga membantu memperkuat keterampilan interpersonal dan kemampuan menjalin hubungan sosial dengan lingkungan sekitar. Tidak kalah penting, terapi aktivitas kelompok berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan serta kemampuan individu dalam memecahkan masalah, menghadapi situasi sulit atau tidak terduga, dan mengelola tantangan yang kompleks secara lebih adaptif.

## **3. Jenis Terapi Aktivitas kelompok**

Menurut (Keliat & Akemat, 2014) terdapat beberapa macam terapi aktivitas kelompok diantaranya :

### **a. Terapi aktivitas kelompok (TAK) sosialisasi**

Terapi aktivitas kelompok sosialisasi merupakan suatu bentuk intervensi keperawatan jiwa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi pada sejumlah klien yang mengalami hambatan dalam hubungan sosial. Melalui pelaksanaan TAK sosialisasi, klien difasilitasi untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga kemampuan mereka dalam menjalin hubungan sosial dan berperan aktif di lingkungan sosial dapat berkembang. Terapi ini memberikan bekal pengetahuan serta keterampilan yang



dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk kemampuan berkomunikasi secara efektif dan pemahaman terhadap nilai serta norma perilaku yang berlaku. Proses sosialisasi membantu individu mempelajari dan memahami perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial (Yuswatiningsih & Rahmawati, 2020). Terapi Aktivitas Kelompok Sosialisasi (TAKS) merupakan rangkaian kegiatan yang penting dalam membantu klien dengan masalah isolasi sosial agar mampu bersosialisasi secara bertahap. Pelaksanaannya dilakukan melalui tujuh sesi yang dirancang untuk melatih dan meningkatkan kemampuan sosialisasi klien secara sistematis dan berkelanjutan (Suwarni & Rahayu, 2020).

#### 1) Tujuan Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) Sosialisasi

Secara umum, TAK sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan klien dalam menjalin hubungan sosial di dalam kelompok secara bertahap. Adapun tujuan khusus dari TAK sosialisasi meliputi:

- a) Klien mampu memperkenalkan diri secara tepat
- b) Klien mampu menjalin perkenalan dengan anggota kelompok lainnya
- c) Klien mampu melakukan percakapan dengan anggota kelompok
- d) Klien mampu menyampaikan dan mendiskusikan topik pembicaraan
- e) Klien mampu mengungkapkan permasalahan pribadi kepada orang lain
- f) Klien mampu bekerja sama dengan individu lain
- g) Klien mampu mengemukakan pendapat mengenai manfaat kegiatan TAK yang telah diikuti

#### 2) Indikasi terapi aktivitas kelompok sosialisasi

Terapi aktivitas kelompok sosialisasi direkomendasikan bagi klien yang mengalami gangguan dalam hubungan sosial, yang ditandai dengan beberapa kondisi berikut:

- a) Kurangnya minat atau inisiatif klien untuk mengikuti aktivitas di ruangan
- b) Perilaku menarik diri serta minimnya kontak sosial
- c) Klien dengan masalah harga diri rendah
- d) Munculnya sikap curiga, gelisah, takut, atau cemas saat berinteraksi dengan orang lain
- e) Tidak adanya inisiatif untuk memulai percakapan dan respons komunikasi yang terbatas

#### 3) Efektivitas TAK sosialisasi

Terapi Aktivitas Kelompok Sosialisasi merupakan salah satu intervensi yang dirancang untuk membantu mengembangkan kemampuan bersosialisasi pada pasien skizofrenia yang mengalami gangguan dalam hubungan sosial. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan

terapi aktivitas kelompok sosialisasi efektif dalam meningkatkan kemampuan interaksi sosial pada pasien skizofrenia yang mengalami hambatan dalam menjalin hubungan dengan orang lain (Pardede & Ramadia, 2021; Yuswatiningsih & Rahmawati, 2020).

b. Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) Stimulasi Persepsi

Terapi Aktivitas Kelompok Stimulasi Persepsi merupakan bentuk intervensi keperawatan jiwa yang memanfaatkan aktivitas tertentu sebagai rangsangan berdasarkan pengalaman klien untuk kemudian dibahas secara bersama dalam kelompok. Proses diskusi yang berlangsung memungkinkan terbentuknya kesamaan persepsi maupun alternatif solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi klien. Terapi ini ditujukan bagi klien yang mengalami penurunan kemampuan orientasi dengan tujuan menstimulasi fungsi perseptual, mendorong proses berpikir dan respon afektif, serta menurunkan perilaku yang tidak adaptif.

1) Tujuan terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi :

Pelaksanaan TAK stimulasi persepsi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan klien dalam mengenali realitas secara tepat, memperbaiki tingkat konsentrasi, serta mengembangkan kemampuan intelektual. Selain itu, terapi ini membantu klien dalam menyampaikan pendapat, menerima pandangan orang lain, serta mengekspresikan perasaan secara verbal dalam suasana kelompok yang suportif.

2) Indikasi Terapi Aktivitas Kelompok Stimulasi Persepsi

Terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi dianjurkan bagi klien yang mengalami gangguan persepsi yang berkaitan dengan sistem nilai, kesulitan dalam membedakan antara realitas dan fantasi, serta klien yang memiliki inisiatif atau pola pikir yang cenderung negatif.

3) Efektivitas TAK Stimulasi Persepsi

Terapi Aktivitas Kelompok Stimulasi Persepsi terbukti memberikan dampak yang bermakna dalam pengendalian berbagai gangguan mental, seperti halusinasi, skizofrenia, waham, dan depresi (Maulana et al., 2021). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa intervensi ini efektif dalam mengontrol dan menurunkan intensitas halusinasi pada pasien skizofrenia secara signifikan (Firmawati & Syukur, 2021; Maulana et al., 2021; Sumartyawati, 2019). Penelitian lain juga melaporkan bahwa terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi mampu menurunkan tingkat kecemasan pada pasien yang mengalami halusinasi (Jayarahmana, 2019).

c. Terapi aktivitas kelompok (TAK) stimulasi sensori

Terapi Aktivitas Kelompok Stimulasi Sensori merupakan intervensi keperawatan jiwa yang bertujuan untuk merangsang fungsi seluruh pancaindra agar klien mampu memberikan respons sensori yang sesuai. Terapi ini dilaksanakan melalui berbagai aktivitas terstruktur yang dirancang untuk mengaktifkan kemampuan sensori klien secara optimal

1) Tujuan

Pelaksanaan terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori bertujuan untuk meningkatkan fungsi sensori atau pancaindra, membantu klien dalam memusatkan perhatian, serta memfasilitasi kemampuan klien dalam mengungkapkan perasaan secara tepat.

2) Indikasi Terapi Aktivitas Kelompok Stimulasi Sensori

Terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori diindikasikan bagi klien yang mengalami halusinasi, isolasi sosial dan masalah harga diri rendah, terutama apabila disertai dengan gangguan dalam komunikasi verbal.

3) Efektivitas Terapi Aktivitas Kelompok Stimulasi Sensori

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menilai efektivitas terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori dalam menangani gangguan persepsi sensori pada pasien dengan halusinasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Larasati et al., 2025) menunjukkan adanya penurunan tanda dan gejala halusinasi setelah penerapan terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori. Temuan tersebut diperkuat oleh studi literatur yang dilakukan oleh (Wijoyo et al., 2022) yang menyimpulkan bahwa terapi aktivitas kelompok stimulasi sensori merupakan intervensi penting, khususnya bagi pasien dengan halusinasi, karena mampu meningkatkan kemampuan klien dalam mengendalikan halusinasi.

d. Terapi aktivitas kelompok (TAK) orientasi realita

Terapi aktivitas kelompok orientasi realita merupakan suatu intervensi keperawatan jiwa yang bertujuan membantu klien mengenali dan memahami kondisi nyata yang berkaitan dengan diri sendiri, orang lain, lingkungan sekitar, serta orientasi terhadap waktu dan tempat. Terapi ini dilaksanakan melalui aktivitas kelompok yang terstruktur untuk memperkuat kemampuan klien dalam memaknai realitas secara tepat.

1) Tujuan Terapi aktivitas kelompok (TAK) orientasi realita

Pelaksanaan TAK orientasi realita bertujuan untuk meningkatkan kemampuan klien dalam mengenali rangsangan internal, seperti pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh, serta rangsangan eksternal yang berasal dari

lingkungan, termasuk kondisi cuaca, suara, dan situasi sekitar. Selain itu, terapi ini membantu klien membedakan antara pengalaman khayalan dan kenyataan, serta meningkatkan kemampuan dalam mengenali identitas diri, orang lain, waktu, dan tempat secara akurat.

2) Indikasi Terapi aktivitas kelompok (TAK) orientasi realita

Terapi aktivitas kelompok orientasi realita umumnya diberikan kepada klien yang mengalami gangguan orientasi terhadap orang, waktu, maupun tempat, baik akibat gangguan kognitif maupun gangguan psikotik.

3) Efektivitas Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) orientasi realita

Terapi aktivitas kelompok orientasi realita termasuk dalam intervensi kognitif-perilaku yang bertujuan untuk menurunkan tingkat disorientasi dan gangguan proses pikir pada individu dengan gangguan kognitif atau psikotik (Videbeck, 2018). Hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh (Situmorang et al., 2025) di Rumah Sakit Jiwa Prof. M. Ildream Sumatera Utara, menunjukkan bahwa penerapan TAK orientasi realita efektif dalam meningkatkan kesadaran terhadap realitas pada pasien dengan gangguan mental serta mendukung proses rehabilitasi sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Aulia et al., 2025) yang menyimpulkan bahwa terapi orientasi realita merupakan intervensi nonfarmakologis yang efektif untuk menurunkan delusi pada pasien skizofrenia dan layak diterapkan secara rutin dalam praktik keperawatan kesehatan mental.

## **C. Komunitas Efektif**

---

### **1. Pengertian Komunikasi Efektif**

Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada individu yang terlibat dalam komunikasi. Tujuan dari komunikasi efektif adalah memudahkan penyampaian pesan sehingga diharapkan pemberi pesan dan penerima pesan dapat menerima pesan dengan pemahaman yang sama. Informasi yang disampaikan dalam komunikasi efektif harus menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami sehingga dapat terjadi umpan balik yang seimbang antara pemberi dan penerima pesan. Selain secara verbal, komunikasi efektif juga tidak dapat dilakukan dengan bahasa non verbal seperti bahasa tubuh, tatapan mata, ekspresi wajah, intonasi suara dan lain sebagainya (Gani et al., 2023).

Suatu komunikasi dapat dikatakan efektif apabila pesan, ide, atau informasi yang disampaikan dapat diterima serta dipahami dengan tepat oleh penerima, sehingga tercipta kesamaan pemahaman, peningkatan pengetahuan,

atau perubahan perilaku. Selain itu, komunikasi yang efektif juga ditandai dengan kemampuannya memengaruhi sikap individu yang terlibat di dalamnya. Proses ini melibatkan pertukaran informasi, pemikiran, keyakinan, perasaan, dan sikap antara individu maupun kelompok, sehingga menghasilkan respons atau dampak yang sesuai dengan tujuan komunikasi yang telah ditetapkan.

## **2. Komponen komunikasi efektif**

Dalam komunikasi efektif terdapat beberapa komponen dasar, diantaranya:

a. Pengirim pesan (komunikator)

Pengirim pesan atau komunikator adalah individu yang memiliki gagasan, informasi, atau maksud tertentu untuk disampaikan kepada pihak lain. Komunikator mengharapkan pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima sesuai dengan tujuan dan makna yang dimaksudkan.

b. Pesan

Pesan merupakan isi atau informasi yang disampaikan oleh komunikator, baik melalui bahasa verbal maupun nonverbal, dengan tujuan memberikan informasi, memengaruhi sikap, atau mendorong perubahan perilaku. Pesan dapat berbentuk pernyataan, ajakan, rencana, pertanyaan, simbol, maupun isyarat tertentu.

c. Media

Media adalah sarana yang digunakan sebagai perantara dalam penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima. Media komunikasi dapat berupa alat elektronik maupun non-elektronik, seperti televisi, telepon, papan pengumuman, dan berbagai bentuk media lainnya.

d. Penerima pesan (komunikan)

Penerima pesan atau komunikan merupakan individu yang menerima informasi dari komunikator dan memiliki kemampuan untuk memahami serta menafsirkan pesan yang disampaikan.

e. Encoding.

Encoding adalah proses pengorganisasian dan perumusan pesan oleh komunikator sebelum pesan tersebut disampaikan kepada komunikan, agar maknanya dapat diterima secara jelas

f. Decoding

Decoding merupakan proses penafsiran atau pemaknaan pesan yang dilakukan oleh komunikan ketika menerima pesan dari komunikator.

### 3. Teknik dalam Komunikasi Efektif

Agar komunikasi dapat berlangsung secara efektif, terdapat beberapa tahapan penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Mendengarkan secara aktif: Melatih kemampuan untuk menyimak pembicaraan dengan penuh perhatian tanpa terdistraksi oleh hal lain.
- b. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami: Menghindari istilah teknis atau jargon yang berpotensi membingungkan penerima pesan.
- c. Memberikan umpan balik yang membangun: Baik penyampai maupun penerima pesan perlu saling memberikan tanggapan guna memastikan pesan diterima dan dipahami secara tepat.
- d. Memahami karakteristik audiens: Menyesuaikan cara dan gaya komunikasi dengan kebutuhan, latar belakang, serta kemampuan audiens.
- e. Memanfaatkan komunikasi nonverbal secara tepat: Menjaga kesesuaian antara bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata dengan pesan verbal yang disampaikan.
- f. Meminimalkan gangguan: Mengupayakan lingkungan komunikasi yang kondusif dan bebas dari distraksi agar pesan dapat tersampaikan secara optimal.

### 4. Komunikasi efektif dalam keperawatan jiwa

Komunikasi efektif dalam keperawatan jiwa merujuk pada kemampuan perawat dalam menyampaikan informasi secara jelas, penuh empati, serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan, tetapi juga memiliki tujuan terapeutik, yaitu membantu pasien mengenali dan memahami dirinya, menurunkan tingkat kecemasan, serta meningkatkan kemampuan beradaptasi. Oleh sebab itu, konsep komunikasi efektif dalam keperawatan jiwa kerap dipahami sejalan dengan komunikasi terapeutik, karena keduanya sama-sama berfokus pada proses penyembuhan dan pemulihan psikologis pasien.

#### a. Prinsip Komunikasi Terapeutik pada Klien dengan Gangguan Mental

Klien yang mengalami gangguan jiwa memerlukan pendekatan komunikasi yang berbeda dibandingkan dengan klien yang memiliki masalah kesehatan fisik. Oleh karena itu, perawat dituntut memiliki karakteristik dan keterampilan khusus dalam menjalin interaksi terapeutik dengan klien gangguan jiwa. Menurut (Sarfika et al., 2018), prinsip penting yang harus dimiliki perawat adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak Menghakimi (*Nonjudgmental Approach*)

Sikap tidak menghakimi merupakan salah satu wujud perilaku caring yang harus dimiliki perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Meskipun dalam situasi tertentu perawat perlu membuat penilaian profesional, seperti saat menetapkan diagnosis keperawatan dan menyusun rencana intervensi, pendekatan yang digunakan dalam berkomunikasi dengan klien tetap harus bebas dari sikap menghakimi. Pendekatan nonjudgmental berarti perawat tidak bersikap kasar, tidak memaksakan pendapat, serta tidak mengambil kesimpulan sepihak terhadap klien, baik secara verbal maupun nonverbal. Upaya yang dapat dilakukan agar perawat tidak terjebak dalam sikap menghakimi antara lain dengan meningkatkan kesadaran diri terhadap sikap, nilai, dan prasangka pribadi. Selain itu, perawat perlu memberi ruang bagi klien untuk mengekspresikan pikiran serta perasaannya secara terbuka, menghormati klien sebagai individu yang memiliki kemampuan dan potensi untuk bertanggung jawab, serta melibatkan klien dalam proses pengambilan keputusan terkait perawatan yang dijalaninya. Pendekatan ini membantu terciptanya hubungan terapeutik yang saling menghargai dan mendukung proses pemulihan klien.

## 2) Menerima (*Acceptance*)

Sikap menerima merupakan salah satu ciri penting perawat yang memiliki perilaku caring. Penerimaan berarti mengakui dan menghargai klien apa adanya, serta menyadari bahwa setiap klien memiliki hak untuk mengekspresikan perasaan dan pemikirannya. Perawat yang menerapkan sikap menerima akan menunjukkan penghargaan terhadap pengalaman subjektif klien, tidak menolak atau menyangkal perasaan yang diungkapkan, serta berperan dalam membantu klien mengenali dan memahami dirinya secara lebih baik. Pendekatan ini menjadi dasar terbentuknya hubungan terapeutik yang aman dan saling percaya.

## 3) Empati

Empati merupakan sikap yang sangat penting dalam menunjukkan perilaku caring pada perawat. Empati diartikan sebagai kemampuan untuk memahami pikiran dan perasaan klien serta turut merasakan emosi yang dialami klien tanpa larut sepenuhnya di dalam perasaan tersebut. Dalam membangun empati, terdapat dua tahapan utama yang perlu dilalui. Tahap pertama adalah memahami kondisi emosional klien melalui pengamatan terhadap ekspresi verbal maupun nonverbal. Tahap kedua adalah melakukan validasi dengan mendorong klien untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. Sikap empati ini berperan

besar dalam membangun hubungan terapeutik yang efektif serta membantu klien memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya sendiri.

#### 4) Hormat (*Respect*)

Hormat merupakan salah satu karakteristik penting perawat yang menunjukkan sikap caring. Sikap hormat tercermin melalui penghargaan terhadap klien sebagai individu, termasuk mempertimbangkan kebutuhan dan pandangan mereka, berkomitmen untuk melindungi klien dari bahaya atau risiko, serta meyakini kemampuan klien dalam mengatasi masalah atau menjalani perawatan secara mandiri. Dengan menempatkan hormat sebagai dasar interaksi, perawat dapat membangun hubungan yang saling percaya dan mendukung proses pemulihan klien secara optimal.

#### b. Teknik Komunikasi Terapeutik pada Klien Gangguan Mental

Beberapa teknik yang dapat diterapkan perawat dalam berkomunikasi dengan klien gangguan jiwa meliputi:

- 1) **Klien dengan halusinasi:** Tingkatkan frekuensi komunikasi, baik dengan mengajak klien berinteraksi dengan perawat maupun dengan klien lain, sehingga mereka tetap terhubung dengan lingkungan sosial dan tidak terisolasi dalam pengalaman halusinasinya.
- 2) **Klien dengan harga diri rendah:** Berikan penguatan positif (positive reinforcement) secara rutin untuk mendorong rasa percaya diri dan menghargai kemampuan diri klien.
- 3) **Klien yang menarik diri (*withdrawn*):** Libatkan klien dalam aktivitas atau kegiatan kelompok, sehingga mereka terdorong untuk berinteraksi dan merasa menjadi bagian dari lingkungan sosial.
- 4) **Klien dengan perilaku agresif atau kekerasan:** Reduksi kemarahan klien terlebih dahulu melalui intervensi farmakologis atau teknik de-eskalasi, kemudian setelah klien tenang, komunikasi dapat dilakukan dengan aman dan efektif.

### D. Manajemen Krisis

---

#### 1. Pengertian Manajemen Krisis

Krisis merupakan kondisi gangguan internal yang muncul akibat situasi menegangkan dan mengancam, di mana kemampuan coping serta strategi penyelesaian masalah klien tidak memadai untuk menjaga keseimbangan psikologis, sehingga menimbulkan peningkatan kecemasan (Yosep & Sutini, 2016). Krisis dapat terjadi secara tiba-tiba dalam kehidupan seseorang dan



mengganggu stabilitas psikologis, sehingga mekanisme koping yang dimiliki individu tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Krisis dalam kesehatan jiwa adalah keadaan psikologis yang mendesak dan membutuhkan penanganan secepat mungkin (Suryawantie et al., 2025). Krisis kesehatan jiwa adalah kondisi darurat psikiatri yang ditandai oleh perilaku pasien yang berpotensi membahayakan dirinya sendiri, tenaga kesehatan, maupun orang di sekitarnya. Situasi ini dapat mengancam keselamatan jiwa, berisiko menyebabkan kematian, atau menimbulkan dampak bahaya yang tinggi, sehingga membutuhkan intervensi yang segera dan tepat. (Brister, 2018; Yusuf, A.H & ,R & Nihayati, 2015).

Untuk mencegah kondisi kegawatdaruratan psikiatri yang berpotensi membahayakan keselamatan pasien maupun lingkungan sekitarnya, perawat sebagai tenaga kesehatan yang berada di lini terdepan memiliki peran penting dalam memberikan intervensi yang cepat dan akurat. Tindakan tersebut dilakukan dengan berlandaskan prinsip-prinsip asuhan keperawatan yang diterapkan dalam situasi darurat kejiwaan. Salah satu bentuk intervensi yang dapat dilakukan oleh perawat adalah penerapan manajemen krisis.

Manajemen krisis merupakan komponen esensial dalam praktik keperawatan jiwa. Fokus utama dari proses penilaian dan intervensi pada individu yang mengalami krisis kesehatan mental adalah memastikan stabilitas kondisi medis pasien, melakukan evaluasi risiko keselamatan, menurunkan tingkat tekanan atau distress yang dialami, serta mencapai hasil perawatan yang optimal dan memuaskan bagi pasien (Zeller & Christensen, 2021).

Manajemen krisis dalam keperawatan jiwa merupakan serangkaian tindakan intervensi yang bertujuan membantu individu menghadapi dan melewati pengalaman traumatis dengan memulihkan kembali fungsi psikologisnya. Proses ini mencakup pelaksanaan asesmen awal, pembentukan hubungan terapeutik, penentuan mekanisme koping yang adaptif, serta penerapan berbagai teknik penanganan, termasuk terapi farmakologis dan langkah-langkah pengamanan seperti restrain dan isolasi apabila pasien menunjukkan perilaku yang berisiko. Seluruh tindakan tersebut dilakukan untuk menjamin keselamatan pasien, orang lain, dan lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi hasil intervensi dan penataan ulang kondisi pasien. Manajemen krisis merupakan intervensi aktif yang dilakukan perawat dan tim kesehatan lainnya dan merupakan penanganan kegawatdaruratan psikiatri.

Walaupun krisis kesehatan mental tidak memiliki kriteria diagnosis yang baku, tanda dan karakteristiknya telah dikenal secara tidak langsung oleh para praktisi klinis. Pengalaman berulang dalam menangani individu yang berada

dalam kondisi krisis membentuk pemahaman profesional mengenai gambaran klinis pasien dibandingkan dengan mekanisme atau proses yang mendasarinya. Hal ini terutama dirasakan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di unit gawat darurat dan layanan kesehatan jiwa. Penanganan krisis juga merupakan bidang yang bersifat lintas sektor, sehingga menuntut kerja sama antara aparat penegak hukum, layanan sosial, serta sistem pelayanan kesehatan baik di komunitas maupun di rumah sakit (Hudson et al., 2024).

## **2. Tujuan Manajemen Krisis**

Manajemen krisis dalam keperawatan jiwa merupakan pendekatan intervensi jangka pendek yang diterapkan oleh perawat untuk membantu individu yang sedang berada dalam situasi krisis (Hudson et al., 2024). Intervensi ini dilakukan secara aktif oleh perawat bersama tim kesehatan lainnya guna menangani perilaku pasien yang tidak terkontrol dan berpotensi membahayakan dirinya sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya.

Kondisi kegawatdaruratan psikiatri yang memerlukan penerapan manajemen krisis antara lain percobaan bunuh diri, tindakan agresif atau kekerasan, serta situasi darurat yang berkaitan dengan penggunaan zat atau obat-obatan (Gnanapragasam et al., 2021). Pelaksanaan manajemen krisis menuntut adanya asesmen yang akurat, jaminan keselamatan, dan respons yang segera terhadap pasien. Selain itu, diperlukan pula penilaian risiko terkait perilaku kekerasan, hilangnya kontrol diri, agresivitas, tindakan melukai diri, bunuh diri, maupun pembunuhan.

## **3. Intervensi Manajemen Krisis**

Dalam kondisi krisis, ketika pasien menunjukkan luapan emosi yang sangat kuat, terdapat risiko tinggi terjadinya perilaku agresif atau kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan diri pasien, orang lain, maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan penerapan intervensi manajemen krisis pada situasi kegawatdaruratan psikiatri, yang meliputi beberapa tindakan tertentu diantaranya:

### **a. *De-eskalasi* verbal**

Pedoman penatalaksanaan perilaku agresif pada pasien dengan gangguan jiwa menempatkan teknik de-eskalasi sebagai pendekatan utama yang sebaiknya dilakukan terlebih dahulu (Garriga et al., 2016; NICE, 2015). Dalam praktik klinis, para pakar sepakat bahwa de-eskalasi secara verbal dapat diterapkan sebagai langkah awal sebelum mempertimbangkan tindakan restrain atau pengkekangan fisik (Haefner et al., 2021). Hal ini sejalan

dengan (Richmond et al., 2012) yang menekankan penggunaan farmakoterapi dan restrain pada pasien psikiatri perlu diminimalkan dengan menggantinya melalui strategi lain untuk menenangkan agitasi, salah satunya dengan melibatkan pasien secara verbal guna membangun hubungan yang bersifat kolaboratif antara pasien dan tenaga kesehatan. Secara umum, terdapat empat aspek utama yang menjadi fokus dalam penanganan pasien dengan perilaku agresif, yaitu:

- 1) Menjamin keamanan pasien, tenaga kesehatan, serta individu lain yang berada di lingkungan sekitar,
- 2) Membantu pasien untuk kembali mengendalikan perilaku, emosi, dan tingkat distress yang dialaminya
- 3) Meminimalkan penggunaan tindakan pengekangan dan hanya menerapkannya bila benar-benar diperlukan, serta
- 4) Menghindari intervensi yang bersifat memaksa karena berpotensi meningkatkan agitasi atau kegelisahan pasien.

Dalam situasi kegawatdaruratan psikiatri, de-eskalasi verbal mencakup beberapa pendekatan utama, antara lain:

- 1) Pemilihan bahasa yang lembut dan sopan yaitu berkomunikasi dengan intonasi suara yang rendah dan stabil guna menurunkan tingkat kecemasan serta ketegangan pasien.
- 2) Menjaga jarak aman secara fisik, dengan tidak berada terlalu dekat dengan individu yang sedang mengalami kecemasan atau kemarahan untuk meminimalkan risiko ancaman.
- 3) Menghindari sikap konfrontatif atau perdebatan, dengan tidak menantang, menyalahkan, ataupun mempertanyakan secara langsung perilaku maupun emosi pasien yang sedang berada dalam kondisi krisis.
- 4) Menggunakan pernyataan yang menenangkan dan suportif, seperti menyampaikan kesiapan untuk membantu atau mengajak pasien menenangkan diri dan berdiskusi secara bersama-sama.

(Richmond et al., 2012) menegaskan bahwa pasien yang menunjukkan kegelisahan dan perilaku agresif dapat ditenangkan melalui penerapan teknik de-eskalasi verbal yang berfokus pada pemberdayaan pasien agar tetap mampu mengendalikan diri, sekaligus membangun rasa percaya terhadap tenaga kesehatan. Pendekatan ini juga berpotensi mendorong pasien untuk mencari bantuan lebih dini serta mencegah terjadinya kembali episode agitasi di kemudian hari. Hal ini didukung oleh (Kuivalainen et al., 2017) yang melaporkan bahwa teknik de-eskalasi lebih efektif untuk menenangkan

pasien yang gelisah dibandingkan dengan menggunakan teknik isolasi/pengasingan.

b. Modifikasi lingkungan

Teknik lain yang dapat digunakan dalam penanganan pasien dengan agresivitas dan gelisah adalah dengan melakukan modifikasi lingkungan. Modifikasi lingkungan dalam penanganan kegawatdaruratan psikiatri bertujuan untuk melindungi keselamatan pasien serta orang-orang di sekitarnya. Pendekatan ini mencakup berbagai tindakan yang dilakukan untuk menata atau menyesuaikan kondisi lingkungan di sekitar individu yang mengalami gangguan jiwa atau situasi darurat psikologis, sehingga pasien merasa lebih aman dan nyaman, serta dapat membantu mengurangi kecemasan, ketegangan, atau potensi bahaya. Tujuan dari modifikasi lingkungan adalah menciptakan suasana yang menurunkan stres dan mendukung proses pemulihan mental pasien. Dalam konteks situasi kegawatdaruratan psikiatri, manipulasi lingkungan dapat mencakup beberapa tindakan berikut:

- 1) **Menciptakan lingkungan yang tenang dan terkendali**  
Misalnya dengan mengurangi kebisingan, menyesuaikan pencahayaan agar tidak terlalu terang, serta menghilangkan gangguan lain yang dapat memperburuk kondisi psikologis pasien.
- 2) **Pengaturan tata letak ruangan**  
Menata ruang agar lebih aman, meminimalkan risiko cedera atau perilaku agresif, dan menyediakan privasi bagi pasien bila dibutuhkan.
- 3) **Penyediaan dukungan sosial atau emosional**  
Memastikan kehadiran tenaga kesehatan atau individu yang mampu memberikan rasa aman, mendengarkan, serta menenangkan pasien secara emosional.

c. Terapi farmakologi

Perilaku agresif terkait dengan masalah serius yang membutuhkan intervensi segera karena menimbulkan risiko nyata bagi individu yang terlibat. Perilaku ini dapat menimbulkan stres yang tinggi dan berpotensi mengancam nyawa akibat kelelahan fisik. Selain itu, agresivitas pasien juga dapat membahayakan keselamatan orang lain, termasuk anggota keluarga maupun tenaga kesehatan. Dalam situasi kegawatdaruratan psikiatri, pemberian obat injeksi sering kali diperlukan untuk memberikan efek yang cepat pada pasien yang menunjukkan gejala akut atau sedang mengalami

krisis. Hal ini sejalan dengan (Bak et al., 2019) yang menyatakan bahwa pemberian intervensi farmakologis jangka pendek bertujuan untuk menenangkan pasien dan memulihkan kondisi dalam waktu maksimal dua jam. Obat ini digunakan untuk mengendalikan gejala psikotik, kecemasan yang berat, atau perilaku agresif yang berpotensi membahayakan. Pemberian obat injeksi harus dilakukan dengan pengawasan ketat untuk mencegah efek samping atau reaksi yang merugikan.

d. Isolasi (seclusion)

Isolasi adalah proses pengasingan di mana pasien ditempatkan di ruangan khusus untuk mencegah agar pasien tidak melarikan diri, membahayakan diri sendiri atau orang lain, serta tidak merusak lingkungan sekitarnya. Ruangan isolasi dirancang sebagai lingkungan yang aman bagi pasien sekaligus mempermudah perawat dalam melaksanakan tindakan keperawatan. Prosedur pelaksanaan isolasi (seclusion) meliputi beberapa langkah, antara lain:

1) Pengawasan Ketat

Selama pasien berada dalam isolasi, staf medis atau perawat harus memantau pasien secara terus-menerus untuk memastikan keselamatan mereka serta mengamati kondisi fisik dan psikologis pasien.

2) Kenyamanan dan Keamanan

Ruang isolasi perlu dirancang agar aman, dengan peralatan yang tidak membahayakan dan ruang yang cukup untuk bergerak. Ruangan sebaiknya tenang dan nyaman meskipun pasien berada terpisah dari orang lain.

3) Durasi Terbatas

Isolasi harus diterapkan hanya untuk jangka waktu sesingkat mungkin, yakni selama pasien membutuhkan ruang untuk menenangkan diri atau saat terdapat risiko bahaya yang nyata. Penerapan isolasi yang berlebihan dalam layanan kesehatan mental dapat membahayakan kualitas perawatan dan berpotensi melanggar hak asasi pasien (Haefner et al., 2021).

4) Evaluasi Berkala

Pasien perlu dinilai secara berkala untuk menentukan apakah isolasi masih diperlukan atau dapat dihentikan.

Penggunaan isolasi yang berlebihan dalam perawatan kesehatan mental merupakan ancaman terhadap kualitas perawatan, serta hak asasi manusia pasien.

e. Restrain /pengekangan

Penanganan gawat darurat dalam psikiatri pada pasien yang mengalami agitasi dan berpotensi melakukan kekerasan harus diawali dengan memastikan keselamatan diri sendiri serta tetap waspada terhadap tanda-tanda perilaku agresif. Jika pasien tidak dapat dikendalikan, pembatasan perilaku dapat diterapkan melalui pengekangan fisik (restrain) (Mawaddah et al., 2022).

Dalam konteks psikiatri, restrain merujuk pada tindakan membatasi atau mengekang gerakan individu yang perilakunya tidak terkendali, dengan tujuan menjaga keselamatan fisik dan psikologis pasien. Restrain fisik dapat berupa penggunaan alat mekanis, seperti manset pada pergelangan tangan atau kaki, pengikat khusus. (Rosyad, 2020). Pelaksanaan fiksasi harus dilakukan dengan cermat untuk menghindari cedera pada pasien, dan biasanya disertai dengan pengekangan farmakologis, seperti pemberian injeksi antipsikotik. Fiksasi mekanik dapat menimbulkan beberapa komplikasi, antara lain trauma psikologis, dehidrasi, patah tulang pada anggota tubuh, gangguan pernapasan, bahkan kematian mendadak. Oleh karena itu, pemantauan pasien secara intensif selama proses fiksasi sangat penting untuk mencegah risiko tersebut.

1) Indikasi penggunaan restrain meliputi:

- a) Perilaku agresif yang menimbulkan bahaya bagi pasien maupun orang di sekitarnya.
- b) Agitasi atau kegelisahan yang tidak dapat dikendalikan melalui pengobatan.
- c) Risiko terhadap keselamatan fisik pasien, misalnya terkait penolakan untuk beristirahat, makan, atau minum.
- d) Permintaan pasien untuk intervensi pengendalian perilaku eksternal, setelah evaluasi menunjukkan indikasi terapeutik.

2) Tujuan penggunaan restrain:

- a) Membantu pasien mengendalikan emosi yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
- b) Mengurangi risiko kerusakan atau gangguan terhadap lingkungan sekitar.
- c) Mencegah cedera pada pasien, misalnya akibat terjatuh.
- d) Menghindari pasien meninggalkan rumah sakit tanpa izin tenaga kesehatan (melarikan diri).

3) Hal-hal Penting yang perlu diperhatikan dalam penggunaan restrain:

- a) Dalam situasi darurat, restrain atau seklusi dapat dilakukan tanpa perintah dokter.
- b) Segera setelah tindakan restrain/seklusi (< 1 jam), perawat wajib melaporkan kepada dokter untuk memperoleh legalitas tindakan, baik secara verbal maupun tertulis.
- c) Durasi restrain dibatasi: maksimal 4 jam untuk pasien berusia di atas 18 tahun, dan 2 jam untuk pasien usia 9–17 tahun.
- d) Evaluasi pasien dilakukan secara berkala: setiap 4 jam untuk pasien > 17 tahun dan setiap 2 jam untuk pasien < 18 tahun.
- e) Penggunaan restrain tidak boleh melebihi 24 jam.
- f) Selama restrain, pasien harus diobservasi setiap 10–15 menit dengan fokus pada:
  - Tanda-tanda fisik yang dapat menunjukkan cedera akibat restrain
  - Keamanan lingkungan sekitar pasien
  - Nutrisi dan hidrasi
  - Sirkulasi dan mobilitas ekstremitas
  - Tanda-tanda vital
  - Kebersihan dan eliminasi
  - Kondisi fisik dan psikologis pasien
  - Kesiapan pasien untuk dilepaskan dari restrain

Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrain ekstremitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skor PANSS-EC pada pasien dengan perilaku kekerasan (Mawaddah et al., 2022). Hal ini sejalan hasil dari penerapan evidence based restraint pada klien didapatkan bahwa terjadi penurunan gejala amuk pada klien yang terpasang restraint selama 30 menit dalam kurung waktu 2-3 kali pemasangan (Sanjaya & Syafrizal, 2023). Meskipun beberapa penelitian menunjukkan restrain memiliki pengaruh dalam penurunan gejala amuk pada pasien dengan perilaku kekerasan, namun penggunaan intervensi restriktif ini hanya boleh digunakan dalam situasi klinis darurat, dimana teknik verbal dan perilaku tidak efektif dan penggunaan pengkekangan/restrain menjadi perlu untuk mencegah bahaya bagi pasien dan/atau staf. Jika intervensi ini digunakan, maka penggunaannya dilaksanakan dalam jangka waktu sesingkat mungkin. Selain itu, tindakan restrain juga harus diimbangi dengan adanya staf yang terlatih sehingga prosedur dapat dilakukan dengan aman dan efektif (NICE, 2015)

f. Rehabilitasi dan Tindak Lanjut

Setelah situasi kritis berhasil ditangani, perawat perlu mengajak klien untuk meninjau kembali pengalaman yang telah dialami. Upaya ini dilakukan

guna meningkatkan kesadaran diri klien, mengenali faktor-faktor pemicu, serta merancang mekanisme koping yang lebih adaptif di masa mendatang. Melalui proses refleksi ini, klien juga diberi kesempatan untuk memperoleh edukasi mengenai pentingnya bersikap terbuka terhadap berbagai bentuk dukungan, baik yang berasal dari tenaga kesehatan maupun dari lingkungan sosial sekitarnya (Suryawantie et al., 2025). Selain itu, rehabilitasi dan tindak lanjut pasien dalam konteks kegawatdaruratan jiwa memiliki peran krusial dalam menunjang proses pemulihan setelah pasien melewati episode psikiatri akut dan keluar dari unit gawat darurat. Tahapan ini bertujuan untuk menurunkan risiko kekambuhan gangguan jiwa yang lebih berat di kemudian hari serta membantu pasien kembali menjalankan fungsi kehidupannya secara optimal (NICE, 2015).

#### 1) Perencanaan Rehabilitasi dan Dukungan Psikososial

Rehabilitasi kesehatan jiwa mencakup serangkaian intervensi yang bertujuan membantu pasien kembali berfungsi secara maksimal di lingkungan sosial setelah menjalani perawatan darurat. Program ini melibatkan perawatan lanjutan yang menitikberatkan pada pemulihan aspek mental dan fisik, seperti pengembangan keterampilan sosial, pelatihan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari, serta penguatan relasi sosial untuk mendukung integrasi pasien ke dalam masyarakat.

#### 2) Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap terulangnya episode psikiatri akut. Kegiatan ini meliputi pengawasan setelah pasien dipulangkan dari unit gawat darurat untuk memastikan kondisi mental tetap stabil dan tidak mengalami penurunan. Bentuk pemantauan dapat berupa kontrol berkala ke psikiater atau tenaga profesional kesehatan jiwa, disertai evaluasi kondisi fisik dan psikologis guna mengidentifikasi secara dini tanda-tanda kemungkinan kekambuhan.

## E. Simpulan

---

Kesehatan jiwa mencakup kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial, yang memungkinkan individu beradaptasi terhadap stres, berfungsi produktif, dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Keperawatan jiwa memegang peranan strategis dalam pelayanan kesehatan mental melalui pendekatan yang holistik dan berkesinambungan. Perawat jiwa dituntut untuk memiliki kompetensi profesional yang mencakup kemampuan terapeutik, komunikasi efektif, serta keterampilan dalam manajemen krisis. Penerapan terapi aktivitas kelompok, komunikasi terapeutik yang empatik, dan penanganan krisis yang tepat merupakan komponen



penting dalam mendukung proses pemulihan pasien, meningkatkan kemampuan adaptasi, serta menciptakan rasa aman dan kepercayaan. Dengan mengintegrasikan ketiga aspek tersebut, pelayanan keperawatan jiwa dapat diberikan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pasien, keluarga, dan masyarakat secara menyeluruh.

## F. Referensi

- Aulia, V. R., Sholikhah, S., & Saifudin, M. (2025). Efektivitas Terapi Guided Imagery Dan Terapi Orientasi Realita Terhadap Gangguan Proses Berpikir (Waham) Pada Pasien Skizofrenia Di Yayasan Griya Cinta Kasih Kabupaten Jombang. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 10(2), 1–7.
- Bak, M., Weltens, I., Bervoets, C., De Fruyt, J., Samochowiec, J., Fiorillo, A., Sampogna, G., Bienkowski, P., Preuss, W. U., Misiak, B., Frydecka, D., Samochowiec, A., Bak, E., Drukker, M., & Dom, G. (2019). The pharmacological management of agitated and aggressive behaviour: A systematic review and meta-analysis. In *European Psychiatry* (Vol. 57). <https://doi.org/10.1016/j.eurpsy.2019.01.014>
- Brister, T. (2018). Navigating a mental health crisis: A NAMI resource guide for those experiencing a mental health emergency. *National Alliance on Mental Illness*.
- Firmawati, F., & Syukur, S. B. (2021). EFEKTIVITAS TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK STIMULASI PERSEPSI TERHADAP KEMAMPUAN PASIEN DALAM MENGENDALIKAN HALUSINASI .... *Zaitun (Jurnal Ilmu Kesehatan)*.
- Gani, Zuraidah, Adharudin, Pranata, A. D., & Saputra, A. U. (2023). *Keperawatan Jiwa* (1st ed.). CV.Adanu Abimata.
- Garriga, M., Pacchiarotti, I., Kasper, S., Zeller, S. L., Allen, M. H., Vázquez, G., Baldacçara, L., San, L., McAllister-Williams, R. H., Fountoulakis, K. N., Courtet, P., Naber, D., Chan, E. W., Fagiolini, A., Möller, H. J., Grunze, H., Llorca, P. M., Jaffe, R. L., Yatham, L. N., ... Vieta, E. (2016). Assessment and management of agitation in psychiatry: Expert consensus. *World Journal of Biological Psychiatry*, 17(2). <https://doi.org/10.3109/15622975.2015.1132007>
- Gnanapragasam, A., Paul, D., Sebastian, J., & Sathiyaseelan, M. (2021). Nursing Management of Patients with Psychiatric Emergencies. *Indian Journal of Continuing Nursing Education*, 22(1). [https://doi.org/10.4103/ijcn.ijcn\\_40\\_21](https://doi.org/10.4103/ijcn.ijcn_40_21)
- Haefner, J., Dunn, I., & McFarland, M. (2021). A Quality Improvement Project Using Verbal De-Escalation to Reduce Seclusion and Patient Aggression in an Inpatient Psychiatric Unit. *Issues in Mental Health Nursing*, 42(2). <https://doi.org/10.1080/01612840.2020.1789784>
- Hudson, E., Pariseau-Legault, P., Cassivi, C., Chouinard, C., & Goulet, M. H. (2024).

Mental Health Crisis: An Evolutionary Concept Analysis. In *International Journal of Mental Health Nursing* (Vol. 33, Issue 6). <https://doi.org/10.1111/inm.13412>

- Jayarahmana. (2019). Pendengaran, Efektivitas Terapi Aktivitas kelompok Stimulasi Persepsi terhadap Penurunan kecemasan Klien Halusinasi. *Universitas Muhammadiyah Semarang*, 2(1).
- Keliat, B. A., & Akemat. (2014). Keperawatan jiwa: Terapi aktivitas kelompok. *Cetakan 2016*.
- Kuivalainen, S., Vehviläinen-Julkunen, K., Louheranta, O., Putkonen, A., Repo-Tiihonen, E., & Tiihonen, J. (2017). De-escalation techniques used, and reasons for seclusion and restraint, in a forensic psychiatric hospital. *International Journal of Mental Health Nursing*, 26(5). <https://doi.org/10.1111/inm.12389>
- Larasati, G. K., Hasanah, U., Fitri, N. L., Keperawatan, A., & Wacana, D. (2025). IMPLEMENTASI TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK STIMULASI SENSORI: MENGGAMBAR PADA PASIEN HALUSINASI. *Jurnal Cendikia Muda*, 5(3).
- Maulana, Indra, Hernawati, Taty, Shalahuddin, & Iwan. (2021). Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok Terhadap Penurunan Tingkat Halusinasi Pada Pasien Skizofrenia: Literature Review. *Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok Terhadap Penurunan Tingkat Halusinasi Pada Pasien Skizofrenia: Literature Review*, 9(1).
- Mawaddah, N., Syurandhari, D. H., Kusuma, Y. L. H., & Suryani, D. S. (2022). Efektifitas restrain ekstremitas dan isolasi dalam menurunkan skor PANSS-EC pasien perilaku kekerasan. *Jurnal Keperawatan*, 20(1). <https://doi.org/10.35874/jkp.v20i1.991>
- NICE. (2015). NICE Guideline NG10 - Violence and aggression: short-term management in mental health, health and community settings. *Guidelines*, May 2015.
- Pardede, J. A., & Ramadia, A. (2021). The Ability to Interact with Schizophrenic Patients through Socialization Group Activity Therapy. *International Journal of Contemporary Medicine*, 9(1). <https://doi.org/10.37506/ijocm.v9i1.2925>
- Richmond, J. S., Berlin, J. S., Fishkind, A. B., Holloman, G. H., Zeller, S. L., Wilson, M. P., Rifai, M. A., & Ng, A. T. (2012). Verbal de-escalation of the agitated patient: Consensus statement of the American Association for emergency psychiatry project BETA De-escalation workgroup. *Western Journal of Emergency Medicine*, 13(1). <https://doi.org/10.5811/westjem.2011.9.6864>
- Rosyad, Y. S. (2020). *MODUL PRAKTIK LABORATORIUM KEPERAWATAN JIWA II*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Sanjaya, H., & Syafrizal, R. (2023). Efektifitas Penerapan Restraint Mekanis Terhadap Penurunan Gejala Amuk Pada Perilaku Kekerasan di Ruang Upip RSJ Tampan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1).

- Sarfika, R., Maisa, E. A., & Freska, W. (2018). Buku Ajar Keperawatan Dasar 2 Komunikasi Terapeutik Dalam Keperawatan. In *Andalas University Press*.
- Situmorang, H., Nasution, B. H., & Nainggolan, E. (2025). Pengabdian Kepada Masyarakat "Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) Orientasi Realita." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Sumartyawati, N. M. (2019). EFEKTIVITAS TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK STIMULASI PERSEPSI DAN TERAPI RELIGIUS TERHADAP FREKUENSI HALUSINASI. *Prima: Jurnal Ilmiah Ilmu Kesehatan*, 5(1). <https://doi.org/10.47506/jpri.v5i1.134>
- Suryawantie, T., Afriyanti, F. N., Wijayanti, A. P., Dias, M. F. A. A., Reni, Tatisina, C. M., Diorarta, R., Ansela, R. D., Hitiyaut, M., & Samura, M. D. (2025). *Asuhan Keperawatan Jiwa*. PT.Bukuloka Literasi Bangsa.
- Suwarni, S., & Rahayu, D. A. (2020). Peningkatan Kemampuan Interaksi Pada Pasien Isolasi Sosial Dengan Penerapan Terapi Aktivitas Kelompok Sosialisasi Sesi 1-3. *Ners Muda*, 1(1). <https://doi.org/10.26714/nm.v1i1.5482>
- Tisna Yanti, Emilya Irawan, Sri Redjeki, SatrioKusumo Lelono, Nining Fitrianingsih, Fajar Adhie Sulisty, & Rani Devayanti. (2022). The Effect of Group Activity Therapy on Patients' Independence Level in Controlling Hallucinations at Bogor Mental Health Clinic. *Indian Journal of Public Health Research & Development*, 14(1). <https://doi.org/10.37506/ijphrd.v14i1.18871>
- Videbeck, L. S. (2018). Psychiatric-Mental Health NURSING Eighth Edition. In *Wolters Kluwer*.
- Wijoyo, E. B., Khotimah, N., & Nuraini, N. (2022). The Effect of Sensory Perception Stimulation Group Activity Therapy on the Ability to Control Hallucinations: A Literature Review. *Jurnal Kesehatan Masa Depan*, 1(2). <https://doi.org/10.58516/jhnxdg96>
- Yosep, I., & Sutini, T. (2016). *Buku Ajar Keperawatan Jiwa dan Advance Mental Health Nursing*. Refika Aditama.
- Yusuf, A.H, F., & ,R & Nihayati, H. . (2015). Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa. *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. <https://doi.org/ISBN 978-xxx-xxx-xx-x>
- Yuswatiningsih, E., & Rahmawati, I. M. H. (2020). Terapi Social Skill Training (SST) Untuk Klien Isolasi Sosial. In *E-Book Penerbit STIKes Majapahit Mojokerto*.
- Zeller, S. L., & Christensen, J. C. (2021). Delivery models of emergency psychiatric care. In *Behavioral Emergencies for Healthcare Providers*. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-52520-0\\_45](https://doi.org/10.1007/978-3-030-52520-0_45)

## G. Glosarium

---

TAK = Terapi Aktivitas Kelompok

# CHAPTER 5

## KOLABORASI INTERPROFESIONAL DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN

Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.

### A. Pendahuluan

#### 1. Kompleksitas Sistem Kesehatan dan Tantangan Pelayanan Modern

Sistem kesehatan global saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, ditandai oleh peningkatan usia harapan hidup, meningkatnya prevalensi penyakit kronis dan komorbiditas, serta kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang. Kondisi ini diperberat oleh keterbatasan sumber daya manusia kesehatan dan ketidakseimbangan distribusi tenaga kesehatan, baik di negara maju maupun berkembang. Laporan *World Health Report* menunjukkan adanya krisis tenaga kesehatan global yang berdampak langsung pada mutu dan akses pelayanan kesehatan (Yan et al., 2006).

Model pelayanan kesehatan yang masih terfragmentasi, berbasis profesi tunggal, dan berorientasi pada perawatan episodik terbukti tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks. Sistem yang berfokus pada pelayanan akut dan rumah sakit cenderung mengabaikan aspek promotif, preventif, serta kesinambungan pelayanan, sehingga berkontribusi pada peningkatan biaya kesehatan dan ketidakefektifan hasil klinis. Dokumen kebijakan kesehatan di Kanada menunjukkan bahwa kegagalan sistem kesehatan dalam mengoptimalkan kolaborasi lintas profesi telah berdampak pada kesenjangan akses layanan, khususnya bagi kelompok dengan penyakit kronis dan masyarakat di wilayah *rural* dan *remote* (Canadian-Nurses-Association, 2012).

Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak untuk mereorientasi sistem pelayanan kesehatan menuju pendekatan berbasis tim (*team-based care*) yang mengintegrasikan berbagai profesi kesehatan secara kolaboratif. Pendekatan ini dipandang sebagai strategi penting untuk memperkuat sistem kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan, serta menjawab tantangan kesehatan masyarakat secara lebih holistik dan berkelanjutan.

## 2. Pergeseran Paradigma Pelayanan- dari Fragmentasi ke Kolaborasi

Perubahan kebutuhan kesehatan masyarakat telah mendorong pergeseran paradigma pelayanan kesehatan dari pendekatan yang terfragmentasi menuju pendekatan kolaboratif dan berpusat pada pasien. Paradigma baru ini menempatkan pasien, keluarga, dan komunitas sebagai mitra aktif dalam pelayanan, serta menekankan pentingnya integrasi peran berbagai profesi kesehatan dalam proses pengambilan keputusan klinis.

Kerangka global yang dikembangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa sistem kesehatan yang kuat memerlukan tenaga kesehatan yang siap berkolaborasi lintas profesi. *Framework for Action on Interprofessional Education and Collaborative Practice* menyatakan bahwa *interprofessional collaboration* merupakan strategi kunci untuk mengatasi fragmentasi sistem kesehatan dan meningkatkan hasil kesehatan populasi (Gilbert et al., 2010). Kerangka ini menekankan bahwa kolaborasi interprofesional tidak dapat dilepaskan dari kesiapan sistem pendidikan dan praktik pelayanan kesehatan secara simultan.

Lebih lanjut, WHO menegaskan bahwa kolaborasi interprofesional bukan hanya pendekatan teknis dalam pelayanan, melainkan sebuah perubahan budaya dalam sistem kesehatan. Perubahan ini mencakup cara tenaga kesehatan berkomunikasi, berbagi tanggung jawab, dan mengambil keputusan bersama dalam konteks pelayanan yang kompleks (Gilbert et al., 2010). Dalam praktiknya, sistem kesehatan yang berhasil mengimplementasikan kolaborasi interprofesional menunjukkan peningkatan koordinasi pelayanan, penurunan kesalahan klinis, serta peningkatan kepuasan pasien dan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, kolaborasi interprofesional dipandang sebagai fondasi penting dalam transformasi pelayanan kesehatan modern.

## 3. Peran Strategis Perawat dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Kolaboratif

Perawat merupakan kelompok tenaga kesehatan terbesar dan memiliki keterlibatan paling berkelanjutan dalam proses pelayanan kesehatan. Peran perawat tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tindakan keperawatan, tetapi mencakup koordinasi asuhan, edukasi pasien, advokasi, serta penghubung antara pasien, keluarga, dan profesi kesehatan lainnya. Posisi strategis ini menjadikan perawat sebagai aktor kunci dalam praktik kolaborasi interprofesional.

Laporan *Optimizing the Role of Nurses in Primary Care in Canada* menegaskan bahwa optimalisasi peran perawat dalam tim interprofesional berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pelayanan, kontinuitas

asuhan, dan efisiensi sistem kesehatan. Studi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perawat dalam model pelayanan berbasis tim berhubungan dengan peningkatan promosi kesehatan, manajemen penyakit kronis, dan koordinasi layanan (Canadian-Nurses-Association, 2014). Namun demikian, laporan yang sama juga mengidentifikasi bahwa peran perawat sering kali belum dimanfaatkan secara optimal akibat kurangnya kejelasan peran, keterbatasan dukungan kebijakan, serta budaya hierarkis dalam sistem pelayanan kesehatan. Hambatan-hambatan ini dapat mengurangi efektivitas kolaborasi interprofesional dan berdampak pada mutu pelayanan yang diberikan.

Dalam konteks kolaborasi interprofesional, perawat berperan sebagai penggerak integrasi pelayanan. Perawat sering berada pada posisi sentral dalam komunikasi antarprofesi, khususnya dalam perencanaan asuhan, pemantauan kondisi pasien, dan koordinasi transisi pelayanan. Oleh karena itu, penguatan peran perawat dalam sistem pelayanan kolaboratif menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi kolaborasi interprofesional.

#### **4. Kolaborasi Interprofesional sebagai Kebutuhan Sistemik**

Kolaborasi interprofesional didefinisikan sebagai proses kerja sama antara dua atau lebih profesi kesehatan yang melibatkan komunikasi efektif, pengambilan keputusan bersama, dan tanggung jawab kolektif dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien. Kolaborasi ini berbeda dari sekadar kerja paralel antar disiplin, karena menuntut integrasi peran, nilai, dan praktik profesional.

Berbagai kajian menunjukkan bahwa kolaborasi interprofesional berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan pasien dan mutu pelayanan. Tinjauan sistematis di rumah sakit menunjukkan bahwa strategi kolaborasi interprofesional yang terstruktur, termasuk pelatihan bersama, pengembangan protokol, dan integrasi kerja tim, efektif dalam menurunkan insiden keselamatan pasien dan meningkatkan kualitas layanan (Keumalasari et al., 2025). Temuan serupa juga menekankan bahwa komunikasi interprofesional yang efektif merupakan komponen kunci dalam keberhasilan kolaborasi dan pencegahan kesalahan klinis (Wahyuningsih & Firmada, 2025).

Dari perspektif kebijakan, kolaborasi interprofesional dipandang sebagai kebutuhan sistemik, bukan sekadar pilihan praktik. Dokumen kebijakan dan posisi profesi keperawatan di Kanada menegaskan bahwa model pelayanan berbasis tim interprofesional diperlukan untuk memastikan tenaga kesehatan bekerja sesuai kompetensi dan lingkup praktiknya secara optimal, serta untuk

menjawab tantangan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks (Canadian-Nurses-Association, 2012).

Dengan demikian, kolaborasi interprofesional harus dipahami sebagai strategi fundamental dalam penguatan sistem kesehatan. Dalam praktik keperawatan, kolaborasi ini menjadi landasan bagi pemberian asuhan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Bab ini menjadi dasar konseptual untuk memahami pentingnya kolaborasi interprofesional sebelum membahas konsep, prinsip, dan implementasinya secara lebih mendalam pada bab-bab selanjutnya.

## **B. Konsep Dasar Kolaborasi Interprofesional**

---

### **1. Definisi Kolaborasi Interprofesional**

Kolaborasi interprofesional merupakan konsep sentral dalam pengembangan sistem pelayanan kesehatan modern yang berorientasi pada mutu, keselamatan pasien, dan kesinambungan asuhan. Secara konseptual, kolaborasi interprofesional merujuk pada proses kerja sama yang terstruktur antara dua atau lebih profesi kesehatan yang memiliki latar belakang keilmuan berbeda, dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berpusat pada pasien.

Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan kolaborasi interprofesional sebagai praktik di mana tenaga kesehatan dari berbagai latar belakang profesi bekerja bersama dengan pasien, keluarga, dan komunitas untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan kualitas tertinggi. Definisi ini menegaskan bahwa kolaborasi tidak hanya terjadi antar profesi, tetapi juga melibatkan pasien sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan terkait perawatan (Gilbert et al., 2010).

Lebih lanjut, WHO menekankan bahwa kolaborasi interprofesional merupakan hasil dari proses pembelajaran dan praktik yang saling terkait. Kolaborasi yang efektif hanya dapat terwujud apabila tenaga kesehatan telah dipersiapkan melalui *interprofessional education* dan didukung oleh sistem pelayanan yang memungkinkan praktik kolaboratif berlangsung secara berkelanjutan (WHO, 2010). Dengan demikian, kolaborasi interprofesional bukanlah peristiwa spontan, melainkan suatu kompetensi profesional yang berkembang melalui interaksi, pengalaman, dan dukungan sistemik.

Dalam konteks keperawatan, kolaborasi interprofesional dipahami sebagai proses dinamis yang mencakup pertukaran informasi klinis, negosiasi peran, serta pengambilan keputusan bersama dalam tim pelayanan kesehatan. Perawat berperan aktif dalam mengintegrasikan perspektif berbagai profesi untuk

memastikan asuhan yang diberikan selaras dengan kebutuhan pasien dan keluarga.

## **2. Kolaborasi Interprofesional dalam Spektrum Pendekatan Kerja Tim Kesehatan**

Dalam praktik pelayanan kesehatan, kolaborasi interprofesional sering kali disamakan dengan pendekatan multidisipliner atau transdisipliner, meskipun ketiganya memiliki perbedaan konseptual yang mendasar. Pendekatan multidisipliner umumnya ditandai oleh keterlibatan berbagai profesi kesehatan yang bekerja secara paralel sesuai dengan lingkup tugas masing-masing. Interaksi antartenenaga kesehatan pada pendekatan ini cenderung terbatas, dan pengambilan keputusan sering dilakukan secara terpisah.

Berbeda dengan pendekatan multidisipliner, kolaborasi interprofesional menekankan integrasi peran dan tanggung jawab, komunikasi dua arah, serta pengambilan keputusan bersama. Dalam kolaborasi interprofesional, setiap profesi mempertahankan identitas profesionalnya, namun bekerja dalam kerangka tujuan bersama yang berorientasi pada kebutuhan pasien. WHO menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif ini memungkinkan optimalisasi kompetensi setiap profesi dan meminimalkan fragmentasi pelayanan (WHO, 2010).

Pendekatan transdisipliner, di sisi lain, ditandai oleh batas peran yang lebih fleksibel, di mana anggota tim dapat saling berbagi atau mengambil alih peran profesi lain setelah melalui pelatihan tertentu. Meskipun pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi dalam konteks tertentu, kolaborasi interprofesional tetap dipandang sebagai pendekatan yang paling relevan dalam sistem kesehatan modern karena menjaga keseimbangan antara kejelasan peran profesional dan kerja sama lintas disiplin.

Bagi profesi keperawatan, pemahaman terhadap spektrum pendekatan kerja tim ini penting untuk menempatkan peran secara tepat dalam sistem pelayanan kesehatan. Kolaborasi interprofesional memungkinkan perawat berkontribusi secara optimal tanpa kehilangan identitas dan otonomi profesionalnya.

## **3. Prinsip-Prinsip Dasar Kolaborasi Interprofesional**

Kolaborasi interprofesional yang efektif dibangun di atas sejumlah prinsip dasar yang saling berkaitan. Prinsip pertama adalah orientasi pada pasien (*client-centred care*). Kolaborasi interprofesional menempatkan pasien dan keluarga sebagai pusat pelayanan, dengan menghargai nilai, preferensi, dan



kebutuhan individu dalam setiap proses pengambilan keputusan. Prinsip ini secara konsisten ditekankan dalam berbagai dokumen kebijakan dan pernyataan posisi profesi keperawatan (Bosch & Mansell, 2015)

Prinsip kedua adalah komunikasi yang efektif dan berkelanjutan. Komunikasi interprofesional mencakup pertukaran informasi yang jelas, terbuka, dan tepat waktu antaranggota tim. Bukti empiris menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi antartagenaga kesehatan merupakan salah satu penyebab utama insiden keselamatan pasien. Tinjauan sistematis dan *scoping review* terbaru menegaskan bahwa komunikasi interprofesional yang terstruktur berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di rumah sakit (Wahyuningsih & Firmanda, 2025).

Prinsip berikutnya adalah saling menghormati dan pengakuan terhadap peran profesional. Setiap profesi kesehatan membawa kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman yang unik. Kolaborasi yang efektif hanya dapat terwujud apabila terdapat pengakuan dan penghormatan terhadap kontribusi masing-masing profesi, serta pemahaman yang jelas mengenai batas dan tanggung jawab profesional. Pernyataan posisi organisasi profesi keperawatan menekankan bahwa penghormatan lintas profesi merupakan fondasi etis dalam praktik kolaboratif (Bosch & Mansell, 2015)

Selain itu, pengambilan keputusan bersama (*shared decision-making*) merupakan prinsip penting dalam kolaborasi interprofesional. Pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai profesi memungkinkan pertimbangan klinis yang lebih komprehensif dan mengurangi risiko kesalahan akibat perspektif yang terbatas. Prinsip ini juga memperkuat akuntabilitas kolektif dalam pemberian pelayanan kesehatan.

#### **4. Implikasi Konseptual Kolaborasi Interprofesional dalam Keperawatan**

Kolaborasi interprofesional memiliki implikasi konseptual yang signifikan terhadap praktik keperawatan. Perawat dituntut untuk tidak hanya memiliki kompetensi klinis, tetapi juga kompetensi kolaboratif yang mencakup kemampuan komunikasi, pemahaman peran profesi lain, serta kemampuan bekerja secara efektif dalam tim lintas profesi. Kompetensi ini menjadi bagian integral dari praktik keperawatan modern.

Dalam sistem pelayanan berbasis tim, perawat sering berperan sebagai penghubung utama antar profesi. Laporan kebijakan mengenai optimalisasi peran perawat menunjukkan bahwa perawat memiliki posisi strategis dalam koordinasi asuhan, manajemen penyakit kronis, dan kesinambungan pelayanan, khususnya dalam pelayanan kesehatan primer dan komunitas (Canadian-

Nurses-Association, 2014). Peran ini menegaskan bahwa kolaborasi interprofesional bukan sekadar tambahan dalam praktik keperawatan, melainkan bagian esensial dari peran profesional perawat. Lebih lanjut, kolaborasi interprofesional memperkuat kontribusi keperawatan terhadap keselamatan pasien dan mutu pelayanan. Tinjauan sistematis mengenai strategi kolaborasi interprofesional di rumah sakit menunjukkan bahwa praktik kolaboratif yang terstruktur berdampak positif terhadap penurunan insiden keselamatan pasien dan peningkatan kualitas layanan (Keumalasari et al., 2025).

Dengan demikian, kolaborasi interprofesional menjadi kerangka konseptual penting dalam pengembangan praktik keperawatan yang aman, bermutu, dan berkelanjutan.

### **C. Landasan Teoretis Kolaborasi Interprofesional**

---

#### **1. Kerangka WHO tentang Interprofessional Education dan Collaborative Practice**

Landasan teoretis utama kolaborasi interprofesional bersumber dari *Framework for Action on Interprofessional Education and Collaborative Practice* yang dikembangkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Kerangka ini memandang kolaborasi interprofesional sebagai hasil dari keterkaitan yang erat antara sistem pendidikan dan sistem pelayanan kesehatan. WHO menegaskan bahwa tenaga kesehatan yang siap berkolaborasi (*collaborative practice-ready workforce*) hanya dapat dihasilkan melalui *interprofessional education* (IPE) yang terintegrasi dengan praktik pelayanan kesehatan (WHO, 2010).

Kerangka WHO menempatkan kolaborasi interprofesional sebagai strategi untuk mengatasi fragmentasi sistem kesehatan dan krisis tenaga kesehatan global. Dalam kerangka tersebut, kolaborasi dipahami sebagai mekanisme penguatan sistem yang memungkinkan optimalisasi kompetensi lintas profesi, peningkatan koordinasi pelayanan, dan perbaikan hasil kesehatan populasi. WHO juga menekankan bahwa kolaborasi interprofesional bukan intervensi tunggal, melainkan proses sistemik yang dipengaruhi oleh kebijakan, tata kelola organisasi, budaya kerja, serta dukungan manajerial (Gilbert et al., 2010).

Lebih lanjut, WHO Study Group menegaskan bahwa setelah lebih dari lima dekade penelitian, terdapat bukti yang cukup bahwa *interprofessional education* yang efektif memungkinkan terwujudnya praktik kolaboratif yang berdampak positif pada penguatan sistem kesehatan dan hasil kesehatan pasien (Yan et al., 2006). Dengan demikian, kerangka WHO memberikan fondasi teoretis bahwa kolaborasi interprofesional merupakan pendekatan berbasis

bukti (*evidence-informed approach*) dalam pengembangan pelayanan kesehatan modern.

## **2. Interprofessional Education sebagai Fondasi Kompetensi Kolaboratif**

Interprofessional education (IPE) merupakan pilar utama dalam pengembangan kolaborasi interprofesional. WHO mendefinisikan IPE sebagai proses pembelajaran di mana peserta didik dari dua atau lebih profesi belajar *tentang, dari, dan dengan* satu sama lain untuk memungkinkan kolaborasi yang efektif dan meningkatkan hasil kesehatan. Definisi ini menekankan bahwa kolaborasi bukan sekadar keterampilan teknis, tetapi kompetensi profesional yang harus dibangun sejak tahap pendidikan (WHO, 2010)

Penguatan konseptual IPE juga dikembangkan oleh Interprofessional Education Collaborative (IPEC). Dalam *Core Competencies for Interprofessional Collaborative Practice* versi terbaru, IPEC menegaskan bahwa kompetensi kolaboratif mencakup empat domain utama, yaitu nilai dan etika kolaboratif, peran dan tanggung jawab profesional, komunikasi interprofesional, serta kerja tim dan kepemimpinan kolaboratif. Kompetensi ini menjadi kerangka normatif yang menjembatani pendidikan dan praktik kolaboratif di layanan kesehatan (Interprofessional-Education-Collaborative, 2023).

IPE dipandang sebagai mekanisme penting untuk membentuk budaya kolaboratif dan mengurangi hambatan profesional, seperti stereotip profesi dan hierarki dalam pelayanan kesehatan. Tanpa IPE yang memadai, praktik kolaboratif berisiko bersifat formalitas dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam konteks keperawatan, IPE menjadi landasan teoretis penting untuk menyiapkan perawat yang mampu bekerja secara efektif dalam tim interprofesional.

## **3. Teori Kerja Tim dan Kolaborasi dalam Pelayanan Kesehatan**

Secara teoretis, kolaborasi interprofesional berakar pada teori kerja tim dan dinamika kelompok dalam organisasi. Kerja tim dalam pelayanan kesehatan dipahami sebagai proses koordinasi interaksi, peran, dan tanggung jawab antarindividu dengan kompetensi yang saling melengkapi. Reeves dan kolega menekankan pentingnya membedakan antara teamwork, collaboration, coordination, dan networking agar praktik kolaboratif tidak disederhanakan sebagai kerja bersama tanpa integrasi makna dan tujuan (Reeves et al., 2018).

Dalam konteks keselamatan pasien, teori kerja tim menempatkan komunikasi, kejelasan peran, dan kepemimpinan kolaboratif sebagai determinan utama keberhasilan tim. Kajian klasik oleh Manser menunjukkan

bahwa kegagalan kerja tim dan komunikasi merupakan faktor dominan dalam terjadinya insiden keselamatan pasien di lingkungan pelayanan kesehatan yang kompleks dan dinamis (Manser, 2009).

Pendekatan teoretis ini relevan bagi keperawatan, mengingat perawat sering berada pada pusat koordinasi pelayanan dan menjadi penghubung antarprofesi. Dengan demikian, teori kerja tim memberikan kerangka analitik untuk memahami bagaimana kolaborasi interprofesional dapat meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara sistemik.

#### **4. Model Kolaborasi Interprofesional dalam Praktik Pelayanan Kesehatan**

Berbagai model kolaborasi interprofesional telah dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana kerja tim lintas profesi dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik. Dokumen kebijakan dan sintesis bukti menunjukkan bahwa model kolaborasi yang berhasil umumnya ditandai oleh struktur tim yang jelas, kepemimpinan kolaboratif, komunikasi terintegrasi, serta dukungan organisasi dan kebijakan (Canadian-Nurses-Association, 2012).

Tinjauan sistematis mengenai efektivitas tim interprofesional dalam pelayanan kesehatan primer menunjukkan bahwa model pelayanan berbasis tim berkontribusi terhadap peningkatan hasil kesehatan pasien, akses layanan, serta efisiensi penggunaan sumber daya (Jacobson & Health, 2012). Temuan ini memperkuat argumen bahwa kolaborasi interprofesional bukan hanya konsep normatif, tetapi pendekatan yang terbukti efektif secara empiris.

Dalam konteks rumah sakit, kerangka kolaborasi tim interprofesional menekankan pentingnya integrasi peran klinis, mekanisme komunikasi formal, dan budaya keselamatan pasien. Studi-studi terkini menunjukkan bahwa intervensi berbasis kolaborasi interprofesional berdampak positif terhadap penurunan insiden keselamatan pasien dan peningkatan kualitas layanan (Keumalasari et al., 2025). Bagi keperawatan, model-model ini menegaskan bahwa kolaborasi interprofesional harus dipahami sebagai sistem kerja yang terstruktur, bukan sekadar interaksi individual. Perawat berperan penting dalam menjaga kesinambungan model kolaboratif tersebut melalui koordinasi asuhan, komunikasi lintas profesi, dan advokasi kebutuhan pasien.

#### **5. Sintesis Landasan Teoretis bagi Praktik Keperawatan**

Berdasarkan kerangka WHO, konsep IPE, teori kerja tim, dan model kolaborasi interprofesional, dapat disimpulkan bahwa kolaborasi interprofesional merupakan pendekatan yang bersifat sistemik, multidimensional, dan berbasis bukti. Kolaborasi tidak hanya bergantung pada

kompetensi individu, tetapi juga pada dukungan sistem pendidikan, organisasi pelayanan, dan kebijakan kesehatan. Dalam praktik keperawatan, landasan teoretis ini memberikan pijakan kuat untuk memahami peran perawat sebagai aktor kunci dalam kolaborasi interprofesional.

#### **D. Peran Dan Tanggung Jawab Perawat Dalam Kolaborasi Interprofesional**

---

##### **1. Perawat sebagai *Care Provider* dalam Tim Interprofesional**

Dalam sistem pelayanan kesehatan kolaboratif, perawat berperan sebagai *care provider* yang memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif, berkelanjutan, dan berpusat pada pasien. Peran ini mencakup pengkajian kebutuhan pasien, perencanaan asuhan, implementasi intervensi keperawatan, serta evaluasi hasil perawatan yang terintegrasi dengan kontribusi profesi kesehatan lain. Kerangka WHO menegaskan bahwa praktik kolaboratif yang efektif memungkinkan optimalisasi kompetensi setiap profesi sehingga pelayanan yang diberikan menjadi lebih aman dan bermutu (WHO, 2010).

Bukti empiris menunjukkan bahwa keterlibatan perawat sebagai *care provider* dalam tim interprofesional berdampak positif terhadap hasil kesehatan pasien, khususnya pada manajemen penyakit kronis dan pelayanan kesehatan primer. Sintesis bukti mengenai efektivitas tim interprofesional di layanan primer menegaskan bahwa model berbasis tim meningkatkan akses layanan, koordinasi asuhan, dan pengalaman pasien (Jacobson & Health, 2012). Dalam konteks ini, perawat berkontribusi signifikan melalui pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural pasien.

Optimalisasi peran perawat sebagai *care provider* juga ditopang oleh kebijakan yang mendorong praktik keperawatan sesuai lingkup kompetensi. Laporan kebijakan mengenai optimalisasi peran perawat di layanan primer menunjukkan bahwa pemanfaatan perawat secara penuh dalam tim kolaboratif meningkatkan efisiensi sistem dan kualitas pelayanan, sekaligus mengurangi beban layanan akut (Canadian-Nurses-Association, 2014).

##### **2. Perawat sebagai Komunikator dan Koordinator Layanan**

Komunikasi dan koordinasi merupakan elemen kunci dalam kolaborasi interprofesional, dan perawat sering berada pada posisi sentral dalam kedua fungsi tersebut. Perawat berinteraksi secara intensif dengan pasien, keluarga, dan berbagai profesi kesehatan, sehingga berperan penting dalam memastikan alur informasi klinis yang akurat, tepat waktu, dan berkesinambungan. WHO menekankan bahwa kegagalan komunikasi antartenant kesehatan merupakan

salah satu penyebab utama fragmentasi pelayanan dan risiko keselamatan pasien (Gilbert et al., 2010).

Tinjauan sistematis mengenai pengalaman tenaga kesehatan dalam kolaborasi interprofesional pada edukasi pasien menunjukkan bahwa perawat berperan sebagai penghubung utama antar profesi, khususnya dalam menyampaikan informasi, menyelaraskan rencana perawatan, dan memastikan keterlibatan pasien dalam proses pengambilan keputusan (Tanuwijaya et al., 2023). Peran ini memperkuat kesinambungan asuhan dan meningkatkan pemahaman pasien terhadap rencana perawatan.

Lebih lanjut, bukti empiris di lingkungan rumah sakit menunjukkan bahwa komunikasi interprofesional yang efektif berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas layanan dan keselamatan pasien. Studi mengenai peran komunikasi interprofesional dalam mutu layanan rumah sakit menegaskan bahwa perawat memainkan peran strategis dalam koordinasi layanan lintas profesi, terutama pada situasi klinis yang kompleks dan dinamis (Wahyuningsih & Firmanda, 2025). Dengan demikian, kompetensi komunikasi dan koordinasi menjadi bagian integral dari peran profesional perawat dalam tim interprofesional.

### **3. Perawat sebagai Advokat Pasien**

Peran advokasi merupakan salah satu ciri khas profesi keperawatan dalam praktik kolaborasi interprofesional. Sebagai advokat pasien, perawat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebutuhan, preferensi, dan nilai pasien dipertimbangkan dalam setiap proses pengambilan keputusan klinis. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *client-centred care* yang menempatkan pasien sebagai mitra aktif dalam pelayanan kesehatan.

Pernyataan posisi organisasi profesi keperawatan menegaskan bahwa advokasi pasien merupakan tanggung jawab etis perawat, terutama dalam konteks kolaborasi lintas profesi di mana terdapat potensi ketimpangan kekuasaan dalam pengambilan keputusan klinis (Canadian-Nurse-Association, 2011). Dalam situasi tersebut, perawat berperan menyuarakan kepentingan pasien dan keluarga agar rencana perawatan tetap berorientasi pada kebutuhan individu.

Peran advokasi perawat juga memiliki implikasi penting terhadap keselamatan pasien. Bukti dari kajian mengenai kolaborasi interprofesional dan keselamatan pasien menunjukkan bahwa keterlibatan aktif perawat dalam tim kolaboratif membantu mengidentifikasi risiko klinis lebih dini dan mencegah terjadinya kesalahan pelayanan (Keumalasari et al., 2025). Dengan demikian,

advokasi pasien oleh perawat bukan hanya fungsi etis, tetapi juga strategi penting dalam peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan.

#### **4. Perawat sebagai Mitra Seajar dalam Tim Interprofesional**

Kolaborasi interprofesional yang efektif mensyaratkan hubungan kerja yang setara antarprofesi, termasuk pengakuan terhadap kontribusi dan kompetensi perawat sebagai mitra seajar dalam tim. WHO menekankan bahwa praktik kolaboratif yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila setiap profesi memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan berbagi tanggung jawab pelayanan (WHO, 2010)

Dokumen kebijakan dan sintesis bukti mengenai tim interprofesional menunjukkan bahwa perawat memiliki peran substansial dalam kepemimpinan tim, khususnya pada model pelayanan berbasis komunitas dan layanan primer. Laporan *What If: Interprofessional Care Was the Norm in Canada?* menegaskan bahwa perawat, sebagai kelompok tenaga kesehatan terbesar, memiliki kapasitas untuk memimpin dan mengoordinasikan praktik kolaboratif secara efektif (Canadian-Nurses-Association, 2012).

Dari perspektif teoretis, kemitraan seajar antarprofesi diperkuat melalui *interprofessional education* yang menanamkan nilai saling menghormati, pemahaman peran, dan kerja tim sejak tahap pendidikan. Kerangka kompetensi IPEC menegaskan bahwa kepemimpinan kolaboratif dan kerja tim merupakan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh semua tenaga kesehatan, termasuk perawat (Interprofessional-Education-Collaborative, 2023).

Dengan demikian, perawat sebagai mitra seajar dalam tim interprofesional tidak hanya berkontribusi pada aspek klinis, tetapi juga berperan dalam membangun budaya kolaboratif yang mendukung keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan keberlanjutan sistem kesehatan.

### **E. Bentuk dan Implementasi Kolaborasi Interprofesional dalam Praktik Keperawatan**

---

#### **1. Kolaborasi Perawat dengan Dokter**

Kolaborasi perawat–dokter merupakan bentuk paling fundamental dalam praktik kolaborasi interprofesional. Hubungan ini berfokus pada integrasi pengambilan keputusan klinis, pertukaran informasi yang akurat, serta koordinasi rencana perawatan yang berorientasi pada kebutuhan pasien. Kerangka WHO menekankan bahwa kolaborasi yang efektif antara perawat dan dokter berkontribusi pada kesinambungan asuhan dan penurunan fragmentasi pelayanan (WHO, 2010).

Bukti empiris menunjukkan bahwa model pelayanan berbasis tim yang mengintegrasikan peran perawat dan dokter berdampak positif terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Tinjauan sistematis mengenai strategi kolaborasi interprofesional di rumah sakit melaporkan penurunan insiden keselamatan pasien dan peningkatan kualitas layanan ketika komunikasi dan koordinasi perawat–dokter difasilitasi secara terstruktur (Keumalasari et al., 2025). Selain itu, kajian mengenai peran komunikasi interprofesional menegaskan bahwa kejelasan alur komunikasi antara perawat dan dokter merupakan determinan penting dalam pencegahan kesalahan klinis (Wahyuningsih & Firmanda, 2025).

Dalam praktik keperawatan, kolaborasi perawat–dokter tidak lagi dipahami sebagai hubungan hierarkis semata, melainkan kemitraan profesional yang setara. Pendekatan ini memungkinkan pemanfaatan kompetensi masing-masing profesi secara optimal, khususnya dalam pengelolaan kasus kompleks dan pengambilan keputusan klinis berbasis tim.

## **2. Kolaborasi Perawat dengan Tenaga Kesehatan Lain**

Selain dengan dokter, perawat berkolaborasi secara intensif dengan berbagai tenaga kesehatan lain, seperti farmasis, ahli gizi, fisioterapis, psikolog, dan pekerja sosial. Kolaborasi lintas profesi ini bertujuan untuk memberikan asuhan yang komprehensif dengan mempertimbangkan dimensi klinis, psikologis, sosial, dan fungsional pasien. Sintesis bukti mengenai efektivitas tim interprofesional dalam pelayanan kesehatan primer menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai profesi kesehatan dalam satu tim meningkatkan koordinasi pelayanan, hasil kesehatan pasien, dan pengalaman pasien (Jacobson & Health, 2012). Dalam konteks ini, perawat sering berperan sebagai penghubung antarprofesi yang memastikan integrasi rencana perawatan dan kesinambungan asuhan.

Tinjauan sistematis mengenai pengalaman tenaga kesehatan dalam kolaborasi interprofesional pada edukasi pasien menegaskan bahwa perawat memiliki peran penting dalam menyelaraskan kontribusi profesi lain, khususnya dalam penyampaian informasi, pemantauan kepatuhan pasien, dan evaluasi hasil intervensi (Tanuwijaya et al., 2023). Kolaborasi dengan farmasis, misalnya, berkontribusi pada keamanan penggunaan obat; dengan ahli gizi pada pengelolaan nutrisi; serta dengan fisioterapis dan psikolog pada pemulihan fungsi dan kesejahteraan psikososial pasien.



Dengan demikian, kolaborasi perawat dengan tenaga kesehatan lain memperkuat pendekatan holistik dalam praktik keperawatan dan meningkatkan mutu pelayanan secara keseluruhan.

### **3. Kolaborasi Lintas Sektor: Kesehatan, Sosial, dan Pendidikan**

Kolaborasi interprofesional dalam praktik keperawatan tidak terbatas pada sektor kesehatan, tetapi juga mencakup kerja sama lintas sektor dengan bidang sosial dan pendidikan. Pendekatan lintas sektor menjadi semakin relevan dalam menghadapi determinan sosial kesehatan yang memengaruhi status kesehatan individu dan komunitas. Kerangka WHO menegaskan bahwa praktik kolaboratif yang berorientasi pada masyarakat memerlukan integrasi layanan kesehatan dengan sektor sosial dan pendidikan untuk mencapai hasil kesehatan yang berkelanjutan (WHO, 2010). Dalam konteks ini, perawat berperan sebagai penghubung antara layanan kesehatan formal dan sumber daya komunitas, seperti layanan sosial, institusi pendidikan, dan organisasi masyarakat.

Dokumen kebijakan dan laporan praktik di layanan primer menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor berkontribusi pada peningkatan manajemen penyakit kronis, promosi kesehatan, dan pencegahan masalah kesehatan di tingkat komunitas (Canadian-Nurses-Association, 2012). Perawat, melalui peran edukatif dan advokatifnya, memfasilitasi koordinasi lintas sektor guna memastikan dukungan yang komprehensif bagi pasien dan keluarga. Kolaborasi lintas sektor ini memperluas cakupan praktik keperawatan dari pelayanan kuratif menuju pendekatan promotif dan preventif yang berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

Kolaborasi lintas sektor dalam praktik keperawatan tidak hanya berfungsi sebagai perluasan jejaring pelayanan, tetapi merupakan respons sistemik terhadap determinan sosial kesehatan yang tidak dapat ditangani oleh sektor kesehatan secara terpisah. *European Forum for Primary Care* menegaskan bahwa kebutuhan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks menuntut integrasi pelayanan kesehatan primer dengan sektor sosial dan pendidikan, khususnya dalam pengelolaan kondisi kronis, kesehatan mental, serta promosi dan pencegahan kesehatan berbasis komunitas (Samuelson et al., 2012).

Lebih lanjut, pendekatan kolaboratif lintas sektor memungkinkan terbentuknya *collective competence*, yaitu kapasitas tim lintas profesi dan sektor yang melampaui kompetensi individual masing-masing aktor. Leathard menekankan bahwa integrasi kebijakan dan praktik lintas sektor menjadi prasyarat penting agar kolaborasi tidak berhenti pada level koordinasi administratif, tetapi menghasilkan perubahan bermakna dalam kualitas

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (Leathard, 2005). Dalam konteks komunitas dan layanan berbasis anak serta keluarga, kolaborasi lintas sektor terbukti memperluas akses layanan, mengurangi duplikasi intervensi, serta meningkatkan keberlanjutan dukungan bagi individu dan keluarga. Studi mengenai kolaborasi sekolah–keluarga–komunitas menunjukkan bahwa keterlibatan perawat dan profesional kesehatan lain dalam jejaring lintas sektor berkontribusi pada efektivitas intervensi kesehatan dan sosial secara simultan (Mellin et al., 2011).

#### **4. Kolaborasi Interprofesional di Berbagai Tataan Layanan**

Implementasi kolaborasi interprofesional dalam praktik keperawatan bervariasi sesuai dengan tataan layanan kesehatan, termasuk rumah sakit, pelayanan kesehatan primer, dan komunitas. Setiap tataan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri yang memengaruhi bentuk kolaborasi yang diterapkan. Di rumah sakit, kolaborasi interprofesional berfokus pada koordinasi pelayanan akut, keselamatan pasien, dan pengelolaan kasus kompleks. Studi mengenai strategi kolaborasi interprofesional di rumah sakit menunjukkan bahwa penerapan protokol komunikasi, ronde kolaboratif, dan pelatihan bersama berkontribusi terhadap penurunan insiden keselamatan pasien dan peningkatan kualitas layanan (Keumalasari et al., 2025).

Pada pelayanan kesehatan primer, kolaborasi interprofesional menekankan kesinambungan asuhan, manajemen penyakit kronis, dan pendekatan berbasis keluarga. Sintesis bukti mengenai tim interprofesional di layanan primer menunjukkan bahwa model berbasis tim meningkatkan akses layanan, efisiensi sistem, dan kepuasan pasien (Jacobson & Health, 2012). Dalam konteks ini, perawat memainkan peran penting sebagai koordinator asuhan dan penghubung antara layanan klinis dan komunitas.

Di tataan komunitas, kolaborasi interprofesional berfokus pada promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemberdayaan masyarakat. Laporan kebijakan mengenai optimalisasi peran perawat menegaskan bahwa perawat memiliki kapasitas untuk memimpin dan mengoordinasikan praktik kolaboratif di komunitas, khususnya dalam menjangkau kelompok rentan dan meningkatkan literasi kesehatan masyarakat (Canadian-Nurses-Association, 2014). Dengan demikian, implementasi kolaborasi interprofesional dalam praktik keperawatan bersifat kontekstual dan adaptif, namun tetap berlandaskan prinsip komunikasi efektif, pengambilan keputusan bersama, dan orientasi pada kebutuhan pasien.

## **F. Tantangan dan Hambatan Kolaborasi Interprofesional**

---

### **1. Hambatan Struktural dan Organisasi**

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kolaborasi interprofesional adalah hambatan struktural dan organisasi dalam sistem pelayanan kesehatan. Hambatan ini mencakup tata kelola organisasi yang belum mendukung kerja tim lintas profesi, kebijakan internal yang masih berorientasi profesi tunggal, serta keterbatasan sumber daya yang menghambat koordinasi pelayanan. Kerangka WHO menegaskan bahwa tanpa dukungan institusional yang memadai seperti model tata kelola kolaboratif, kebijakan sumber daya manusia, dan alokasi waktu kerja tim praktik kolaboratif cenderung bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan (WHO, 2010).

Bukti empiris dari layanan kesehatan primer menunjukkan bahwa struktur organisasi yang tidak mendukung pembagian peran dan tanggung jawab lintas profesi berkontribusi pada fragmentasi pelayanan dan duplikasi intervensi. Sintesis bukti mengenai efektivitas tim interprofesional di layanan primer mengidentifikasi bahwa ketiadaan mekanisme koordinasi formal dan dukungan manajerial menjadi penghambat utama keberhasilan kerja tim (Jacobson & Health, 2012).

Di lingkungan rumah sakit, hambatan struktural juga muncul dalam bentuk alur kerja yang terpisah antarunit dan sistem dokumentasi yang tidak terintegrasi. Kondisi ini menyulitkan pertukaran informasi klinis dan memperbesar risiko kesalahan pelayanan, khususnya pada pasien dengan kondisi kompleks yang memerlukan keterlibatan banyak profesi.

### **2. Hambatan Komunikasi Interprofesional**

Komunikasi yang tidak efektif merupakan hambatan paling sering dilaporkan dalam praktik kolaborasi interprofesional. Hambatan ini mencakup perbedaan terminologi profesional, kurangnya kejelasan informasi, serta keterbatasan waktu untuk melakukan diskusi lintas profesi. WHO menekankan bahwa kegagalan komunikasi antartenant kesehatan berkontribusi signifikan terhadap fragmentasi pelayanan dan risiko keselamatan pasien (Gilbert et al., 2010).

Tinjauan sistematis mengenai peran komunikasi interprofesional dalam mutu layanan rumah sakit menunjukkan bahwa miskomunikasi antarprofesi berkorelasi dengan meningkatnya insiden keselamatan pasien dan menurunnya kualitas layanan. Studi tersebut juga menegaskan bahwa perawat sering berada pada posisi kunci dalam menjembatani komunikasi lintas profesi, namun peran

ini tidak selalu didukung oleh sistem yang memadai (Wahyuningsih & Firmanda, 2025).

Selain itu, kajian mengenai pengalaman tenaga kesehatan dalam kolaborasi interprofesional pada edukasi pasien menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi yang terstruktur antarprofesi dapat menghambat konsistensi pesan yang diterima pasien, sehingga berdampak pada pemahaman dan kepatuhan pasien terhadap rencana perawatan (Tanuwijaya et al., 2023). Hambatan komunikasi ini menunjukkan bahwa kolaborasi interprofesional memerlukan strategi komunikasi yang sistematis dan berkelanjutan.

### **3. Hambatan Budaya Profesi dan Hierarki**

Perbedaan budaya profesi dan hierarki dalam pelayanan kesehatan merupakan tantangan signifikan dalam implementasi kolaborasi interprofesional. Setiap profesi kesehatan memiliki nilai, norma, dan cara kerja yang terbentuk melalui proses pendidikan dan sosialisasi profesional. Perbedaan ini dapat memperkaya perspektif dalam tim, namun juga berpotensi menimbulkan konflik dan hambatan kolaborasi apabila tidak dikelola dengan baik.

Dokumen kebijakan dan pernyataan posisi profesi keperawatan menegaskan bahwa budaya hierarkis dalam sistem kesehatan sering kali membatasi partisipasi perawat dalam pengambilan keputusan klinis. Kondisi ini dapat menghambat terwujudnya kemitraan sejajar antarprofesi dan mengurangi efektivitas kolaborasi (Canadian-Nurse-Association, 2011). Laporan *What If: Interprofessional Care Was the Norm in Canada?* juga mengidentifikasi bahwa kegagalan memanfaatkan kompetensi perawat secara optimal sering kali berakar pada struktur hierarkis yang menghambat kolaborasi setara. Padahal, bukti menunjukkan bahwa model pelayanan berbasis tim yang setara antarprofesi memberikan hasil kesehatan yang lebih baik dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien (Canadian-Nurses-Association, 2012).

Dalam konteks ini, hambatan budaya profesi dan hierarki tidak dapat diatasi hanya melalui kebijakan teknis, tetapi memerlukan perubahan budaya organisasi dan penguatan nilai kolaboratif lintas profesi. Hambatan budaya profesi dan hierarki dalam kolaborasi interprofesional tidak hanya bersumber dari perbedaan individu, tetapi juga dari konstruksi historis dan kebijakan yang membentuk relasi kekuasaan antarprofesi. Leathard menjelaskan bahwa struktur profesional yang kaku dan dominasi profesi tertentu sering kali menghambat terciptanya kolaborasi yang setara, meskipun secara normatif kolaborasi telah diakui sebagai kebutuhan sistem pelayanan kesehatan (Leathard, 2005).

Temuan empiris terbaru dalam konteks pelayanan kesehatan primer menunjukkan bahwa kejelasan peran, pengakuan terhadap kontribusi masing-masing profesi, serta ruang refleksi tim menjadi faktor kunci dalam mengurangi dampak negatif hierarki dan memperkuat kolaborasi lintas profesi. Studi Ashcroft et al. menegaskan bahwa penguatan kapasitas kolaboratif memerlukan upaya sadar untuk membangun budaya kerja yang menghargai perspektif non-medis dan mendorong partisipasi setara seluruh anggota tim (Ashcroft et al., 2024).

#### **4. Keterbatasan Kompetensi Kolaboratif**

Hambatan lain yang signifikan adalah keterbatasan kompetensi kolaboratif tenaga kesehatan. Kompetensi kolaboratif mencakup kemampuan komunikasi interprofesional, pemahaman peran dan tanggung jawab profesi lain, serta keterampilan kerja tim dan kepemimpinan kolaboratif. WHO menegaskan bahwa banyak tenaga kesehatan belum dipersiapkan secara memadai untuk bekerja dalam tim interprofesional karena sistem pendidikan yang masih terpisah antarprofesi (WHO, 2010).

Keterbatasan kompetensi kolaboratif ini berdampak pada praktik keperawatan, khususnya dalam peran perawat sebagai koordinator dan mitra seajar dalam tim. Tanpa kompetensi yang memadai, kolaborasi berisiko menjadi formalitas administratif tanpa integrasi nyata dalam praktik pelayanan. WHO *Study Group* menekankan bahwa penguatan *interprofessional education* merupakan strategi kunci untuk mengatasi kesenjangan kompetensi ini dan membangun tenaga kesehatan yang siap berkolaborasi (Yan et al., 2006). Dengan demikian, keterbatasan kompetensi kolaboratif harus dipahami sebagai tantangan sistemik yang memerlukan intervensi pada level pendidikan, organisasi, dan kebijakan.

#### **5. Implikasi Hambatan Kolaborasi bagi Praktik Keperawatan**

Berbagai hambatan kolaborasi interprofesional memiliki implikasi langsung terhadap praktik keperawatan. Hambatan struktural, komunikasi, budaya profesi, dan kompetensi kolaboratif dapat mengurangi efektivitas peran perawat sebagai *care provider*, koordinator, dan advokat pasien. Kondisi ini berpotensi berdampak pada mutu asuhan, keselamatan pasien, serta kepuasan kerja perawat. Bukti empiris menunjukkan bahwa kegagalan kolaborasi interprofesional berkontribusi terhadap fragmentasi pelayanan dan peningkatan risiko keselamatan pasien, khususnya di lingkungan pelayanan yang kompleks seperti rumah sakit (Keumalasari et al., 2025). Oleh karena itu,

identifikasi dan pemahaman terhadap tantangan dan hambatan kolaborasi menjadi langkah awal yang penting dalam pengembangan strategi penguatan kolaborasi interprofesional.

## **G. Strategi Penguatan Kolaborasi Interprofesional**

---

### **1. Penguatan Kolaborasi melalui Pendidikan Interprofesional**

Penguatan kolaborasi interprofesional harus dimulai dari sistem pendidikan tenaga kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa *interprofessional education* (IPE) merupakan fondasi untuk membentuk tenaga kesehatan yang siap berkolaborasi (*collaborative practice-ready workforce*). Tanpa IPE yang terintegrasi, praktik kolaboratif cenderung tidak konsisten dan sulit dipertahankan dalam jangka panjang (WHO, 2010).

Tinjauan naratif yang mengkaji keterkaitan antara IPE dan *interprofessional collaborative practice* (IPCP) menunjukkan bahwa strategi pendidikan berbasis kompetensi—meliputi nilai/etika kolaboratif, kejelasan peran, komunikasi interprofesional, serta kerja tim—berdampak pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap kolaboratif, dan kualitas pelayanan kesehatan. Studi ini juga menekankan pentingnya kesinambungan antara pembelajaran di institusi pendidikan dan praktik di lahan klinik agar kompetensi kolaboratif dapat diaplikasikan secara nyata (Gautama et al., 2023).

Model-model praktik terbaik IPE menunjukkan bahwa penguatan kolaborasi dapat dilakukan melalui pendekatan didaktik terstruktur, pembelajaran berbasis komunitas, serta simulasi interprofesional. Model-model tersebut menekankan pengembangan identitas profesional yang kuat sekaligus pemahaman lintas peran, sehingga lulusan tenaga kesehatan siap bekerja dalam tim kolaboratif sejak awal praktik (Bridges et al., 2011). Dengan demikian, pendidikan interprofesional perlu dirancang sebagai proses berkelanjutan yang menghubungkan kurikulum, pelatihan klinis, dan kebutuhan sistem pelayanan kesehatan.

### **2. Penguatan Kolaborasi pada Tingkat Organisasi Pelayanan Kesehatan**

Selain pendidikan, penguatan kolaborasi interprofesional memerlukan dukungan organisasi pelayanan kesehatan. Struktur organisasi, tata kelola tim, serta budaya kerja sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kolaborasi. Kerangka WHO menegaskan bahwa organisasi pelayanan kesehatan perlu menyediakan mekanisme formal yang mendukung kerja tim, seperti alokasi waktu kolaborasi, sistem komunikasi terintegrasi, dan kepemimpinan yang mendukung praktik kolaboratif (Gilbert et al., 2010)

Studi mutakhir mengenai tim pelayanan kesehatan primer menunjukkan bahwa penguatan kolaborasi memerlukan kejelasan peran, pengakuan terhadap kontribusi setiap profesi, serta ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi proses kerja tim. Ashcroft et al. menegaskan bahwa kapasitas kolaboratif tidak terbentuk secara otomatis, melainkan harus dibangun melalui strategi organisasi yang disengaja, termasuk pelatihan lintas profesi dan pengembangan kompetensi kontekstual sesuai karakteristik layanan primer (Ashcroft et al., 2024).

Dalam konteks rumah sakit, strategi organisasi yang efektif meliputi penerapan protokol komunikasi interprofesional, ronde kolaboratif, dan sistem dokumentasi bersama. Bukti empiris menunjukkan bahwa strategi-strategi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan pasien dan kualitas layanan, sekaligus memperkuat peran perawat sebagai koordinator dan penghubung antarprofesi.

### **3. Strategi Penguatan Kolaborasi melalui Kebijakan dan Tata Kelola Sistem**

Penguatan kolaborasi interprofesional tidak dapat dilepaskan dari dukungan kebijakan dan tata kelola sistem kesehatan. *European Forum for Primary Care* menekankan bahwa kolaborasi interprofesional memerlukan kebijakan yang mendukung *skill-mix*, perencanaan tenaga kesehatan, serta model pembiayaan yang mendorong kerja tim lintas profesi. Kebijakan yang masih berorientasi profesi tunggal berpotensi menghambat implementasi kolaborasi di tingkat layanan (Samuelson et al., 2012).

Leathard menegaskan bahwa transisi dari kebijakan menuju praktik kolaboratif memerlukan keselarasan antara regulasi, pendidikan, dan organisasi pelayanan. Tanpa integrasi kebijakan lintas sektor dan lintas profesi, kolaborasi berisiko tereduksi menjadi koordinasi administratif tanpa dampak substantif terhadap mutu pelayanan (Leathard, 2005). Dalam konteks sistem kesehatan, kebijakan yang mendukung kolaborasi interprofesional perlu mencakup pengakuan terhadap peran perawat sebagai aktor kunci dalam koordinasi pelayanan, advokasi pasien, dan kepemimpinan tim. Dukungan kebijakan ini menjadi prasyarat bagi keberlanjutan praktik kolaboratif di berbagai tatanan layanan.

### **4. Penguatan Kolaborasi melalui Pendekatan Lintas Sektor dan Komunitas**

Kolaborasi interprofesional yang kuat perlu diperluas ke pendekatan lintas sektor, khususnya pada layanan berbasis komunitas. Tantangan kesehatan yang dipengaruhi oleh determinan sosial menuntut integrasi layanan kesehatan

dengan sektor sosial dan pendidikan. Studi mengenai kolaborasi dalam konteks sekolah dan komunitas menunjukkan bahwa kerja tim lintas profesi dan lintas sektor meningkatkan akses layanan, mengurangi duplikasi intervensi, serta memperkuat dukungan berkelanjutan bagi individu dan keluarga (Mellin et al., 2011).

Model kolaborasi lintas sektor menekankan pentingnya interdependensi peran, pembentukan aktivitas profesional baru, serta refleksi bersama terhadap proses kerja tim. Kerangka ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif memungkinkan terciptanya *collective competence*, yaitu kapasitas kolektif yang melampaui kompetensi individual masing-masing profesi (Mellin et al., 2010).

Dalam praktik keperawatan, pendekatan lintas sektor memperluas peran perawat dari pemberi asuhan klinis menjadi fasilitator jejaring layanan dan agen penghubung antara sistem kesehatan dan sumber daya komunitas. Strategi ini relevan untuk memperkuat promosi kesehatan, pencegahan penyakit, serta penanganan masalah kesehatan yang kompleks dan multidimensional.

## **5. Monitoring dan Evaluasi Kolaborasi Interprofesional**

Keberhasilan strategi penguatan kolaborasi interprofesional perlu diikuti dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang sistematis. Evaluasi kolaborasi tidak hanya berfokus pada hasil klinis, tetapi juga pada proses kerja tim, kualitas komunikasi, dan tingkat interdependensi antarprofesi. Pengembangan instrumen pengukuran kolaborasi memungkinkan organisasi dan peneliti untuk menilai efektivitas tim serta mengidentifikasi area perbaikan (Mellin et al., 2010).

Pendekatan evaluatif ini penting untuk memastikan bahwa kolaborasi interprofesional berkembang secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan layanan. Dengan adanya data evaluasi yang sistematis, strategi penguatan kolaborasi dapat disesuaikan dan ditingkatkan sesuai konteks praktik keperawatan.

## **6. Sintesis Strategi Penguatan Kolaborasi Interprofesional**

Secara keseluruhan, penguatan kolaborasi interprofesional memerlukan pendekatan multi-level yang mencakup pendidikan, organisasi, kebijakan, dan komunitas. Strategi-strategi tersebut saling terkait dan tidak dapat diimplementasikan secara terpisah. Bab ini menegaskan bahwa kolaborasi interprofesional bukan sekadar keterampilan individual, melainkan praktik sistemik yang memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan.



Bagi keperawatan, strategi penguatan kolaborasi interprofesional mempertegas peran perawat sebagai aktor kunci dalam transformasi pelayanan kesehatan. Bab ini menjadi landasan untuk memahami bagaimana kolaborasi interprofesional dapat menghasilkan dampak nyata terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien, yang akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

## **H. Dampak Kolaborasi Interprofesional Terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan**

### **1. Dampak Kolaborasi Interprofesional terhadap Keselamatan Pasien**

Keselamatan pasien merupakan indikator utama mutu pelayanan kesehatan dan menjadi salah satu justifikasi terkuat bagi penerapan kolaborasi interprofesional. Sistem pelayanan yang terfragmentasi dan minim komunikasi lintas profesi telah lama diidentifikasi sebagai faktor risiko terjadinya kesalahan medis dan insiden keselamatan pasien. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa praktik kolaboratif interprofesional berkontribusi signifikan terhadap pengurangan risiko keselamatan pasien melalui peningkatan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan bersama (Gilbert et al., 2010).

Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa strategi kolaborasi interprofesional yang terstruktur, seperti ronde kolaboratif dan protokol komunikasi lintas profesi, berdampak pada penurunan insiden keselamatan pasien di lingkungan rumah sakit. Tinjauan sistematis mengenai intervensi kolaborasi interprofesional di rumah sakit melaporkan perbaikan dalam pencegahan kesalahan klinis, peningkatan pelaporan insiden, serta penguatan budaya keselamatan pasien (Keumalasari et al., 2025).

Dalam praktik keperawatan, perawat memiliki peran sentral dalam menjaga keselamatan pasien karena keterlibatan langsung dan berkelanjutan dalam asuhan. Kolaborasi interprofesional memperkuat kemampuan perawat untuk mengidentifikasi risiko klinis secara dini, menyampaikan informasi kritis kepada profesi lain, serta memastikan tindak lanjut intervensi yang aman dan tepat waktu.

### **2. Dampak terhadap Kualitas dan Kontinuitas Asuhan Keperawatan**

Kolaborasi interprofesional juga berdampak langsung pada kualitas dan kontinuitas asuhan keperawatan. Pelayanan kesehatan yang melibatkan berbagai profesi secara terintegrasi memungkinkan perencanaan asuhan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Sintesis bukti mengenai efektivitas tim interprofesional di pelayanan kesehatan primer menunjukkan bahwa kolaborasi lintas profesi meningkatkan koordinasi asuhan,

kesinambungan layanan, dan hasil kesehatan pasien, khususnya pada pengelolaan penyakit kronis (Jacobson & Health, 2012).

Dalam konteks keperawatan, kolaborasi interprofesional mendukung peran perawat sebagai koordinator asuhan yang memastikan transisi pelayanan berjalan lancar, baik antar unit maupun antar level layanan. Laporan kebijakan mengenai optimalisasi peran perawat di layanan primer menunjukkan bahwa keterlibatan perawat dalam tim kolaboratif berkontribusi pada peningkatan kualitas asuhan, penguatan pendekatan holistik, serta efisiensi sistem pelayanan kesehatan (Canadian-Nurses-Association, 2014). Kualitas asuhan keperawatan yang ditopang oleh kolaborasi interprofesional juga tercermin dalam konsistensi intervensi, kesesuaian rencana perawatan dengan kebutuhan pasien, serta integrasi aspek klinis dan psikososial dalam asuhan.

### **3. Dampak terhadap Kepuasan Pasien dan Keluarga**

Kepuasan pasien dan keluarga merupakan indikator penting keberhasilan pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien. Kolaborasi interprofesional memungkinkan pasien menerima pelayanan yang lebih terkoordinasi, informatif, dan responsif. Studi mengenai pengalaman tenaga kesehatan dalam kolaborasi interprofesional pada edukasi pasien menunjukkan bahwa kolaborasi lintas profesi meningkatkan konsistensi pesan, pemahaman pasien, dan keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan (Tanuwijaya et al., 2023).

Pendekatan kolaboratif juga mendukung prinsip *client-centred care*, di mana pasien dan keluarga diposisikan sebagai mitra aktif dalam pelayanan. Dalam praktik keperawatan, kolaborasi interprofesional memperkuat peran perawat sebagai advokat pasien yang memastikan suara pasien terakomodasi dalam rencana perawatan. Hal ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan pasien terhadap sistem pelayanan dan kepuasan terhadap asuhan yang diterima.

### **4. Dampak terhadap Kepuasan dan Kesejahteraan Perawat**

Selain berdampak pada pasien, kolaborasi interprofesional juga berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan kesejahteraan perawat. Lingkungan kerja yang kolaboratif memungkinkan perawat bekerja sesuai kompetensi, memperoleh dukungan profesional, serta berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan klinis. Laporan kebijakan dan studi praktik menunjukkan bahwa kerja tim interprofesional berkontribusi pada penurunan beban kerja individual, peningkatan dukungan profesional, dan pengurangan risiko kelelahan kerja (*burnout*) (Canadian-Nurses-Association, 2012).

Kolaborasi yang setara antarprofesi juga meningkatkan pengakuan terhadap kontribusi perawat dalam tim pelayanan kesehatan. Hal ini memperkuat identitas profesional perawat dan meningkatkan motivasi dalam memberikan asuhan yang bermutu. Dengan demikian, kolaborasi interprofesional tidak hanya berdampak pada mutu pelayanan, tetapi juga pada keberlanjutan praktik keperawatan melalui peningkatan kesejahteraan tenaga keperawatan.

## **5. Implikasi Dampak Kolaborasi bagi Pengembangan Praktik Keperawatan**

Dampak positif kolaborasi interprofesional terhadap keselamatan pasien, kualitas asuhan, dan kepuasan pasien serta perawat menunjukkan bahwa kolaborasi merupakan strategi kunci dalam pengembangan praktik keperawatan modern. Namun, dampak tersebut hanya dapat dicapai apabila kolaborasi diimplementasikan secara sistematis dan didukung oleh pendidikan, organisasi, dan kebijakan yang memadai.

Temuan dari berbagai kajian menegaskan bahwa kolaborasi interprofesional bukan sekadar pendekatan normatif, melainkan praktik berbasis bukti yang memberikan nilai tambah nyata bagi sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, integrasi kolaborasi interprofesional dalam praktik keperawatan perlu dipandang sebagai investasi strategis dalam peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan.

## **6. Sintesis Dampak Kolaborasi Interprofesional**

Secara keseluruhan, kolaborasi interprofesional memberikan dampak multidimensional terhadap mutu pelayanan keperawatan, mencakup aspek keselamatan, kualitas asuhan, kepuasan pasien, dan kesejahteraan perawat. Dampak ini memperkuat posisi kolaborasi interprofesional sebagai pilar penting dalam transformasi pelayanan kesehatan. Hal ini menegaskan bahwa kolaborasi interprofesional bukan hanya kebutuhan konseptual, tetapi praktik nyata yang memberikan manfaat signifikan bagi pasien, tenaga kesehatan, dan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

### **I. Penutup**

---

Kolaborasi interprofesional merupakan pendekatan strategis yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di tengah kompleksitas kebutuhan kesehatan masyarakat. Melalui pembahasan konseptual, teoretis, hingga implementatif, book chapter ini menegaskan bahwa kolaborasi

interprofesional bukan sekadar pilihan praktik, melainkan kebutuhan sistemik dalam pelayanan keperawatan modern.

Perawat memiliki peran kunci dalam praktik kolaborasi interprofesional, baik sebagai pemberi asuhan, koordinator layanan, advokat pasien, maupun mitra sejajar dalam tim pelayanan kesehatan. Posisi strategis ini menempatkan perawat sebagai penghubung utama yang memastikan kesinambungan asuhan, keselamatan pasien, dan pendekatan pelayanan yang berpusat pada pasien dan keluarga.

Implementasi kolaborasi interprofesional menghadapi berbagai tantangan, mulai dari hambatan struktural, komunikasi, budaya profesi, hingga keterbatasan kompetensi kolaboratif. Namun demikian, strategi penguatan melalui pendidikan interprofesional, dukungan organisasi, kebijakan yang kondusif, serta pendekatan lintas sektor menunjukkan potensi besar dalam membangun praktik kolaboratif yang efektif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kolaborasi interprofesional terbukti memberikan dampak positif terhadap keselamatan pasien, kualitas asuhan keperawatan, kepuasan pasien dan keluarga, serta kesejahteraan perawat. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi interprofesional perlu terus diintegrasikan dalam praktik, pendidikan, dan kebijakan keperawatan sebagai bagian dari transformasi sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi pada mutu dan keselamatan.

## J. Daftar Pustaka

- 
- Ashcroft, R., Bobbette, N., Moodie, S., Miller, J., Adamson, K., Smith, M. A., & Donnelly, C. (2024). Strengthening collaboration for interprofessional primary care teams: Insights and key learnings from six disciplinary perspectives. *Healthcare Management Forum*, 37, 568–575. <https://doi.org/10.1177/08404704241266763>
- Bosch, B., & Mansell, H. (2015). Interprofessional collaboration in health care: Lessons to be learned from competitive sports. *Canadian Pharmaceutical Journal*, 148(4), 2–5. <https://doi.org/10.1177/1715163515588106>
- Bridges, D. R., Davidson, R. A., Odegard, P. S., Maki, I. V., & Tomkowiak, J. (2011). Interprofessional collaboration: three best practice models of interprofessional education. *Medical Education Online*, 1, 1–10. <https://doi.org/10.3402/meo.v16i0.6035>
- Canadian-Nurse-Association. (2011). *INTERPROFESSIONAL COLLABORATION* (Vol. 9).
- Canadian-Nurses-Association. (2012). *WHAT IF: INTERPROFESSIONAL CARE WAS THE NORM IN CANADA?* (pp. 1–3).

- Canadian-Nurses-Association. (2014). *Optimizing the Role of Nurses in Primary Care in Canada* (Issue August).
- Gautama, M. S. N., Kharismawati, F. A., Astuti, L. F., Maulidyati, & Hidayatulloh, A. (2023). Collaboration between interprofessional education (IPE) and interprofessional collaborative practice (IPCP) in health education: A narrative review. *Journal of Holistic Nursing Science*, 10(2), 73–81. <https://doi.org/10.31603/nursing.v0i0.8801>
- Gilbert, J. H. V, Yan, J., & Hoffman, S. J. (2010). *A WHO Report: Framework for Action on Interprofessional Education and Collaborative Practice* (pp. 2–3).
- Interprofessional-Education-Collaborative. (2023). *IPEC - CORE COMPETENCIES FOR INTERPROFESSIONAL COLLABORATIVE PRACTICE: VERSION 3*.
- Jacobson, P. M., & Health, C. (2012). *Evidence Synthesis for the Effectiveness of Interprofessional Teams in Primary Care* (Issue June).
- Keumalasari, Yetti, K., Novieastari, E., & Martha, E. (2025). The Strategies and Interventions for Interprofessional Collaboration to Improving Patient Safety in Hospitals: A Systematic Review. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 28(May), 141–156. <https://doi.org/10.7454/jki.v28i2.1148>
- Leathard, A. (2005). *Interprofessional Collaboration*.
- Manser, T. (2009). Teamwork and patient safety in dynamic domains of healthcare: a review of the literature. *ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA*, 53, 143–151. <https://doi.org/10.1111/j.1399-6576.2008.01717.x>
- Mellin, E. A., Anderson-Butcher, D., & Bronstein, L. (2011). Strengthening Inter professional Team Collaboration: Potential Roles for School Mental Health Professionals. *Advances in School Mental Health Promotion*, 4(2), 51–61.
- Mellin, E. A., Bronstein, L., Anderson-butcher, D., Amorose, A. J., Ball, A., & Green, J. (2010). Measuring interprofessional team collaboration in expanded school mental health: Model refinement and scale development. *Journal of Interprofessional Care*, 2001, 1–10. <https://doi.org/10.3109/13561821003624622>
- Reeves, S., Xyrichis, A., Zwarenstein, M., Reeves, S., & Xyrichis, A. (2018). Teamwork , collaboration , coordination , and networking : Why we need to distinguish between different types of interprofessional practice distinguish between different types of interprofessional practice. *Journal of Interprofessional Care*, 32(1), 1–3. <https://doi.org/10.1080/13561820.2017.1400150>
- Samuelson, M., Tedeschi, P., & Groenewegen, P. (2012). Improving interprofessional collaboration in primary care: Position Paper of the European Forum for Primary Care. *Quality in Primary Care*, 20, 303–312.
- Tanuwijaya, J., Ting, M., See, A., Jia, A., Tan, Q., Levett-jones, T., Ching, T., Zhou, W., & Ying, S. (2023). Healthcare professionals ' experiences of interprofessional

collaboration in patient education : A systematic review. *Patient Education and Counseling*, 116(November 2022), 107965.  
<https://doi.org/10.1016/j.pec.2023.107965>

- Wahyuningsih, A., & Firmanda, G. I. (2025). The Role of Interprofessional Communication in Enhancing the Quality of Hospital Health Services: A Scoping Review. *JMMR/Jurnal Medicoeticolegal Dan Manajemen Rumah Sakit*, 14(2), 230–241.
- WHO. (2010). *Human Resources for Health Framework for Action on Interprofessional Education & Collaborative Practice*.
- Yan, J., Gilbert, J. H. V, & Hoffman, S. J. (2006). *World Health Organization Study Group on Interprofessional Education and Collaborative Practice. Exhibit 1*, 588–589.



# CHAPTER 6

## PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM KEPERAWATAN: TELE-NURSING, MOBILE APPS, DAN PERALATAN KLINIS MODERN

Ulfa Munawaroh Diniyah, S.Kep., Ns.

### A. Pendahuluan

---

Transformasi digital dalam sistem pelayanan kesehatan merupakan keniscayaan yang tidak terpisahkan dari dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks praktik keperawatan, perubahan ini menghadirkan tantangan yang semakin kompleks, antara lain meningkatnya beban kerja perawat, ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan, serta tuntutan akan kontinuitas asuhan keperawatan yang berkesinambungan dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Kondisi tersebut semakin nyata pada populasi dengan penyakit kronis, kelompok rentan, serta masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan sumber daya pelayanan kesehatan (Chaharsoughi et al., 2022).

Perawat sebagai tenaga profesional yang memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan asuhan keperawatan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Peran perawat tidak lagi terbatas pada pemberian asuhan secara langsung, tetapi berkembang sebagai agen transformasi yang mengintegrasikan teknologi ke dalam proses keperawatan. Melalui pemanfaatan teknologi, perawat berperan dalam mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis bukti, memperluas jangkauan pelayanan, serta meningkatkan efektivitas komunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarga. Integrasi teknologi dalam praktik keperawatan menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan secara berkelanjutan (Wang et al., 2024).

Pemanfaatan teknologi dalam keperawatan memiliki relevansi yang kuat terhadap peningkatan mutu, keselamatan, dan efisiensi asuhan keperawatan. Penggunaan teknologi digital memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara lebih akurat dan berkesinambungan, memperbaiki kualitas dokumentasi keperawatan, serta meminimalkan risiko kesalahan dalam pemberian asuhan. Selain itu, teknologi juga mendukung efisiensi penggunaan waktu dan sumber



daya, sehingga perawat dapat lebih fokus pada aspek klinis dan humanistik dalam pemberian asuhan keperawatan (Mohammadnejad et al., 2023).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, book chapter ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji secara komprehensif inovasi praktik keperawatan melalui pemanfaatan teknologi di berbagai bidang keperawatan, meliputi keperawatan medikal bedah, maternitas, anak, jiwa, komunitas, dan gerontik. Pembahasan difokuskan pada penerapan tele-nursing, penggunaan aplikasi berbasis mobile, serta pemanfaatan peralatan klinis modern sebagai strategi inovatif dalam mendukung peningkatan kualitas asuhan keperawatan dan penguatan peran profesional perawat di era digital.

## **B. Konsep Dasar Pemanfaatan Teknologi dalam Keperawatan**

---

Pemanfaatan teknologi dalam praktik keperawatan merupakan manifestasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Dalam konteks keperawatan, teknologi kesehatan dipahami sebagai keseluruhan perangkat, sistem, dan aplikasi berbasis digital maupun mekanik yang digunakan untuk mendukung proses keperawatan secara komprehensif, mulai dari pengelolaan data pasien, pelaksanaan intervensi keperawatan, hingga evaluasi hasil asuhan. Kehadiran teknologi dalam praktik keperawatan tidak dimaknai sebagai pengganti peran perawat, melainkan sebagai sarana pendukung yang memperkuat kemampuan perawat dalam memberikan asuhan yang aman, efektif, dan berbasis bukti ilmiah (Schlicht et al., 2024).

Landasan teoretis yang mendasari pemanfaatan teknologi dalam keperawatan berakar pada konsep Nursing Informatics, suatu disiplin ilmu yang mengintegrasikan ilmu keperawatan dengan ilmu informasi dan ilmu komputer. *Nursing Informatics* berfokus pada pengelolaan data, informasi, dan pengetahuan keperawatan untuk mendukung pengambilan keputusan klinis dan manajerial. Melalui pendekatan ini, data klinis yang dihasilkan dalam praktik keperawatan diolah secara sistematis menjadi informasi yang bermakna dan selanjutnya dikonversi menjadi pengetahuan yang dapat digunakan dalam praktik keperawatan berbasis bukti. Dengan demikian, *Nursing Informatics* berperan strategis dalam meningkatkan akurasi pengkajian, ketepatan intervensi, serta efektivitas evaluasi asuhan keperawatan, sekaligus mendukung keselamatan pasien dan mutu layanan kesehatan (Graves & Corcoran, 1989).

Seiring dengan meningkatnya integrasi teknologi dalam praktik keperawatan, penerapan prinsip etika dan aspek legal menjadi landasan fundamental yang tidak dapat dipisahkan. Penggunaan teknologi keperawatan harus menjunjung tinggi

prinsip penghormatan terhadap otonomi pasien, perlindungan privasi, serta kerahasiaan data kesehatan. Penerapan *informed consent* menjadi sangat penting, khususnya dalam penggunaan teknologi berbasis digital seperti tele-nursing dan aplikasi kesehatan, di mana interaksi tidak selalu berlangsung secara tatap muka. Selain itu, aspek keselamatan pasien menuntut adanya jaminan keandalan teknologi, akurasi data, serta kompetensi perawat dalam mengoperasikan dan mengevaluasi perangkat teknologi. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar hukum yang berlaku merupakan bentuk tanggung jawab profesional perawat dalam menjaga integritas praktik keperawatan di era digital.

Pemanfaatan teknologi dalam keperawatan juga menuntut penguatan kompetensi digital perawat sebagai bagian dari profesionalisme keperawatan modern. Kompetensi ini mencakup kemampuan literasi digital, yaitu kapasitas perawat dalam memahami, menggunakan, serta mengevaluasi teknologi secara kritis dan etis, serta kemampuan memanfaatkan sistem pendukung keputusan klinis (*clinical decision support systems*) dalam proses pengambilan keputusan keperawatan. Penguasaan kompetensi digital memungkinkan perawat untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik keperawatan secara optimal, tanpa mengesampingkan nilai-nilai humanistik, empati, dan hubungan terapeutik dengan pasien. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi digital perawat menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan praktik keperawatan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan (Hashish & Alnajjar, 2024).

### **C. Tele-Nursing dalam Berbagai Bidang Keperawatan**

---

Tele-nursing merupakan salah satu bentuk inovasi praktik keperawatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Secara konseptual, tele-nursing didefinisikan sebagai pemberian asuhan keperawatan jarak jauh yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi untuk mendukung proses pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi asuhan keperawatan. Pendekatan ini memungkinkan interaksi profesional antara perawat dan pasien tanpa keterbatasan ruang dan waktu, sehingga menjadi solusi strategis dalam menjawab tantangan akses dan kontinuitas pelayanan keperawatan (Asbath et al., 2025).

Dalam konteks sistem pelayanan kesehatan modern, tele-nursing berperan sebagai perluasan praktik keperawatan konvensional yang berorientasi pada peningkatan mutu dan efisiensi layanan. Tele-nursing tidak hanya difungsikan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai medium untuk pemantauan kondisi pasien, edukasi kesehatan, konseling keperawatan, serta tindak lanjut asuhan pasca

pelayanan langsung. Melalui tele-nursing, perawat dapat melakukan pemantauan kondisi klinis pasien secara berkelanjutan, mengidentifikasi masalah keperawatan secara dini, serta memberikan intervensi yang tepat berdasarkan kebutuhan individual pasien.

Penerapan tele-nursing memiliki relevansi yang luas di berbagai bidang keperawatan, termasuk keperawatan medikal bedah, maternitas, anak, jiwa, komunitas, dan gerontik. Setiap bidang keperawatan memiliki karakteristik kebutuhan pasien yang berbeda, namun secara umum tele-nursing memberikan kontribusi dalam meningkatkan akses pelayanan, memperkuat hubungan terapeutik, serta mendukung keterlibatan aktif pasien dan keluarga dalam proses perawatan. Dalam praktiknya, tele-nursing memungkinkan perawat untuk menjangkau populasi yang sulit diakses, seperti pasien dengan keterbatasan mobilitas, masyarakat di wilayah terpencil, serta kelompok dengan kebutuhan perawatan jangka panjang (Souza-Junior et al., 2016).

Selain manfaat klinis, tele-nursing juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi sistem pelayanan kesehatan. Penggunaan layanan keperawatan jarak jauh dapat mengurangi frekuensi kunjungan langsung yang tidak diperlukan, menekan biaya pelayanan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya keperawatan. Dari perspektif profesional, tele-nursing memperkuat peran otonomi perawat dalam pengambilan keputusan klinis, sekaligus menuntut kompetensi teknologi, komunikasi terapeutik, dan tanggung jawab etika yang tinggi.

Dengan demikian, tele-nursing dapat dipandang sebagai pendekatan inovatif yang memiliki potensi besar dalam mendukung praktik keperawatan yang adaptif dan berkelanjutan. Pemanfaatan tele-nursing secara optimal memerlukan integrasi antara kompetensi klinis perawat, penguasaan teknologi, serta pemahaman terhadap aspek etika dan legal. Oleh karena itu, pengembangan dan implementasi tele-nursing di berbagai bidang keperawatan menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan di era digital.

## **1. Model Tele-Nursing dan Manfaatnya dalam Praktik Keperawatan**

Pengembangan tele-nursing dalam praktik keperawatan didasarkan pada berbagai model konseptual yang menempatkan teknologi sebagai sarana pendukung proses keperawatan yang berpusat pada pasien. Secara umum, model tele-nursing dikembangkan dengan mengadaptasi kerangka proses keperawatan klasik, yang meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi, ke dalam konteks pelayanan jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Model ini menegaskan bahwa tele-nursing bukan sekadar aktivitas komunikasi virtual, melainkan suatu

bentuk asuhan keperawatan yang tetap mengikuti standar profesional dan prinsip praktik keperawatan berbasis bukti.

Salah satu model yang banyak digunakan dalam praktik tele-nursing adalah model asuhan keperawatan berbasis teknologi sinkron dan asinkron. Pada pendekatan sinkron, interaksi antara perawat dan pasien berlangsung secara real time melalui media seperti panggilan video atau telepon, sehingga memungkinkan komunikasi terapeutik, pengkajian kondisi pasien, serta pemberian edukasi secara langsung. Sementara itu, pendekatan asinkron memungkinkan pertukaran informasi yang tidak harus dilakukan secara bersamaan, seperti pengiriman data kesehatan, pesan tertulis, atau hasil pemantauan mandiri pasien. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam pemberian asuhan keperawatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien.

Model tele-nursing juga banyak dikaitkan dengan kerangka Nursing Informatics, di mana data kesehatan pasien yang diperoleh melalui teknologi digital diolah menjadi informasi yang bermakna untuk mendukung pengambilan keputusan klinis. Dalam model ini, perawat berperan sebagai pengelola informasi klinis yang memanfaatkan sistem pendukung keputusan (*clinical decision support systems*) untuk mengidentifikasi masalah keperawatan, menentukan intervensi yang tepat, serta mengevaluasi hasil asuhan. Integrasi antara teknologi dan penalaran klinis perawat menjadi kunci utama dalam menjamin mutu dan keselamatan asuhan keperawatan berbasis tele-nursing.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan tele-nursing memberikan manfaat signifikan terhadap peningkatan kualitas asuhan keperawatan. Tele-nursing terbukti mampu meningkatkan akses layanan keperawatan, terutama bagi pasien dengan keterbatasan mobilitas, pasien penyakit kronis, serta masyarakat di wilayah terpencil. Selain itu, tele-nursing berkontribusi dalam meningkatkan kontinuitas asuhan melalui pemantauan kondisi pasien secara berkelanjutan, sehingga memungkinkan deteksi dini terhadap perubahan status kesehatan dan pencegahan komplikasi.

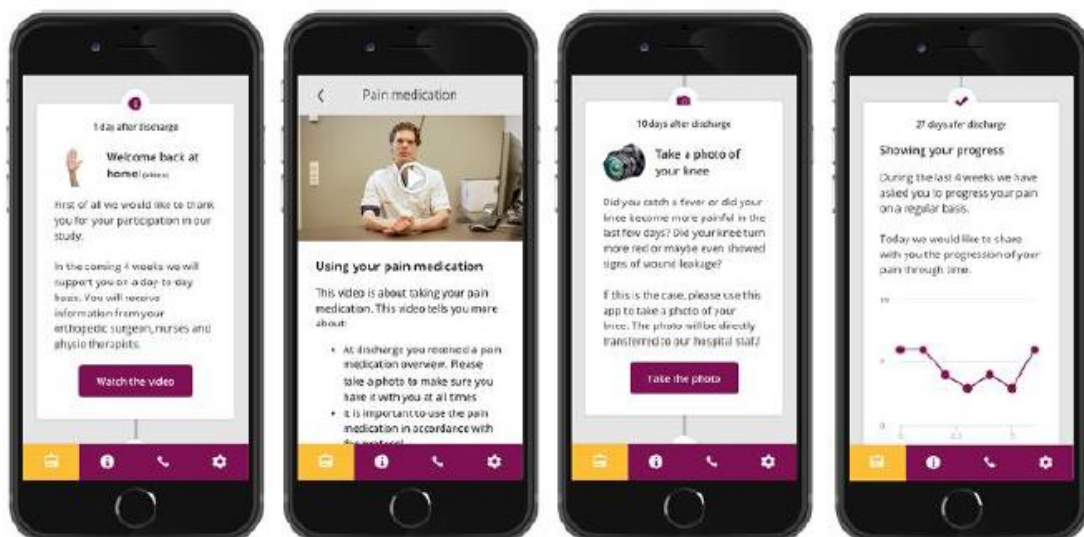
Dari perspektif keselamatan dan outcome pasien, hasil penelitian menunjukkan bahwa tele-nursing berperan dalam meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi dan rekomendasi perawatan, memperbaiki kontrol penyakit kronis, serta menurunkan angka kunjungan ulang ke fasilitas kesehatan. Edukasi dan konseling keperawatan yang diberikan secara jarak jauh juga terbukti meningkatkan pengetahuan, kemandirian, dan keterlibatan aktif pasien serta keluarga dalam proses perawatan. Hal ini menunjukkan bahwa tele-

nursing tidak hanya berdampak pada aspek klinis, tetapi juga pada pemberdayaan pasien.

Selain manfaat bagi pasien, tele-nursing juga memberikan dampak positif terhadap sistem pelayanan kesehatan dan praktik keperawatan. Penelitian menunjukkan bahwa tele-nursing dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, mengurangi beban kerja administratif, serta mengoptimalkan waktu perawat dalam memberikan asuhan yang bernilai klinis tinggi. Bagi perawat, tele-nursing memperkuat peran profesional dalam pengambilan keputusan klinis dan mendorong pengembangan kompetensi teknologi serta komunikasi terapeutik dalam konteks pelayanan modern.

Secara keseluruhan, model tele-nursing yang terintegrasi dengan proses keperawatan dan didukung oleh bukti penelitian menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan mutu, keselamatan, dan efisiensi asuhan keperawatan. Implementasi tele-nursing yang efektif memerlukan kesiapan perawat, dukungan sistem teknologi yang andal, serta kebijakan dan regulasi yang mendukung praktik keperawatan berbasis teknologi. Dengan demikian, tele-nursing dapat dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam pengembangan praktik keperawatan inovatif di era digital.

## 2. Contoh Implementasi Telenursing Berbasis Bukti Penelitian



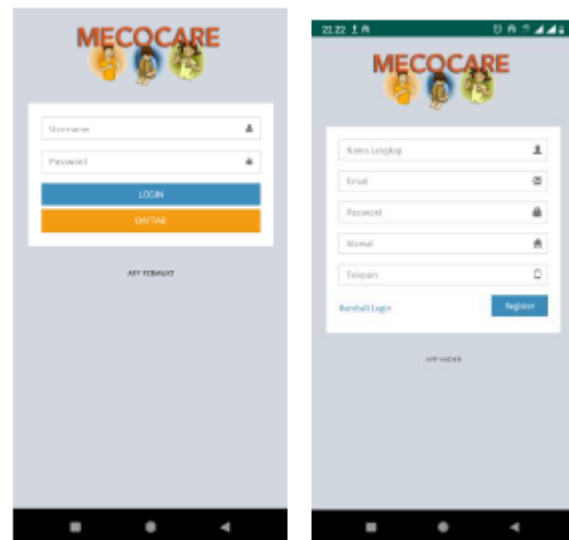
**Gambar 6.1: Aplikasi Edukasi Berbasis Mobile Untuk Pasien  
*Post Total Knee Arthroplasty***

Implementasi telenursing dalam praktik keperawatan telah diterapkan pada berbagai bidang dengan pendekatan dan tujuan yang disesuaikan dengan karakteristik pasien serta kebutuhan layanan. Salah satu contoh implementasi yang terdokumentasi secara baik adalah penerapan telenursing pada pasien

pasca *Total Knee Arthroplasty* (TKA). Berdasarkan studi literatur yang dilakukan pada beberapa uji klinis terkontrol, telenursing diimplementasikan sebagai bentuk asuhan keperawatan berkelanjutan setelah pasien dipulangkan dari rumah sakit. Model telenursing yang digunakan meliputi telepon terstruktur, telepon konseling disertai pesan singkat (SMS), aplikasi edukasi berbasis mobile, serta pengiriman video edukasi melalui pesan teks. Intervensi ini difokuskan pada teleedukasi dan telemonitoring, khususnya terkait latihan rehabilitasi, manajemen nyeri, perawatan luka, penggunaan alat bantu berjalan, serta aktivitas perawatan diri sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar metode telenursing tersebut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan fungsi lutut, kepatuhan latihan mandiri, aktivitas sehari-hari, dan kualitas hidup pasien, serta memungkinkan deteksi dini terhadap komplikasi pascaoperasi tanpa harus melakukan kunjungan tatap muka secara intensif (Meitri & Herawati, 2022).



**Gambar 6.2: Tampilan Menu Aplikasi Pasien / Keluarga**



**Gambar 6.1: Tampilan Menu Aplikasi Perawat**

Contoh implementasi lainnya ditunjukkan dalam bidang keperawatan jiwa komunitas melalui pengembangan aplikasi telenursing Me-Co Care. Aplikasi ini dirancang sebagai platform berbasis mobile yang mengintegrasikan peran perawat, pasien, keluarga, dan kader kesehatan dalam satu sistem pelayanan jarak jauh. Implementasi Me-Co Care dilakukan pada pasien dengan gangguan jiwa di komunitas dengan tujuan utama menurunkan angka kekambuhan, meningkatkan kepatuhan pengobatan, serta memperkuat dukungan keluarga dan komunitas. Dalam praktiknya, aplikasi ini menyediakan fitur pemantauan kondisi pasien, edukasi kesehatan jiwa, pengingat pengobatan, serta sarana komunikasi langsung antara perawat dan pasien maupun keluarga. Hasil uji

coba penggunaan selama tiga minggu menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi, dengan mayoritas responden menyatakan bahwa aplikasi ini membantu akses pelayanan keperawatan, terutama di wilayah dengan keterbatasan sumber daya manusia kesehatan (Slametiningsih et al., 2021).

Secara konseptual, kedua contoh implementasi tersebut menggambarkan bahwa telenursing berfungsi sebagai perpanjangan asuhan keperawatan konvensional, bukan pengganti hubungan terapeutik perawat-pasien. Pada pasien post TKA, telenursing memperkuat kontinuitas perawatan fisik dan rehabilitatif, sedangkan pada keperawatan jiwa komunitas, telenursing berperan dalam memperluas jangkauan layanan promotif, preventif, dan rehabilitatif berbasis komunitas. Dengan dukungan teknologi komunikasi yang tepat, perawat tetap menjalankan proses keperawatan secara utuh, mulai dari pengkajian jarak jauh, perencanaan intervensi, implementasi edukasi dan monitoring, hingga evaluasi hasil asuhan secara sistematis dan berkelanjutan.

#### **D. Pemanfaatan Mobile Applications dalam Praktik Keperawatan**

---

Mobile applications dalam praktik keperawatan merupakan bentuk pemanfaatan teknologi digital yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan secara berkelanjutan, efektif, dan berpusat pada pasien. Aplikasi ini memungkinkan integrasi layanan keperawatan ke dalam aktivitas harian pasien melalui perangkat seluler, sehingga proses pengkajian, edukasi, pemantauan, dan evaluasi keperawatan tidak terbatas pada interaksi tatap muka di fasilitas kesehatan. Dalam konteks sistem pelayanan kesehatan modern, mobile applications berfungsi sebagai media penghubung antara pasien, keluarga, dan perawat dalam suatu sistem pelayanan yang lebih fleksibel dan responsif (Alipour et al., 2025).

Pemanfaatan mobile applications juga mendukung paradigma perawatan berbasis *patient-centered care* dan *self-care management*. Pasien tidak lagi diposisikan sebagai penerima layanan pasif, tetapi sebagai individu yang berperan aktif dalam pemantauan dan pengelolaan kondisi kesehatannya. Melalui aplikasi kesehatan, data klinis yang dikumpulkan secara mandiri oleh pasien dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan keperawatan yang lebih akurat dan berbasis data. Dengan demikian, mobile applications berkontribusi terhadap peningkatan mutu asuhan keperawatan, keselamatan pasien, serta efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan.

## **1. Peran Perawat dalam Penggunaan Mobile Applications**

Perawat memiliki peran strategis dan multidimensional dalam pemanfaatan mobile applications sebagai bagian dari praktik keperawatan profesional. Peran utama perawat adalah sebagai fasilitator teknologi, yaitu membantu pasien dan keluarga dalam memilih, memahami, dan menggunakan aplikasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan klinis, tingkat literasi, serta kondisi sosial budaya pasien. Perawat bertanggung jawab memastikan bahwa aplikasi yang digunakan memiliki tujuan yang jelas dan relevan dengan rencana asuhan keperawatan.

Selain itu, perawat berperan sebagai pengelola dan interpreter data klinis yang dihasilkan oleh aplikasi. Data yang dicatat pasien, seperti nilai glukosa darah, tekanan darah, atau tingkat nyeri, perlu dianalisis secara sistematis oleh perawat untuk mengidentifikasi perubahan kondisi kesehatan, menentukan prioritas masalah keperawatan, serta merancang intervensi yang tepat. Dalam hal ini, kompetensi klinis dan kemampuan berpikir kritis perawat tetap menjadi elemen utama, sementara aplikasi berfungsi sebagai alat pendukung pengambilan keputusan.

Peran perawat juga mencakup evaluasi efektivitas aplikasi kesehatan sebagai intervensi keperawatan. Perawat perlu menilai apakah penggunaan aplikasi berdampak pada peningkatan kepatuhan pasien, perubahan perilaku kesehatan, dan pencapaian tujuan asuhan keperawatan. Di samping itu, perawat memiliki tanggung jawab etik dan legal untuk memastikan keamanan data, perlindungan privasi pasien, serta penggunaan aplikasi sesuai dengan standar praktik dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, perawat tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai penjaga mutu dan keselamatan dalam praktik keperawatan berbasis digital.

## **2. Jenis Mobile Applications dalam Praktik Keperawatan**

Mobile applications dalam praktik keperawatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan fungsi utamanya. Aplikasi edukasi pasien berfokus pada penyediaan informasi kesehatan yang terstruktur dan mudah dipahami, mencakup penjelasan tentang penyakit, pengobatan, pencegahan komplikasi, serta promosi gaya hidup sehat. Aplikasi jenis ini mendukung peran perawat dalam memberikan edukasi berkelanjutan dan memperkuat pemahaman pasien terhadap kondisi kesehatannya.

Jenis berikutnya adalah aplikasi self-monitoring, yang memungkinkan pasien melakukan pemantauan mandiri terhadap parameter kesehatan tertentu, seperti kadar glukosa darah, tekanan darah, intensitas nyeri, aktivitas fisik, atau



kepatuhan pengobatan. Aplikasi ini menghasilkan data longitudinal yang bernilai klinis dan dapat dimanfaatkan oleh perawat untuk mengevaluasi perkembangan kondisi pasien serta efektivitas intervensi keperawatan. Self-monitoring juga berperan dalam meningkatkan kesadaran pasien terhadap kondisi kesehatannya dan mendorong perilaku perawatan mandiri.

Selain itu, terdapat aplikasi clinical decision support, yang ditujukan terutama bagi tenaga kesehatan. Aplikasi ini menyediakan panduan praktik keperawatan, algoritma klinis, pengingat intervensi, serta rekomendasi berbasis bukti ilmiah. Dalam praktik keperawatan, aplikasi ini membantu perawat dalam meningkatkan konsistensi praktik, mengurangi kesalahan klinis, serta mendukung pengambilan keputusan yang aman dan terstandar, khususnya pada kondisi klinis yang kompleks.

### **3. Contoh Pemanfaatan Mobile Applications dalam Praktik Keperawatan**

Dalam manajemen penyakit kronik, mobile applications banyak dimanfaatkan untuk pemantauan glukosa darah pada pasien diabetes melitus, pencatatan tekanan darah pada pasien hipertensi, serta pengelolaan nyeri pada pasien dengan kondisi kronis. Pasien secara rutin memasukkan data kesehatan ke dalam aplikasi, sementara perawat memanfaatkan data tersebut untuk melakukan evaluasi jarak jauh, memberikan umpan balik, dan menyesuaikan rencana asuhan keperawatan. Pendekatan ini terbukti mendukung kontinuitas asuhan dan mencegah keterlambatan penanganan komplikasi.

Mobile applications juga digunakan dalam edukasi kesehatan berbasis budaya (*transcultural nursing*). Aplikasi yang dirancang dengan mempertimbangkan bahasa lokal, nilai budaya, dan kebiasaan masyarakat memungkinkan penyampaian edukasi kesehatan yang lebih kontekstual dan dapat diterima. Perawat berperan memastikan bahwa konten edukasi tidak bertentangan dengan nilai budaya pasien, sehingga intervensi keperawatan menjadi lebih efektif dan sensitif budaya.

Selain itu, dalam praktik keperawatan komunitas dan gerontik, mobile applications digunakan untuk pemantauan kondisi kesehatan lansia, pengingat pengobatan, serta komunikasi berkelanjutan antara perawat, pasien, dan keluarga. Aplikasi ini membantu perawat dalam memantau kondisi pasien secara berkelanjutan, meningkatkan keterlibatan keluarga dalam perawatan, serta mendukung pencegahan komplikasi dan hospitalisasi yang tidak diperlukan

## E. Peralatan Klinis Modern dalam Praktik Keperawatan

Peralatan klinis modern merupakan hasil integrasi antara perkembangan teknologi biomedis, sistem informasi kesehatan, dan praktik keperawatan berbasis bukti. Penggunaan peralatan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, tetapi juga sebagai komponen strategis dalam mendukung proses keperawatan yang akurat, aman, dan efisien. Dalam konteks praktik keperawatan, peralatan klinis modern memungkinkan perawat untuk memperoleh data fisiologis pasien secara objektif, kontinu, dan real time, sehingga mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat dan responsif terhadap perubahan kondisi pasien.

Pemanfaatan peralatan klinis modern secara langsung berkaitan dengan peningkatan mutu asuhan keperawatan, khususnya pada tahap pengkajian, implementasi intervensi, dan evaluasi hasil asuhan. Data yang dihasilkan oleh perangkat berbasis teknologi bersifat lebih akurat dan terdokumentasi secara sistematis, sehingga mengurangi ketergantungan pada pengukuran manual yang rentan terhadap kesalahan. Selain itu, teknologi klinis modern juga memperkuat peran perawat sebagai pengelola informasi klinis, yang tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikannya untuk menentukan tindakan keperawatan yang paling sesuai dengan kondisi pasien.

**Tabel 6.1: Contoh Peralatan klinis Modern**

| <b>Peralatan Klinis Modern</b>                      | <b>Fungsi Utama dalam Keperawatan</b>                                                   | <b>Manfaat terhadap Praktik Keperawatan</b>                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Continuous Glucose Monitoring (CGM)</i>          | Memantau kadar glukosa darah secara kontinu dan real time                               | Meningkatkan akurasi pengkajian metabolik, deteksi dini hipoglikemia/hiperglikemia, mendukung pengambilan keputusan keperawatan berbasis data |
| <i>Wearable Devices</i> (jam pintar, gelang sensor) | Memantau denyut jantung, aktivitas fisik, saturasi oksigen, dan pola tidur              | Mendukung pemantauan jangka panjang, pencegahan perburukan kondisi, dan perawatan berkelanjutan pada pasien kronik dan gerontik               |
| <i>Smart Vital Sign Monitors</i>                    | Mengukur tekanan darah, suhu tubuh, frekuensi napas, dan denyut jantung secara otomatis | Meningkatkan akurasi tanda vital, mengurangi kesalahan pencatatan manual, mempercepat dokumentasi keperawatan                                 |
| <i>Infusion Pump Pintar</i>                         | Mengatur pemberian cairan dan obat intravena secara presisi                             | Meningkatkan keselamatan pasien, mencegah kesalahan dosis, dan                                                                                |

|                                                                    |                                                                 |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                 | memastikan ketepatan intervensi keperawatan                                                               |
| <i>Syringe Pump</i>                                                | Memberikan obat dengan volume kecil dan laju aliran terkontrol  | Mendukung ketepatan terapi pada pasien pediatrik, neonatal, dan pasien kritis                             |
| <i>Assessment Digital</i> (nyeri, risiko jatuh, status neurologis) | Melakukan pengkajian keperawatan secara objektif dan terstandar | Meningkatkan konsistensi pengkajian, kualitas dokumentasi, dan akurasi penetapan masalah keperawatan      |
| Sistem Terintegrasi dengan Rekam Medis Elektronik                  | Mengelola dan menyimpan data klinis pasien secara digital       | Meningkatkan kontinuitas asuhan, efisiensi kerja perawat, dan dukungan praktik keperawatan berbasis bukti |

Sebagaimana disajikan dalam Tabel Peralatan Klinis Modern dalam Praktik Keperawatan, berbagai jenis perangkat teknologi memiliki fungsi dan manfaat yang spesifik dalam mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan. *Continuous Glucose Monitoring* (CGM) merupakan contoh peralatan monitoring modern yang memberikan data kadar glukosa darah secara kontinu dan real time (Frank et al., 2022). Penggunaan CGM memungkinkan perawat melakukan pengkajian metabolik secara lebih komprehensif, mengidentifikasi fluktuasi kadar glukosa secara dini, serta mendukung pengambilan keputusan keperawatan berbasis data, khususnya pada pasien dengan diabetes melitus atau gangguan metabolik (Yang et al., 2021).

*Wearable devices*, seperti jam pintar dan gelang sensor, berfungsi untuk memantau berbagai parameter fisiologis, termasuk denyut jantung, aktivitas fisik, saturasi oksigen, dan pola tidur. Dalam praktik keperawatan, perangkat ini sangat bermanfaat untuk pemantauan jangka panjang, terutama pada pasien dengan penyakit kronik dan kelompok gerontik. Data yang diperoleh mencerminkan kondisi pasien dalam aktivitas sehari-hari, sehingga membantu perawat dalam menilai status fungsional, risiko perburukan kondisi, serta efektivitas intervensi keperawatan yang diberikan (Yuan et al., 2023).

Peralatan lain yang berperan penting adalah smart vital sign monitors, yaitu perangkat pengukur tanda vital berbasis digital yang bekerja secara otomatis. Alat ini meningkatkan akurasi pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, frekuensi napas, dan denyut jantung, sekaligus mengurangi kesalahan pencatatan manual. Integrasi

dengan sistem dokumentasi keperawatan juga mempercepat proses pencatatan dan memudahkan perawat dalam memantau tren perubahan kondisi pasien secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan intervensi keperawatan, infusion pump pintar dan syringe pump merupakan peralatan berbasis teknologi yang berkontribusi besar terhadap keselamatan pasien. Infusion pump pintar memungkinkan pengaturan pemberian cairan dan obat intravena secara presisi serta dilengkapi sistem alarm untuk mencegah kesalahan dosis. Sementara itu, *syringe pump* digunakan untuk pemberian obat dengan volume kecil dan laju aliran terkontrol, sehingga sangat penting dalam perawatan pasien pediatrik, neonatal, dan pasien kritis yang memerlukan ketepatan tinggi dalam terapi.

Selain alat monitoring dan pemberian terapi, alat assessment digital berperan dalam meningkatkan objektivitas dan standardisasi pengkajian keperawatan. Instrumen penilaian nyeri, risiko jatuh, dan status neurologis berbasis digital membantu perawat melakukan pengkajian yang lebih konsisten dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini berdampak pada peningkatan akurasi penetapan masalah keperawatan dan kualitas evaluasi hasil asuhan.

Seluruh pemanfaatan peralatan klinis modern tersebut semakin optimal ketika terintegrasi dengan sistem rekam medis elektronik. Sistem ini memungkinkan pengelolaan dan penyimpanan data klinis pasien secara terpusat dan berkelanjutan, sehingga mendukung kontinuitas asuhan keperawatan, efisiensi kerja perawat, serta penerapan praktik keperawatan berbasis bukti. Integrasi ini menegaskan bahwa teknologi klinis modern bukan hanya alat individual, tetapi bagian dari ekosistem pelayanan keperawatan yang saling terhubung.

## F. Referensi

- 
- Alipour, J., Mehdipour, Y., Zakerabasali, S., & Karimi, A. (2025). Nurses' perspectives on using mobile health applications in southeastern Iran: Awareness, attitude, and obstacles. *PLOS One*, 20. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0316631>
- Asbath, A., Tanaka, K., & Nakamura, Y. (2025). Tele-Nursing: The Future of Remote Care for Healthcare Efficiency and Accessibility. *Journal of World Future Medicine, Health and Nursing*. <https://doi.org/10.70177/health.v3i1.1903>
- Chaharsoughi, N. T., Ahmadifaraz, M., & Kahangi, L. (2022). The impact of digital technologies in nursing care and their application: A narrative review. *Journal of Multidisciplinary Care*. <https://doi.org/10.34172/jmdc.2022.1127>
- Frank, S., Hames, K. C., Jbaily, A., Park, J. H., Stroyeck, C., & Price, D. (2022). Feasibility of Using a Factory-Calibrated Continuous Glucose Monitoring System to

- Diagnose Type 2 Diabetes. *Diabetes Technology and Therapeutics*, 24(12), 907–914. <https://doi.org/10.1089/dia.2022.0189>
- Graves, J., & Corcoran, S. (1989). The study of nursing informatics. *Image--the Journal of Nursing Scholarship*, 21 4, 227–231. <https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.1989.tb00148.x>
- Hashish, E. A., & Alnajjar, H. (2024). Digital proficiency: assessing knowledge, attitudes, and skills in digital transformation, health literacy, and artificial intelligence among university nursing students. *BMC Medical Education*, 24. <https://doi.org/10.1186/s12909-024-05482-3>
- Meitri, W., & Herawati, T. (2022). *Efektivitas Telenursing Terhadap Fungsi Lutut Pasien Post Total Knee Arthroplasty The Effectiveness of Telenursing on Patient 's Knee Function Post Total Knee Arthroplasty Pendahuluan Total joint arthroplasty atau total joint replacement merupakan tindakan pembedahan ortopedi dengan tujuan pengobatan patologi. 2.* <https://doi.org/10.36082/jhcnv2i1.430>
- Mohammadnejad, F., Freeman, S., Klassen-Ross, T., Hemingway, D., & Banner, D. (2023). Impacts of Technology Use on the Workload of Registered Nurses: A Scoping Review. *Journal of Rehabilitation and Assistive Technologies Engineering*, 10. <https://doi.org/10.1177/20556683231180189>
- Schlicht, L., Wendsche, J., Melzer, M., Tschetsche, L., & Rösler, U. (2024). Digital technologies in nursing: An umbrella review. *International Journal of Nursing Studies*, 161, 104950. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2024.104950>
- Slametiningsih, Yunitri, N., Hendra, & Nuraenah. (2021). Rancang Bangun Aplikasi Telenursing Me-Co Care Berbasis Mobile Dalam Pelayanan Keperawatan Jiwa Komunitas. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 11(2), 63–70.
- Souza-Junior, V., Mendes, I., Mazzo, A., & Godoy, S. (2016). Application of telenursing in nursing practice: an integrative literature review. *Applied Nursing Research: ANR*, 29, 254–260. <https://doi.org/10.1016/j.apnr.2015.05.005>
- Wang, B., Shi, X., Han, X., & Xiao, G. (2024). The digital transformation of nursing practice: an analysis of advanced IoT technologies and smart nursing systems. *Frontiers in Medicine*, 11. <https://doi.org/10.3389/fmed.2024.1471527>
- Yang, J., Yang, X., Zhao, D., Wang, X., Wei, W., & Yuan, H. (2021). Association of time in range, as assessed by continuous glucose monitoring, with painful diabetic polyneuropathy. *Journal of Diabetes Investigation*, 12(5), 828–836. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/jdi.13394>
- Yuan, X., Li, C., Yin, X., Yang, Y., Ji, B., Niu, Y., & Ren, L. (2023). Epidermal Wearable Biosensors for Monitoring Biomarkers of Chronic Disease in Sweat. *Biosensors*, 13(3). <https://doi.org/10.3390/bios13030313>

## **G. Glosarium**

---

TKA = Total Knee Arthroplasty

CGM = Continuous Glucose Monitoring



# CHAPTER 7

## PENGEMBANGAN PRAKTIK KEPERAWATAN BERBASIS KOMPETENSI KLINIS DAN STANDART PROFESI

Nina Rizka Rohmawati, S.Kep., Ns., M.Kep.

### A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan menempatkan profesi keperawatan pada posisi yang semakin strategis dalam sistem pelayanan kesehatan. Perawat tidak hanya dituntut untuk mampu melaksanakan tindakan keperawatan secara teknis, tetapi juga diharapkan memiliki kompetensi klinis yang kuat, menjunjung tinggi standar profesi, serta berperan aktif dalam menjamin keselamatan dan kepuasan pasien. Oleh karena itu, pengembangan praktik keperawatan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

Praktik keperawatan profesional harus dilaksanakan berdasarkan kompetensi klinis yang memadai dan mengacu pada standar profesi yang telah ditetapkan. Kompetensi klinis mencakup integrasi pengetahuan ilmiah, keterampilan klinis, serta sikap profesional yang memungkinkan perawat memberikan asuhan keperawatan secara aman, efektif, dan beretika. Standar profesi keperawatan berfungsi sebagai pedoman normatif yang mengatur batas kewenangan, tanggung jawab, serta perilaku profesional perawat dalam praktik klinis. Di Indonesia, standar tersebut dikembangkan dan ditetapkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia sebagai upaya menjaga mutu dan akuntabilitas praktik keperawatan. Dinamika pelayanan kesehatan global menuntut praktik keperawatan yang selaras dengan standar internasional dan praktik berbasis bukti (Evidence-Based Practice). Organisasi internasional seperti World Health Organization dan American Nurses Association menegaskan bahwa penguatan kompetensi perawat, penerapan standar praktik, serta budaya keselamatan pasien merupakan pilar utama dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Dalam konteks ini, strategi pengembangan praktik keperawatan tidak hanya berfokus pada pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, tetapi juga mencakup supervisi klinik, mentoring, evaluasi kompetensi, audit mutu, serta penguatan budaya profesional dan etika keperawatan.



Oleh karena itu, materi dalam bab ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, strategi, dan dampak pengembangan praktik keperawatan berbasis kompetensi klinis dan standar profesi. Pembahasan ini diharapkan dapat menjadi landasan konseptual dan praktis bagi mahasiswa keperawatan, perawat praktisi, serta pendidik keperawatan dalam mengembangkan praktik keperawatan yang profesional, bermutu, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

## **B. Konsep Dasar Pengembangan Praktik Keperawatan**

---

Pengertian Praktik keperawatan profesional sendiri merupakan suatu bentuk pelayanan keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat berdasarkan kompetensi, kewenangan, dan tanggung jawab profesional yang diperoleh melalui pendidikan formal dan pengakuan profesi. Praktik ini menempatkan perawat sebagai tenaga kesehatan profesional yang memiliki otonomi dalam lingkup praktik keperawatan, sekaligus berkolaborasi dengan profesi kesehatanlain dalam sistem pelayanan kesehatan. Secara konseptual, praktik keperawatan profesional tidak dapat dipisahkan dari penerapan ilmu keperawatan (*nursing science*), keterampilan klinis (*clinical skills*), dan sikap profesional (*professional attitude*). Ketiga komponen tersebut terintegrasi dalam setiap tindakan keperawatan yang dilakukan perawat. Menurut *World Health Organization* (WHO)(2020), praktik profesional tenaga kesehatan ditandai oleh kemampuan individu untuk memberikan pelayanan yang aman, efektif, berpusat pada pasien, serta sesuai dengan standar mutu dan etika profesi.

Dalam praktik keperawatan profesional, perawat menjalankan proses keperawatan sebagai kerangka kerja utama. Proses keperawatan memungkinkan perawat melakukan pengambilan keputusan klinis secara sistematis dan rasional, mulai dari pengkajian kondisi klien hingga evaluasi hasil asuhan. Menurut Potter et al. (2021) menegaskan bahwa penggunaan proses keperawatan mencerminkan praktik profesional karena setiap tindakan keperawatan memiliki dasar ilmiah, tujuan yang jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis maupun hukum. Praktik keperawatan profesional juga mencerminkan akuntabilitas dan tanggung jawab profesional. Perawat bertanggung jawab tidak hanya terhadap tindakan yang dilakukan, tetapi juga terhadap dampak dari tindakan tersebut terhadap keselamatan dan kesejahteraan klien. Oleh karena itu, praktik profesional menuntut perawat untuk terus memperbarui kompetensinya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, praktik keperawatan profesional dapat dipahami sebagai praktik yang berorientasi pada mutu, keselamatan, dan nilai kemanusiaan,

yang dilaksanakan secara sadar, sistematis, dan berlandaskan standar profesi serta etika keperawatan.

Tujuan dari Pengembangan praktik keperawatan merupakan suatu proses dinamis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk menyesuaikan praktik keperawatan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan sistem pelayanan kesehatan. Pengembangan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan individu perawat, tetapi juga untuk memperkuat peran profesi keperawatan dalam sistem kesehatan secara keseluruhan. Namun, tujuan utama dari pengembangan praktik keperawatan adalah meningkatkan mutu dan keselamatan asuhan keperawatan. Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, mutu pelayanan tidak lagi hanya diukur dari keberhasilan tindakan klinis, tetapi juga dari keamanan pasien, efektivitas intervensi, dan pengalaman pasien selama menerima pelayanan. Melnyk dan Fineout-Overholt (2023), menjelaskan bahwa pengembangan praktik keperawatan melalui penerapan *evidence-based practice* terbukti mampu meningkatkan hasil klinis dan menurunkan kejadian yang tidak diinginkan (*adverse events*).

Tujuan berikutnya adalah menjamin keseragaman dan konsistensi praktik keperawatan sesuai standar profesi. Tanpa adanya pengembangan praktik yang terarah, asuhan keperawatan berisiko dilakukan berdasarkan kebiasaan atau pengalaman semata. Marquis dan Huston (2021) menekankan bahwa pengembangan praktik membantu perawat menerapkan standar praktik secara konsisten, sehingga kualitas pelayanan dapat dipertahankan di berbagai fasilitas dan tingkat pelayanan kesehatan. Pengembangan praktik keperawatan juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perawat. Kompetensi perawat tidak bersifat statis, melainkan harus terus dikembangkan seiring perubahan kebutuhan pasien dan kompleksitas masalah kesehatan. Benner et al. (2019) menyatakan bahwa pengembangan praktik memungkinkan perawat berkembang dari tingkat pemula menuju tingkat mahir dan ahli melalui pengalaman klinis, refleksi, dan pembelajaran berkelanjutan.

Selain itu, pengembangan praktik keperawatan memiliki tujuan strategis dalam mendukung keberlanjutan sistem pelayanan kesehatan. Perawat yang memiliki praktik profesional yang kuat dapat berkontribusi dalam pengendalian mutu, efisiensi pelayanan, serta pengembangan kebijakan klinis berbasis kebutuhan pasien dan masyarakat (WHO, 2020). Sehingga pengembangan praktik keperawatan tidak hanya berfokus pada peningkatan individu perawat, tetapi juga pada penguatan peran profesi keperawatan dalam meningkatkan kualitas sistem pelayanan kesehatan.

Perawat memegang peran yang sangat strategis dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan karena keberadaannya yang kontinu dan dekat dengan pasien. Dalam praktik sehari-hari, perawat berada pada posisi yang memungkinkan untuk secara langsung mengidentifikasi masalah mutu dan keselamatan pelayanan. Salah satu peran utama perawat adalah sebagai pelaksana asuhan keperawatan berbasis bukti ilmiah. Perawat bertanggung jawab untuk memilih dan menerapkan intervensi keperawatan yang didukung oleh hasil penelitian terkini. Menurut Melnyk dan Fineout-Overholt (2023), keterlibatan aktif perawat dalam *evidence-based practice* merupakan kunci utama dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Perawat juga berperan sebagai advokat pasien, yaitu memastikan bahwa hak, kebutuhan, dan keselamatan pasien menjadi prioritas dalam setiap proses pelayanan. Dalam peran ini, perawat membantu pasien memahami kondisi kesehatannya, mendorong partisipasi pasien dalam pengambilan keputusan, serta melindungi pasien dari tindakan yang berpotensi merugikan (Potter et al., 2021). Perawat juga memiliki peran penting dalam koordinasi dan kolaborasi interprofesional. Mutu pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh komunikasi dan kerja sama tim. Perawat berperan sebagai penghubung antara pasien, keluarga, dan anggota tim kesehatan lainnya untuk memastikan kesinambungan asuhan dan mengurangi risiko kesalahan komunikasi (Marquis & Huston, 2021).

Peran lainnya adalah keterlibatan perawat dalam monitoring, evaluasi, dan perbaikan mutu pelayanan. Perawat berpartisipasi dalam audit keperawatan, pelaporan insiden keselamatan pasien, serta kegiatan peningkatan mutu berkelanjutan. Menurut *American Nurses Association* (2021), keterlibatan perawat dalam program mutu merupakan indikator penting dari praktik keperawatan profesional. Melalui peran-peran tersebut, perawat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi asuhan langsung, tetapi juga sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang berkontribusi aktif dalam membangun budaya mutu dan keselamatan dalam pelayanan kesehatan.

### C. Kompetensi Klinis Perawat

---

Kompetensi klinis pada perawat merupakan kemampuan menyeluruh yang dimiliki perawat untuk memberikan asuhan keperawatan secara aman, efektif, dan bertanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien. Kompetensi ini tidak hanya mencerminkan kecakapan teknis dalam melakukan tindakan keperawatan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, serta penerapan nilai etika dan profesionalisme dalam praktik. Dengan kata lain, kompetensi klinis menuntut perawat untuk mampu mengintegrasikan aspek kognitif, psikomotor,

dan afektif secara seimbang dalam situasi klinik yang dinamis. Menurut *World Health Organization* (WHO)(2020), kompetensi tenaga kesehatan didefinisikan sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang memungkinkan individu melaksanakan tugasnya secara efektif dalam sistem pelayanan kesehatan. Dalam konteks keperawatan, definisi ini menegaskan bahwa kompetensi klinis tidak dapat dinilai hanya dari kemampuan melakukan prosedur, tetapi juga dari cara perawat bersikap, berkomunikasi, dan bertanggung jawab terhadap hasil asuhan. Oleh karena itu, kompetensi klinis perawat menjadi dasar utama praktik keperawatan profesional dan indikator penting mutu pelayanan keperawatan.

Perawat klinis juga memiliki beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Kompetensi klinis perawat terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional, yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pengetahuan merupakan landasan kognitif yang mencakup pemahaman tentang konsep keperawatan, ilmu biomedik, ilmu perilaku, serta prinsip asuhan keperawatan berbasis bukti. Tanpa pengetahuan yang memadai, perawat akan mengalami kesulitan dalam memahami kondisi klien dan menentukan intervensi yang tepat. Keterampilan klinis berkaitan dengan kemampuan psikomotor perawat dalam melaksanakan tindakan keperawatan secara aman, tepat, dan sesuai prosedur. Keterampilan ini mencakup keterampilan dasar keperawatan, keterampilan komunikasi terapeutik, serta keterampilan teknis yang berkembang sesuai bidang praktik. Sementara itu, sikap profesional mencerminkan nilai-nilai etik, tanggung jawab, empati, komitmen, dan integritas perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Potter et al. (2021) menegaskan bahwa praktik keperawatan yang bermutu hanya dapat dicapai apabila ketiga komponen tersebut berkembang secara seimbang dan diterapkan secara konsisten dalam pelayanan.

Area kompetensi klinis dalam Asuhan keperawatan mencakup seluruh tahapan proses keperawatan yang menjadi kerangka kerja praktik keperawatan profesional. Pada tahap pengkajian, perawat dituntut memiliki kompetensi dalam mengumpulkan data secara sistematis, akurat, dan komprehensif, baik data subjektif maupun objektif dari klien. Pengkajian yang tepat menjadi dasar penting dalam menentukan masalah keperawatan dan rencana asuhan selanjutnya. Pada tahap diagnosis keperawatan, kompetensi klinis perawat tercermin dari kemampuan menganalisis data, mengidentifikasi respons klien, dan merumuskan diagnosis keperawatan yang sesuai dengan standar. Selanjutnya, dalam perencanaan dan implementasi, perawat harus mampu memilih dan melaksanakan intervensi keperawatan yang aman, efektif, dan sesuai kebutuhan klien. Tahap

evaluasi menuntut perawat untuk menilai respons klien terhadap intervensi dan melakukan penyesuaian rencana asuhan bila diperlukan. Menurut *American Nurses Association* (2021), penguasaan area kompetensi ini merupakan ciri utama praktik keperawatan profesional yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien.

Pengembangan kompetensi klinis perawat merupakan proses pembelajaran sepanjang hayat atau *lifelong learning* yang harus dilakukan secara terus-menerus sepanjang karier profesional perawat. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, dan kompleksitas masalah kesehatan yang terus berubah. Kompetensi yang memadai pada satu periode waktu dapat menjadi tidak relevan apabila tidak diperbarui sesuai perkembangan terkini. Melnyk dan Fineout-Overholt (2023) menjelaskan bahwa perawat yang aktif dalam pengembangan kompetensi berkelanjutan menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kritis, kualitas asuhan, dan keselamatan pasien. Pengembangan kompetensi klinis dapat dilakukan melalui pendidikan formal lanjutan, pelatihan dan sertifikasi klinis, seminar ilmiah, supervisi, serta refleksi praktik. Selain itu, keterlibatan perawat dalam praktik berbasis bukti juga menjadi sarana penting untuk memperkuat kompetensi klinis. Dengan demikian, *lifelong learning* bukan sekadar kewajiban profesional, tetapi merupakan kebutuhan mendasar untuk mempertahankan mutu praktik keperawatan.

*World Health Organization* (WHO), memiliki peran penting dalam penguatan kompetensi tenaga kesehatan, termasuk perawat, melalui pengembangan kebijakan global dan rekomendasi berbasis bukti. WHO menekankan bahwa tenaga kesehatan yang kompeten merupakan kunci utama dalam pencapaian pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, WHO secara aktif mendorong negara-negara anggota untuk memperkuat sistem pendidikan, pelatihan, dan regulasi praktik tenaga kesehatan. Melalui laporan *State of the World's Nursing* (WHO, 2020), WHO menegaskan bahwa investasi dalam pengembangan kompetensi perawat sangat diperlukan untuk menjawab tantangan sistem kesehatan global. WHO juga menyoroti pentingnya pendidikan berkelanjutan, kepemimpinan perawat, dan lingkungan praktik yang mendukung pengembangan kompetensi klinis. Dengan dukungan kebijakan dan panduan dari WHO, diharapkan negara-negara dapat mengembangkan perawat yang kompeten, profesional, dan mampu memberikan asuhan keperawatan bermutu tinggi.

#### **D. Standar Profesi Keperawatan**

---

Standar profesi keperawatan merupakan pedoman tertulis yang menetapkan kriteria, kualitas, dan batas kewenangan praktik keperawatan profesional yang harus dipatuhi oleh setiap perawat. Standar ini disusun oleh organisasi profesi dan digunakan sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan (*American Nurses Association, 2021*). Menurut *American Nurses Association* (2021), standar profesi keperawatan menggambarkan ekspektasi praktik dan tingkat kinerja profesional yang harus dicapai oleh perawat. Standar ini menegaskan bahwa setiap tindakan keperawatan harus dilakukan berdasarkan pengetahuan ilmiah, keterampilan klinis yang kompeten, serta sikap profesional yang sesuai dengan kode etik keperawatan. Dengan demikian, standar profesi memastikan bahwa praktik keperawatan tidak dilakukan secara subjektif atau berdasarkan kebiasaan.

Potter et al. (2021) menjelaskan bahwa standar profesi keperawatan berfungsi sebagai pembeda utama antara praktik keperawatan profesional dan praktik perawatan non-profesional. Praktik keperawatan profesional selalu menggunakan proses keperawatan sebagai kerangka kerja, meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tanpa standar profesi, praktik keperawatan berisiko menjadi tidak terarah, sulit dievaluasi, dan berpotensi menurunkan mutu pelayanan. Dalam konteks sistem pelayanan kesehatan, standar profesi keperawatan juga berperan penting dalam menjamin mutu dan keselamatan pasien. *World Health Organization* (2020) menegaskan bahwa penerapan standar praktik tenaga kesehatan merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mencegah terjadinya kesalahan pelayanan (patient safety incidents). Oleh karena itu, standar profesi menjadi landasan penting dalam pelaksanaan praktik keperawatan yang aman dan bermutu. Selain sebagai pedoman praktik, standar profesi keperawatan memiliki fungsi akuntabilitas profesional dan hukum. Marquis dan Huston (2021) menyatakan bahwa standar profesi digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah tindakan perawat telah sesuai dengan praktik profesional yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila perawat bekerja sesuai standar, maka tindakan tersebut dinilai sah secara profesional dan dapat menjadi dasar perlindungan hukum bagi perawat maupun klien. Dengan kata lain, standar profesi keperawatan dapat disimpulkan sebagai landasan normatif, ilmiah, dan etis yang mengarahkan praktik keperawatan agar sesuai dengan nilai profesional, bukti ilmiah, dan tanggung jawab hukum. Standar ini menjadi rujukan utama dalam pendidikan keperawatan, praktik klinik, evaluasi kinerja, serta pengembangan profesional perawat secara berkelanjutan.

Standar profesi keperawatan terdiri dari beberapa jenis yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pembagian jenis standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik keperawatan dilaksanakan secara kompeten, sistematis, dan beretika. Secara umum, standar profesi keperawatan meliputi standar kompetensi, standar praktik, dan standar etika keperawatan (*American Nurses Association*, 2021).

## **1. Standar Kompetensi Keperawatan**

Standar kompetensi keperawatan adalah standar yang menetapkan kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh seorang perawat agar dapat melaksanakan praktik keperawatan secara aman dan profesional. Kompetensi ini mencakup tiga komponen utama, yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap profesional (*attitude*) (Potter et al., 2021). Pengetahuan mencakup pemahaman perawat terhadap teori keperawatan, ilmu biomedik, ilmu perilaku, serta prinsip-prinsip ilmiah yang mendasari tindakan keperawatan. Keterampilan berkaitan dengan kemampuan teknis dan klinis perawat dalam melakukan prosedur keperawatan secara tepat, aman, dan sesuai standar. Sementara itu, sikap profesional mencerminkan nilai etika, tanggung jawab, empati, komunikasi terapeutik, serta komitmen perawat terhadap keselamatan pasien. Standar kompetensi menjadi dasar dalam pendidikan keperawatan, uji kompetensi, sertifikasi, dan penilaian kinerja perawat. Seorang perawat yang tidak memenuhi standar kompetensi dianggap belum layak memberikan asuhan keperawatan secara mandiri karena berpotensi menimbulkan risiko bagi klien (Marquis & Huston, 2021).

## **2. Standar Praktik Keperawatan**

Standar praktik keperawatan adalah standar yang mengatur bagaimana asuhan keperawatan harus dilaksanakan secara sistematis dan profesional. Standar ini berfokus pada proses kerja perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Menurut *American Nurses Association* (2021), standar praktik keperawatan didasarkan pada proses keperawatan, yang meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahap harus dilakukan secara berurutan, terdokumentasi dengan baik, dan disesuaikan dengan kebutuhan individu klien. Standar praktik membantu perawat dalam mengambil keputusan klinis yang tepat dan berbasis data. Selain itu, standar praktik juga menekankan pentingnya dokumentasi keperawatan sebagai bukti bahwa tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan standar profesional. Dengan adanya standar



praktik, mutu asuhan keperawatan dapat dievaluasi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **3. Standar Etika Keperawatan**

Standar etika keperawatan adalah standar yang mengatur nilai moral, sikap, dan perilaku profesional perawat dalam menjalankan praktik keperawatan. Standar ini memastikan bahwa perawat tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, martabat klien, dan keadilan dalam pelayanan kesehatan. Standar etika mencakup prinsip-prinsip dasar seperti menghormati hak dan otonomi pasien, menjaga kerahasiaan informasi, bersikap adil, bertanggung jawab, serta mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan klien (Potter et al., 2021). Dalam praktik, standar etika menjadi pedoman perawat dalam menghadapi dilema etik, misalnya ketika kepentingan pasien bertentangan dengan kebijakan institusi atau keputusan keluarga. Menurut *World Health Organization* (2020), penerapan standar etika tenaga kesehatan berkontribusi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan. Dengan demikian, standar etika tidak hanya melindungi klien, tetapi juga menjaga martabat dan citra profesi keperawatan.

Standar profesi keperawatan memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan, mengendalikan, dan menjamin kualitas praktik keperawatan. Standar profesi tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai kerangka kerja profesional yang memastikan bahwa setiap tindakan keperawatan dilakukan secara aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Berikut ini adalah fungsi utama standar profesi dalam praktik keperawatan.

#### **1. Sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Praktik Keperawatan**

Fungsi utama standar profesi keperawatan adalah sebagai pedoman kerja bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Standar ini membantu perawat memahami apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan dalam batas kewenangan apa tindakan tersebut dapat dilaksanakan. Dengan adanya pedoman yang jelas, praktik keperawatan menjadi lebih terarah dan tidak bergantung pada kebiasaan atau penilaian subjektif perawat semata. Menurut *American Nurses Association* (2021), standar profesi memberikan panduan tentang ekspektasi praktik keperawatan profesional sehingga perawat dapat menjalankan perannya secara konsisten dan sesuai dengan prinsip ilmiah. Hal ini penting terutama dalam situasi klinis yang kompleks dan membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat.



## **2. Sebagai Alat Penjamin Mutu Asuhan Keperawatan**

Standar profesi berfungsi sebagai alat pengendalian dan penjamin mutu pelayanan keperawatan. Melalui standar ini, mutu asuhan keperawatan dapat dievaluasi secara objektif, baik oleh perawat itu sendiri, oleh institusi pelayanan kesehatan, maupun oleh organisasi profesi. Setiap tindakan keperawatan dapat dinilai apakah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau belum. Menurut, Potter et al. (2021) standar profesi memungkinkan dilakukan evaluasi dan audit praktik keperawatan secara sistematis. Dengan demikian, kekurangan dalam praktik dapat diidentifikasi dan diperbaiki melalui pelatihan, supervisi, atau pengembangan kompetensi lanjutan. Fungsi ini sangat penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara berkelanjutan.

## **3. Sebagai Dasar Pengembangan Pendidikan dan Kompetensi Perawat**

Standar profesi keperawatan juga berfungsi sebagai acuan dalam pendidikan dan pengembangan kompetensi perawat. Kurikulum pendidikan keperawatan, program pelatihan, serta uji kompetensi disusun berdasarkan standar profesi yang berlaku. Dengan demikian, lulusan pendidikan keperawatan diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan praktik klinik. Menurut Marquis dan Huston (2021), standar profesi menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan sumber daya manusia keperawatan, termasuk pelatihan berkelanjutan dan penilaian kinerja. Hal ini mendukung terciptanya perawat yang kompeten, adaptif, dan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

## **4. Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Profesional dan Etik**

Standar profesi berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban profesional dan etik bagi perawat. Setiap tindakan keperawatan yang dilakukan dapat dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan standar profesi, standar praktik, dan standar etika. Apabila terjadi masalah atau keluhan dari klien, standar profesi digunakan sebagai acuan untuk menilai apakah perawat telah bertindak secara profesional. Dalam hal ini, standar profesi membantu perawat mempertanggungjawabkan praktiknya tidak hanya kepada klien, tetapi juga kepada sejawat, institusi, dan organisasi profesi. Dengan demikian, standar profesi memperkuat akuntabilitas dan integritas praktik keperawatan (*American Nurses Association*, 2021).

## 5. Sebagai Perlindungan Hukum bagi Perawat dan Klien

Standar profesi keperawatan juga berfungsi sebagai perlindungan hukum, baik bagi perawat maupun klien. Bagi perawat, standar profesi menjadi dasar pembelaan apabila perawat menghadapi tuntutan hukum, selama tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Bagi klien, standar profesi menjamin bahwa asuhan keperawatan yang diterima aman, bermutu, dan sesuai dengan hak pasien. WHO (2020) menegaskan bahwa penerapan standar praktik tenaga kesehatan merupakan komponen penting dalam meningkatkan keselamatan pasien dan mengurangi risiko kesalahan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, standar profesi menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak klien dan keamanan praktik perawat.

Standar profesi keperawatan memiliki peran penting sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perawat dan klien dalam pelaksanaan praktik keperawatan. Perlindungan hukum ini muncul karena standar profesi berfungsi sebagai tolok ukur resmi untuk menilai apakah tindakan keperawatan telah dilakukan sesuai dengan kewenangan, kompetensi, dan etika profesi. Dengan demikian, standar profesi menciptakan kepastian hukum dalam hubungan antara perawat dan klien. Menurut *American Nurses Association* (2021), standar profesi keperawatan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi praktik perawat ketika terjadi sengketa, keluhan, atau dugaan kesalahan pelayanan. Tindakan perawat tidak dinilai berdasarkan opini pribadi atau hasil semata, tetapi berdasarkan kesesuaian tindakan dengan standar praktik yang berlaku. Hal ini menjadikan standar profesi sebagai landasan objektif dalam penegakan hukum dan etika profesi.

Bagi perawat, standar profesi berfungsi sebagai alat perlindungan hukum dan profesional dalam menjalankan praktik keperawatan. Apabila perawat telah melaksanakan asuhan keperawatan sesuai standar kompetensi, standar praktik, dan standar etika, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan profesional yang sah. Dalam situasi tertentu, meskipun hasil asuhan tidak sesuai harapan, perawat tetap dapat dilindungi secara hukum selama proses pelayanan telah sesuai standar.

Marquis dan Huston (2021) menjelaskan bahwa standar profesi menjadi dasar utama dalam menilai tanggung jawab profesional perawat. Ketika terjadi tuntutan hukum, perawat dapat menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan telah mengikuti prosedur, didukung oleh dokumentasi yang lengkap, dan sesuai dengan kewenangan profesinya. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar profesi sekaligus melindungi perawat dari tuduhan kelalaian atau malpraktik yang tidak berdasar. Standar profesi membantu perawat memahami batas

kewenangan praktik, sehingga perawat tidak melakukan tindakan di luar kompetensinya. Dengan bekerja dalam batas standar yang ditetapkan, perawat dapat menjalankan perannya secara aman dan percaya diri tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi klien, standar profesi keperawatan berfungsi sebagai jaminan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan. Klien berhak mendapatkan asuhan keperawatan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhan serta hak asasi manusia. Standar profesi memastikan bahwa perawat memberikan pelayanan berdasarkan ilmu pengetahuan, etika, dan prinsip keselamatan pasien, bukan berdasarkan kebiasaan atau kepentingan pribadi. *World Health Organization* (2020) menegaskan bahwa penerapan standar praktik tenaga kesehatan merupakan salah satu strategi utama dalam perlindungan pasien dan pencegahan kesalahan pelayanan. Apabila terjadi penyimpangan dari standar profesi, klien memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan keluhan atau tuntutan melalui mekanisme hukum maupun etik yang tersedia. Dengan adanya standar profesi, hak-hak klien seperti hak atas keselamatan, informasi, dan pelayanan yang bermutu menjadi lebih terlindungi. Standar ini juga memastikan bahwa klien diperlakukan secara adil, manusiawi, dan tanpa diskriminasi dalam setiap tindakan keperawatan.

Dalam proses hukum maupun etik, standar profesi keperawatan berfungsi sebagai alat penilaian objektif untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran dalam praktik keperawatan. Penilaian tidak hanya berfokus pada akibat yang dialami klien, tetapi juga pada proses tindakan keperawatan yang dilakukan oleh perawat. Potter et al. (2021) menyatakan bahwa dokumentasi keperawatan yang sesuai standar menjadi bukti penting dalam proses hukum. Dokumentasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu menunjukkan bahwa perawat telah menjalankan praktiknya sesuai dengan standar profesi. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap standar profesi dan dokumentasi yang baik merupakan bagian penting dari perlindungan hukum perawat dan klien.

Dengan adanya standar profesi sebagai perlindungan hukum, perawat dituntut untuk:

1. Memahami dan menerapkan standar profesi secara konsisten
2. Melaksanakan praktik keperawatan sesuai kewenangan dan kompetensi
3. Menjunjung tinggi etika dan keselamatan pasien
4. Melakukan dokumentasi keperawatan secara lengkap dan benar

Bagi klien, keberadaan standar profesi memberikan rasa aman dan kepercayaan bahwa pelayanan keperawatan yang diterima telah melalui mekanisme profesional yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **E. Integrasi Kompetensi Klinis dan Standar Profesi**

---

Kompetensi klinis dan standar praktik keperawatan merupakan dua komponen utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik keperawatan profesional. Kompetensi klinis menggambarkan kemampuan yang dimiliki oleh perawat, sedangkan standar praktik menjelaskan bagaimana kemampuan tersebut harus diterapkan secara sistematis dalam asuhan keperawatan. Dengan demikian, kompetensi klinis menjadi dasar kemampuan, sementara standar praktik menjadi pedoman penerapannya dalam situasi klinik nyata. Standar praktik keperawatan disusun berdasarkan asumsi bahwa perawat yang menjalankannya telah memiliki kompetensi klinis yang memadai. Artinya, standar praktik tidak dapat dilaksanakan secara optimal apabila perawat tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang sesuai. Kompetensi klinis memastikan bahwa perawat mampu melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis keperawatan, menyusun rencana asuhan, melaksanakan intervensi, serta mengevaluasi hasil asuhan sesuai standar *American Nurses Association* (2021). Hubungan antara kompetensi klinis dan standar praktik dapat dilihat dalam setiap tahapan proses keperawatan. Sebagai contoh, pada tahap pengkajian, perawat memerlukan kompetensi klinis berupa kemampuan komunikasi terapeutik, keterampilan pemeriksaan fisik, serta pengetahuan tentang kondisi kesehatan klien. Standar praktik kemudian mengarahkan bagaimana pengkajian tersebut dilakukan secara sistematis, terdokumentasi, dan berfokus pada kebutuhan individu klien (Potter et al., 2021). Tanpa kompetensi klinis yang memadai, pelaksanaan standar praktik pada tahap ini akan menjadi tidak efektif dan berpotensi menurunkan mutu asuhan keperawatan. Kompetensi klinis juga memungkinkan perawat untuk menginterpretasikan standar praktik secara tepat dalam konteks klinis yang beragam. Standar praktik bersifat umum dan berlaku luas, sedangkan kondisi klien bersifat unik dan kompleks. Oleh karena itu, perawat memerlukan kompetensi klinis yang kuat agar mampu menyesuaikan penerapan standar praktik dengan kebutuhan klien tanpa menyimpang dari prinsip profesional. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi klinis berfungsi sebagai jembatan antara standar praktik dan realitas pelayanan keperawatan di lapangan. WHO (2020) menegaskan bahwa peningkatan kompetensi tenaga kesehatan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penerapan standar praktik dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Perawat yang kompeten secara klinis lebih mampu menerapkan standar praktik secara konsisten, aman, dan berbasis bukti. Sebaliknya, rendahnya kompetensi klinis dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan standar praktik dan meningkatkan risiko kesalahan pelayanan. Dengan demikian, integrasi kompetensi klinis dan standar

praktik merupakan prasyarat utama dalam praktik keperawatan profesional. Kompetensi klinis menyediakan kapasitas individu perawat, sedangkan standar praktik menyediakan kerangka kerja profesional. Keduanya harus dikembangkan dan diterapkan secara bersamaan agar asuhan keperawatan yang diberikan benar-benar memenuhi prinsip keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan akuntabilitas profesional.

Standar profesi keperawatan menjadi pedoman utama bagi perawat dalam melaksanakan proses keperawatan secara profesional, sistematis, dan bertanggung jawab. Proses keperawatan terdiri dari lima tahap utama, yaitu pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pada setiap tahap tersebut, standar profesi berfungsi untuk memastikan bahwa asuhan keperawatan diberikan sesuai dengan kompetensi, etika, dan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), standar profesi keperawatan wajib dijadikan acuan dalam seluruh proses keperawatan agar praktik keperawatan memiliki mutu yang terjamin, aman bagi klien, serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan hukum. Dengan demikian, penerapan standar profesi tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada cara dan proses pemberian asuhan keperawatan.

Pada tahap pengkajian, standar profesi mengarahkan perawat untuk mengumpulkan data klien secara komprehensif, sistematis, dan akurat. Data yang dikaji meliputi aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Standar profesi menuntut perawat untuk menggunakan metode yang tepat, seperti wawancara terapeutik, observasi, pemeriksaan fisik, serta telaah data penunjang. Standar praktik menekankan bahwa pengkajian harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip etika, seperti menghormati privasi dan kerahasiaan klien. Perawat yang menerapkan standar profesi pada tahap ini akan menghasilkan data yang valid sehingga menjadi dasar yang kuat bagi penetapan diagnosis keperawatan (Potter et al., 2021).

Pada tahap diagnosis keperawatan, standar profesi mengatur bahwa perawat harus mampu menganalisis data hasil pengkajian secara kritis dan sistematis. Diagnosis keperawatan harus dirumuskan berdasarkan respons klien terhadap masalah kesehatan, bukan semata-mata diagnosis medis. *American Nurses Association* (2021) menyatakan bahwa diagnosis keperawatan merupakan tanggung jawab profesional perawat yang memerlukan kompetensi klinis, penalaran kritis, serta kepatuhan terhadap standar praktik. Penerapan standar profesi pada tahap ini membantu perawat menghindari kesalahan diagnosis yang dapat berdampak pada ketidaktepatan intervensi keperawatan.

Pada tahap perencanaan, standar profesi mengarahkan perawat untuk menyusun rencana asuhan keperawatan yang individual, realistis, dan berbasis kebutuhan klien. Rencana tersebut mencakup penetapan tujuan dan kriteria hasil yang terukur serta pemilihan intervensi keperawatan yang sesuai dengan diagnosis keperawatan. Standar profesi menegaskan pentingnya keterlibatan klien dan keluarga dalam proses perencanaan sebagai bentuk penghargaan terhadap otonomi klien. Selain itu, perencanaan harus didasarkan pada eviden ilmiah dan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia (PPNI, 2022).

Tahap implementasi merupakan tahap pelaksanaan intervensi keperawatan yang telah direncanakan. Standar profesi menuntut perawat untuk melaksanakan tindakan keperawatan secara aman, efektif, dan sesuai dengan kewenangan profesi. Setiap tindakan harus dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan prinsip keselamatan pasien. *World Health Organization* (2020) menekankan bahwa penerapan standar profesi pada tahap implementasi berperan penting dalam mencegah kesalahan pelayanan dan meningkatkan keselamatan klien. Perawat juga wajib mendokumentasikan setiap tindakan keperawatan sebagai bagian dari tanggung jawab profesional.

Pada tahap evaluasi, standar profesi mengarahkan perawat untuk menilai sejauh mana tujuan asuhan keperawatan telah tercapai. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dengan membandingkan kondisi klien terhadap kriteria hasil yang telah ditetapkan. Apabila tujuan belum tercapai, perawat harus melakukan modifikasi rencana asuhan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Penerapan standar profesi pada tahap evaluasi menunjukkan bahwa proses keperawatan bersifat dinamis dan berorientasi pada mutu pelayanan, bukan sekadar prosedur administratif.

Keselamatan pasien (*patient safety*) merupakan prinsip fundamental dalam pelayanan kesehatan, termasuk praktik keperawatan. Standar profesi keperawatan memiliki peran sentral dalam menjamin keselamatan pasien karena menjadi acuan normatif bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan secara aman, bermutu, dan bertanggung jawab. Melalui standar profesi, setiap tindakan keperawatan diarahkan untuk meminimalkan risiko cedera, kesalahan tindakan, serta kejadian tidak diharapkan pada pasien. Standar profesi keperawatan mengatur batas kewenangan, kompetensi, serta tanggung jawab perawat dalam praktik klinis. Dengan adanya standar ini, perawat diwajibkan melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan kompetensi klinis yang dimiliki dan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya medical error maupun nursing error yang dapat membahayakan keselamatan pasien. Penelitian dalam jurnal keperawatan

menunjukkan bahwa kepatuhan perawat terhadap standar praktik berhubungan signifikan dengan penurunan insiden keselamatan pasien di rumah sakit (Kim et al., 2021). Standar profesi berperan dalam mendorong penerapan pendekatan sistematis terhadap keselamatan pasien, seperti identifikasi pasien secara benar, komunikasi efektif, pencegahan infeksi, dan pengurangan risiko jatuh. Standar ini juga menegaskan pentingnya dokumentasi keperawatan yang akurat dan berkesinambungan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan pasien. Dokumentasi yang sesuai standar memungkinkan kontinuitas asuhan dan mengurangi risiko kesalahan akibat informasi yang tidak lengkap (Potter et al., 2021). Organisasi kesehatan global, seperti *World Health Organization*, menegaskan bahwa tenaga keperawatan yang bekerja berdasarkan standar profesi memiliki kontribusi besar dalam menciptakan budaya keselamatan pasien (*patient safety culture*). WHO (2021) menyatakan bahwa standar praktik yang jelas dan dipatuhi secara konsisten merupakan fondasi utama dalam sistem pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Dengan demikian, standar profesi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam perlindungan keselamatan pasien.

Standar praktik keperawatan internasional banyak dirujuk dari organisasi profesi keperawatan yang memiliki legitimasi global, salah satunya adalah *American Nurses Association* (ANA). ANA secara konsisten mengembangkan dan memperbarui *Nursing: Scope and Standards of Practice* sebagai pedoman resmi bagi praktik keperawatan profesional. Dokumen ini menjadi rujukan internasional karena disusun berdasarkan eviden ilmiah terkini, praktik terbaik (*best practices*), serta nilai-nilai etik profesi keperawatan. Standar praktik yang dikeluarkan oleh ANA mencakup dua aspek utama, yaitu *standards of practice* dan *standards of professional performance*. *Standards of practice* menguraikan tahapan proses keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Sementara itu, *standards of professional performance* mengatur perilaku profesional perawat, seperti etika, komunikasi, kolaborasi, pendidikan berkelanjutan, dan praktik berbasis bukti (ANA, 2021).

Rujukan standar praktik dari ANA memiliki peran penting dalam pengembangan praktik keperawatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak standar nasional keperawatan mengadopsi prinsip-prinsip dasar dari standar ANA dengan penyesuaian konteks sosial, budaya, dan regulasi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa standar ANA berfungsi sebagai benchmark internasional dalam menjamin mutu dan keselamatan praktik keperawatan (Alligood, 2022). Standar praktik ANA juga menekankan bahwa keselamatan pasien merupakan tanggung jawab profesional perawat yang tidak dapat dipisahkan dari kompetensi



klinis dan etika profesi. Perawat diharapkan mampu mengintegrasikan pengetahuan ilmiah, keterampilan klinis, dan nilai profesional dalam setiap tindakan keperawatan. Dengan mengacu pada standar praktik internasional ini, praktik keperawatan dapat berjalan secara konsisten, berkualitas, dan selaras dengan tuntutan pelayanan kesehatan global.

## **F. Strategi Pengembangan Praktik Keperawatan**

---

Pengembangan praktik keperawatan merupakan upaya terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Strategi pengembangan praktik keperawatan harus berorientasi pada peningkatan kompetensi perawat serta penerapan standar profesi dan keselamatan pasien. Dua strategi utama yang diakui secara luas dalam literatur keperawatan adalah pendidikan dan pelatihan berkelanjutan serta penerapan praktik keperawatan berbasis bukti (*Evidence-Based Practice*). Pendidikan dan pelatihan keperawatan berkelanjutan merupakan proses pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*) yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi klinis serta profesional perawat. Dalam konteks praktik keperawatan modern, pengetahuan dan keterampilan perawat tidak bersifat statis, melainkan harus terus diperbarui seiring dengan perkembangan ilmu kesehatan, teknologi medis, dan kebijakan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pendidikan berkelanjutan menjadi kebutuhan fundamental dalam pengembangan praktik keperawatan profesional. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti pelatihan klinis, workshop, seminar ilmiah, pendidikan formal lanjutan, serta pelatihan berbasis kompetensi. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup penguatan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, komunikasi terapeutik, serta kepemimpinan dalam praktik keperawatan. Penelitian menunjukkan bahwa perawat yang aktif mengikuti pendidikan berkelanjutan memiliki tingkat kompetensi dan kepercayaan diri yang lebih baik dalam memberikan asuhan keperawatan (Fukada, 2020). *World Health Organization* menegaskan bahwa pengembangan kapasitas tenaga keperawatan melalui pendidikan berkelanjutan merupakan investasi strategis dalam peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan. WHO (2020) menyatakan bahwa perawat yang memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan berkelanjutan cenderung mampu beradaptasi dengan perubahan sistem kesehatan dan berkontribusi lebih efektif dalam tim interprofesional. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berkelanjutan tidak hanya berdampak pada individu perawat, tetapi juga pada sistem pelayanan



kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan berperan penting dalam menjaga profesionalisme dan akuntabilitas perawat. Dengan mengikuti program pengembangan kompetensi secara teratur, perawat dapat memastikan bahwa praktik yang dilakukan tetap sesuai dengan standar profesi, kode etik, dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, pendidikan berkelanjutan menjadi salah satu indikator penting mutu praktik keperawatan (Potter et al., 2021).

Praktik keperawatan berbasis bukti atau *Evidence-Based Practice* (EBP) merupakan pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan klinis yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis perawat, serta nilai dan preferensi pasien. Penerapan EBP menjadi strategi utama dalam pengembangan praktik keperawatan karena memastikan bahwa asuhan keperawatan yang diberikan tidak hanya berdasarkan kebiasaan, tetapi didukung oleh hasil penelitian yang valid dan terkini. EBP membantu perawat dalam memilih intervensi keperawatan yang paling efektif dan aman bagi pasien. Dengan menggunakan hasil penelitian dan pedoman praktik klinis, perawat dapat mengurangi variasi praktik yang tidak perlu serta meningkatkan konsistensi dan mutu pelayanan keperawatan. Studi keperawatan menunjukkan bahwa penerapan EBP berhubungan dengan peningkatan hasil klinis pasien, kepuasan pasien, serta keselamatan pelayanan kesehatan (Melnyk & Fineout-Overholt, 2023). *American Nurses Association* menegaskan bahwa praktik keperawatan profesional harus didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat dan relevan. Dimana dalam setiap proses keperawatan perawat memiliki tanggung jawab profesional untuk mencari, menilai, dan menerapkan bukti ilmiah dalam praktik klinis. Dengan demikian, EBP bukan sekadar pilihan, melainkan bagian integral dari standar profesional perawat. Penerapan EBP dalam praktik keperawatan juga mendorong budaya berpikir kritis dan pembelajaran berkelanjutan. Perawat dituntut untuk mampu mengidentifikasi masalah klinis, merumuskan pertanyaan berbasis praktik, menelusuri literatur ilmiah, serta mengevaluasi kualitas bukti yang tersedia. Proses ini memperkuat peran perawat sebagai tenaga profesional yang berkontribusi aktif dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan (Stevens, 2021). EBP berperan sebagai jembatan antara teori dan praktik keperawatan. Melalui penerapan EBP, hasil penelitian keperawatan tidak berhenti pada ranah akademik, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dalam praktik klinis. Hal ini menjadikan EBP sebagai strategi kunci dalam pengembangan praktik keperawatan yang adaptif, ilmiah, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Supervisi klinik dan mentoring merupakan strategi penting dalam pengembangan praktik keperawatan karena berfungsi sebagai sarana pembinaan

profesional perawat secara langsung di area praktik. Supervisi klinik adalah proses pengawasan, pembimbingan, dan evaluasi yang dilakukan oleh perawat senior atau pimpinan keperawatan terhadap perawat pelaksana untuk memastikan bahwa asuhan keperawatan diberikan sesuai dengan standar profesi dan standar praktik yang berlaku. Melalui supervisi klinik, perawat mendapatkan umpan balik konstruktif terkait kompetensi klinis, sikap profesional, serta kepatuhan terhadap prosedur keselamatan pasien. Mentoring keperawatan memiliki peran yang saling melengkapi dengan supervisi klinik. Mentoring merupakan hubungan profesional yang bersifat kolaboratif antara perawat yang lebih berpengalaman (mentor) dengan perawat yang lebih junior (mentee), dengan tujuan mengembangkan kompetensi, kepercayaan diri, dan identitas profesional perawat. Berbeda dengan supervisi yang bersifat struktural, mentoring lebih menekankan pada dukungan psikososial, penguatan nilai profesional, dan transfer pengalaman klinis (Nowell et al., 2021). Literatur keperawatan menunjukkan bahwa supervisi klinik dan mentoring yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan kualitas asuhan keperawatan, penurunan kesalahan klinis, serta peningkatan kepuasan kerja perawat. Penelitian sistematis dalam lima tahun terakhir menyimpulkan bahwa perawat yang mendapatkan supervisi dan mentoring secara konsisten menunjukkan peningkatan kompetensi klinis dan kepatuhan terhadap standar praktik (Van Heeden et al., 2020). *World Health Organization* menegaskan bahwa supervisi dan mentoring merupakan bagian integral dari penguatan sistem pelayanan kesehatan. Selain itu, mekanisme supervisi klinik yang terstruktur membantu memastikan bahwa tenaga keperawatan bekerja sesuai dengan kompetensi dan kewenangan profesionalnya. Dengan demikian, supervisi dan mentoring tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai strategi pembelajaran berkelanjutan dalam praktik keperawatan.

Evaluasi kompetensi merupakan proses sistematis untuk menilai kemampuan perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan sesuai dengan standar kompetensi dan standar profesi. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap aspek pengetahuan, keterampilan klinis, dan sikap profesional perawat. Melalui evaluasi kompetensi, institusi pelayanan kesehatan dapat memastikan bahwa setiap perawat memiliki kemampuan yang memadai untuk memberikan asuhan keperawatan yang aman dan bermutu. Audit mutu keperawatan merupakan bagian dari evaluasi praktik keperawatan yang berfokus pada penilaian kualitas asuhan keperawatan yang diberikan kepada klien. Audit ini dilakukan dengan membandingkan praktik aktual dengan standar yang telah ditetapkan, baik standar nasional maupun internasional. Audit mutu keperawatan mencakup evaluasi

dokumentasi keperawatan, kepatuhan terhadap prosedur, serta pencapaian hasil asuhan keperawatan (Potter et al., 2021).

Dalam *Nursing: Scope and Standards of Practice*, ANA (2021) menyatakan bahwa evaluasi berkelanjutan terhadap praktik keperawatan diperlukan untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Evaluasi ini juga menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan kompetensi perawat secara individual maupun organisasi. Selain itu, audit mutu keperawatan berperan penting dalam membangun budaya perbaikan berkelanjutan (continuous quality improvement). Hasil audit dapat digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan praktik, merancang intervensi perbaikan, serta memantau efektivitas perubahan yang dilakukan. Dengan demikian, evaluasi kompetensi dan audit mutu bukan bersifat menghukum, melainkan berorientasi pada peningkatan mutu praktik keperawatan secara sistematis dan berkelanjutan (White et al., 2022).

Budaya profesional dan etika keperawatan merupakan fondasi utama dalam pengembangan praktik keperawatan yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien. Budaya profesional mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku perawat dalam menjalankan praktik keperawatan sesuai dengan standar profesi, kode etik, dan tanggung jawab sosial. Penguatan budaya profesional bertujuan untuk membentuk perawat yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga memiliki integritas moral dan komitmen terhadap nilai-nilai profesi. Etika keperawatan berfungsi sebagai pedoman moral bagi perawat dalam menghadapi dilema etis dalam praktik klinis. Prinsip-prinsip etika seperti menghormati otonomi klien, berbuat baik (beneficence), tidak merugikan (non-maleficence), keadilan, dan kejujuran menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan keperawatan. Penerapan etika keperawatan yang konsisten membantu perawat menjaga kepercayaan klien dan masyarakat terhadap profesi keperawatan (Butts & Rich, 2022). Penguatan budaya profesional dan etika keperawatan dapat dilakukan melalui pendidikan etika, keteladanan pimpinan keperawatan, serta penerapan kebijakan organisasi yang mendukung praktik etis. Lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai profesional dan etika terbukti berhubungan dengan peningkatan mutu asuhan keperawatan, kepuasan pasien, dan kesejahteraan perawat (Numminen et al., 2021). *World Health Organization* (2021), menegaskan bahwa budaya profesional dan etika yang kuat merupakan elemen kunci dalam sistem pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. WHO juga menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang bekerja dalam budaya profesional yang positif lebih mampu memberikan pelayanan yang berpusat pada pasien dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, penguatan budaya profesional dan etika

keperawatan merupakan strategi strategis dalam pengembangan praktik keperawatan berkelanjutan.

## **G. Dampak Pengembangan Praktik Keperawatan**

---

Pengembangan praktik keperawatan merupakan upaya strategis yang berdampak luas tidak hanya pada kualitas asuhan keperawatan, tetapi juga pada keselamatan pasien, profesionalisme perawat, serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan. Praktik keperawatan yang dikembangkan secara sistematis melalui peningkatan kompetensi klinis, penerapan standar profesi, dan praktik berbasis bukti akan menghasilkan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan berorientasi pada kebutuhan klien. Dampak pengembangan praktik keperawatan dapat dilihat dari berbagai aspek berikut.

Pengembangan praktik keperawatan berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu asuhan keperawatan. Mutu asuhan keperawatan tercermin dari ketepatan pengkajian, akurasi diagnosis keperawatan, kesesuaian intervensi, serta keberhasilan evaluasi asuhan yang diberikan kepada klien. Praktik keperawatan yang berbasis kompetensi dan standar profesi memungkinkan perawat memberikan asuhan secara sistematis, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan individu pasien. Penerapan praktik keperawatan berbasis bukti (*Evidence-Based Practice*) juga menjadi faktor penting dalam peningkatan mutu asuhan keperawatan. Dengan mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah ke dalam praktik klinis, perawat dapat memilih intervensi yang paling efektif dan aman. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan EBP dalam praktik keperawatan berhubungan dengan peningkatan hasil klinis pasien dan penurunan variasi praktik yang tidak perlu (Melnyk & Fineout-Overholt, 2023). Menurut *American Nurses Association* (2021), mutu asuhan keperawatan merupakan indikator utama profesionalisme perawat. Standar praktik yang diterapkan secara konsisten membantu memastikan bahwa setiap pasien menerima asuhan keperawatan yang berkualitas, berkesinambungan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Pengembangan praktik keperawatan juga berdampak signifikan terhadap peningkatan keselamatan dan kepuasan pasien. Perawat yang memiliki kompetensi klinis yang baik dan bekerja sesuai standar profesi lebih mampu mengidentifikasi risiko, mencegah kesalahan tindakan, serta merespons perubahan kondisi pasien secara cepat dan tepat. Hal ini berkontribusi pada penurunan kejadian tidak diharapkan (*adverse events*) dalam pelayanan kesehatan. Keselamatan pasien tidak hanya berkaitan dengan pencegahan kesalahan, tetapi juga mencakup pemberian asuhan yang berpusat pada pasien (*patient-centered care*). Praktik keperawatan yang dikembangkan dengan pendekatan profesional

dan etis mendorong perawat untuk menghormati hak, nilai, dan preferensi pasien dalam setiap pengambilan keputusan klinis. Penelitian menunjukkan bahwa keselamatan pasien yang terjaga dengan baik berkorelasi positif dengan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan (Kim et al., 2021). *World Health Organization* (2021) menegaskan bahwa perawat memiliki peran kunci dalam sistem keselamatan pasien. WHO menyatakan bahwa penguatan praktik keperawatan melalui standar profesi dan pengembangan kompetensi merupakan salah satu strategi utama dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.

Dampak penting lain dari pengembangan praktik keperawatan adalah penguatan profesionalisme dan kepercayaan diri perawat. Perawat yang dibekali dengan kompetensi klinis yang memadai, pemahaman standar profesi, serta kemampuan berpikir kritis akan lebih percaya diri dalam melaksanakan asuhan keperawatan dan mengambil keputusan klinis. Kepercayaan diri ini penting dalam menghadapi kompleksitas masalah kesehatan dan tuntutan pelayanan yang semakin tinggi. Profesionalisme perawat tercermin dari kemampuan menjalankan praktik keperawatan sesuai dengan standar, kode etik, dan tanggung jawab profesional. Pengembangan praktik keperawatan melalui pendidikan berkelanjutan, supervisi klinik, dan evaluasi kompetensi membantu perawat membangun identitas profesional yang kuat. Studi dalam jurnal keperawatan menunjukkan bahwa perawat yang mendapatkan dukungan pengembangan profesional memiliki tingkat kepuasan kerja dan komitmen terhadap profesi yang lebih tinggi (Fukada, 2020). Selain itu, penguatan profesionalisme perawat berdampak pada meningkatnya peran perawat sebagai mitra sejajar dalam tim interprofesional. Perawat yang profesional dan percaya diri lebih mampu berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain serta berkontribusi aktif dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara keseluruhan (Potter et al., 2021).

Pengembangan praktik keperawatan yang berkelanjutan juga berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan. Masyarakat cenderung mempercayai profesi yang menunjukkan kompetensi, etika, dan akuntabilitas dalam memberikan pelayanan. Praktik keperawatan yang bermutu dan aman akan membentuk citra positif perawat sebagai tenaga kesehatan profesional yang memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan. Kepercayaan masyarakat dibangun melalui pengalaman langsung pasien dan keluarga dalam menerima asuhan keperawatan. Ketika perawat mampu memberikan pelayanan yang humanis, kompeten, dan berorientasi pada keselamatan pasien, maka persepsi positif terhadap profesi keperawatan akan semakin kuat. Hal ini sejalan dengan pandangan WHO (2020) yang menyatakan

bahwa kualitas praktik keperawatan berkontribusi besar terhadap kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, profesi keperawatan akan memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat. Kondisi ini mendukung penguatan posisi perawat dalam sistem kesehatan, peningkatan penghargaan terhadap profesi, serta dukungan masyarakat terhadap pengembangan pendidikan dan praktik keperawatan di masa depan.

## **H. Simpulan**

---

Pengembangan praktik keperawatan merupakan proses strategis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan, keselamatan pasien, serta profesionalisme perawat. Praktik keperawatan yang dikembangkan berdasarkan kompetensi klinis dan standar profesi memungkinkan perawat memberikan asuhan secara sistematis, ilmiah, dan bertanggung jawab. Kompetensi klinis yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan praktik keperawatan yang aman dan efektif. Standar profesi keperawatan berperan sebagai pedoman penting dalam mengarahkan praktik keperawatan agar sesuai dengan nilai etik, regulasi, dan tuntutan mutu pelayanan kesehatan. Penerapan standar profesi dalam setiap tahap proses keperawatan—mulai dari pengkajian hingga evaluasi—berkontribusi langsung terhadap peningkatan keselamatan dan kepuasan pasien. Selain itu, rujukan terhadap standar praktik nasional dan internasional memperkuat konsistensi serta kualitas praktik keperawatan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Strategi pengembangan praktik keperawatan, seperti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penerapan praktik keperawatan berbasis bukti, supervisi klinik, mentoring, serta evaluasi kompetensi dan audit mutu, terbukti mampu meningkatkan kualitas praktik dan membangun budaya perbaikan berkelanjutan. Penguatan budaya profesional dan etika keperawatan juga menjadi elemen kunci dalam menjaga integritas profesi serta meningkatkan kepercayaan diri perawat dalam menjalankan perannya. Secara keseluruhan, pengembangan praktik keperawatan memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya bagi perawat sebagai tenaga profesional, tetapi juga bagi pasien, institusi pelayanan kesehatan, dan masyarakat. Peningkatan mutu asuhan, keselamatan dan kepuasan pasien, penguatan profesionalisme perawat, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi keperawatan merupakan indikator keberhasilan pengembangan praktik keperawatan. Dengan demikian, pengembangan praktik keperawatan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, beretika, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

## **I. Referensi**

---

- Alligood, M. R. (2022). *Nursing theorists and their work* (10th ed.). Elsevier.
- American Nurses Association. (2021). *Nursing: Scope and standards of practice* (4th ed.). American Nurses Association.
- Benner, P., Sutphen, M., Leonard, V., & Day, L. (2019). *Educating nurses: A call for radical transformation*. Jossey-Bass.
- Fukada, M. (2020). Nursing competency: Definition, structure and development. *Yonago Acta Medica*, 63(1), 1–7. <https://doi.org/10.33160/yam.2020.03.001>
- Kim, Y., Lee, E., & Kim, J. (2021). Nurses' adherence to professional standards and patient safety outcomes in hospital settings. *Journal of Nursing Management*, 29(6), 1561–1569. <https://doi.org/10.1111/jonm.13308>
- Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2021). *Leadership roles and management functions in nursing: Theory and application* (10th ed.). Wolters Kluwer.
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2023). *Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice* (5th ed.). Wolters Kluwer.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2022). *Standar praktik keperawatan profesional Indonesia*. PPNI. Jakarta
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2021). *Fundamentals of nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Stevens, K. R. (2021). The impact of evidence-based practice in nursing and the next big ideas. *Online Journal of Issues in Nursing*, 26(2). <https://doi.org/10.3912/OJIN.Vol26No02Man02>
- World Health Organization. (2020). *State of the world's nursing 2020: Investing in education, jobs and leadership*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2021). *Global patient safety action plan 2021–2030*. Geneva: WHO

## **J. Glosarium**

---

WUS = Wanita Usia Subur



## PROFIL PENULIS



**Sudarso, S.Kep,Ns., M.Kep** Lahir di Sumenep, 20 Mei 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi di Stikes Dian Husada Mojokerto. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada *Universitas Muhammadiyah* Yogyakarta. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 .Saat ini penulis bekerja di *STIKES Bahrul Ulum Jombang* mengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah.



**Sri Martini, S.Kep., Ns., M.Kep.** Lahir di Nama : Sri Martini, S.Kep., Ns., M.Kep. Penulis lahir di Semarang, 13 Nopember 1967. Pendidikan tinggi yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Sumatera Utara tahun 2009. Pendidikan S2 pada Universitas Airlangga Surabaya dan lulus tahun pada tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1988 di RS Charitas Palembang, Kemudian pindah ke Medan tahun 1991 bekerja di RS Santa Elisabeth Medan sampai dengan tahun 2009 dan mulai bekerja aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan pada tahun 2011. Penulis selama di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan pernah dipercayakan Sebagai Koordinator Laboratorium. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elisabeth Medan mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Komunitas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai praktisi keperawatan maternitas dan publikasi. e-mail: srmartini99@gmail.com



## PROFIL PENULIS



**Ns. Indra Tri Astuti, M.Kep., Sp.Kep.An** Lahir di Tegal, 18 September 1978. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII di Akademi Keperawatan Islam Sultan Agung (AKPERISSA) Tahun 1999, S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Dponegoro tahun 2003, melanjutkan Profesi Ners di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Dponegoro tahun 2005 . Pendidikan S2 Keperawatan di Universitas Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2011 serta melanjutkan Program Spesialis Keperawatan di Universitas Indonesia lulus pada tahun 2012. Saat ini sedang melanjutkan Program Doktorat di Universitas Arilangga Surabaya. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2000 di APKERISSA Semarang dan saat ini di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, mengampu mata kuliah Keperawatan Anak. Metodologi Keperawatan, Gizi dan Diet, Biostatistik, Dokumentasi Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [indra@unissula.ac.id](mailto:indra@unissula.ac.id)

Motto: "Jadilah Versi Terbaik Dari Dirimu"

## PROFIL PENULIS



### **Ns. Mutianingsih , M.Kep**

Lahir di Kuningan, 10 desember 1988 dan merupakan staff pengajar di Akepr RS Efarina. Penulis merupakan lulusan Sarjana Keperawatan dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Padjadjaran tahun 2011 dan menyelesaikan Pendidikan Profesi Ners dari kampus yang sama pada tahun 2012. Penulis melanjutkan Pendidikan magister pada tahun 2017 di Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia peminatan Keperawatan Jiwa dan

lulus pada tahun 2019.

Penulis saat ini aktif sebagai staff pengajar di Akper RS Efarina dan mengampu mata Kuliah Keperawatan Jiwa, Keperawatan Gerontik dan Keperawatan Keluarga. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, dan publikasi ilmiah baik di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [nsmutianingsih0920@gmail.com](mailto:nsmutianingsih0920@gmail.com)



**Aini Alifatin, S.Kp., M.Kep.** Lahir di Bojonegoro, 02 Desember 1970. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Keperawatan, lulus tahun 1991, selanjutnya melanjutkan pada jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Indonesia lulus tahun 2000, dan pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991 sebagai

perawat pelaksana di rumah sakit, dan kemudian beralih sebagai staff dosen Diploma III Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Malang sejak 1993 hingga sekarang menjadi Fakultas Ilmu Kesehatan yang terdiri atas program D3, S1, S2 dan profesi Keperawatan serta jurusan kesehatan lainnya diantaranya Farmasi dan Fisioterapi. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Konsep Dasar Keperawatan, Etik dan Hukum Keperawatan, komunikasi keperawatn dan Keperawatan Anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan aktif dalam kegiatan kajian-kajian parenting dan perlindungan perempuan dan anak di tingkat universitas serta Malang raya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [alifatin@umm.ac.id](mailto:alifatin@umm.ac.id).

Motto: "Selalu Berpikiran Positif, Bahkan Dalam Situasi Tersulit."

## PROFIL PENULIS



**Ulfa Munawaroh Diniyah, S.Kep., Ns.** lahir di Negeri Katon, Lampung Timur, pada 3 Maret 1999. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Muhammadiyah Surakarta, serta saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Keperawatan di universitas yang sama. Di samping aktivitas akademik, penulis saat ini bekerja sebagai supporting staff, yang turut memperkaya pengalaman profesional dan pemahaman praktis dalam bidang pelayanan dan manajemen pendukung. Minat akademik penulis berfokus pada keperawatan medikal bedah, khususnya pada asuhan keperawatan pasien dengan penyakit kronis, pengembangan instrumen keperawatan, serta penerapan keperawatan berbasis bukti dalam praktik klinik dan penelitian. Penulis dapat dihubungi melalui [ulfamunawarohdiniyah03@gmail.com](mailto:ulfamunawarohdiniyah03@gmail.com)

**Nina Rizka Rohmawati, S.Kep.Ns., M.Kep** Lahir di Sidoarjo, 22 Februari 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2010-2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya dan lulus tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Kesehatan Kerta Cendekia mengampu mata kuliah EBN, Keperawatan Jiwa, Keperawatan Anak. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [nina@pkc.ac.id](mailto:nina@pkc.ac.id)

Motto: "Berbasis bukti, berlandaskan empati."

## Sinopsis

Buku Bunga Rampai Inovasi Praktik Keperawatan di Berbagai Bidang: Medikal Bedah, Maternitas, Anak, Jiwa, Komunitas, dan Gerontik menyajikan rangkaian praktik keperawatan yang aplikatif dan berbasis bukti untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang terus berkembang. Bunga rampai ini menekankan inovasi klinis, penguatan peran perawat dalam pengambilan keputusan, serta pemanfaatan kolaborasi dan teknologi untuk meningkatkan keselamatan pasien, efektivitas asuhan, dan mutu pelayanan di berbagai tatanan layanan.

Pembahasan dimulai dari inovasi praktik keperawatan pada bidang klinis utama. Chapter 1 membahas praktik keperawatan medikal bedah, meliputi inovasi perawatan luka, manajemen infus, dan perawatan pasca operasi sebagai upaya pencegahan komplikasi dan percepatan pemulihan. Chapter 2 mengulas praktik keperawatan maternitas yang mencakup Ante Natal Care (ANC), manajemen persalinan, serta dukungan laktasi berbasis bukti untuk memperkuat kesehatan ibu dan bayi. Selanjutnya, Chapter 3 menyoroti keperawatan anak melalui pendekatan family centered care dan manajemen nyeri pediatrik yang holistik, serta cara mengintegrasikan keduanya dalam praktik. Chapter 4 melengkapi spektrum layanan dengan praktik keperawatan jiwa yang menekankan terapi aktivitas kelompok, komunikasi efektif, dan manajemen krisis guna mendukung pemulihan dan fungsi sosial klien.

Bagian akhir buku memperkuat aspek sistem dan kesiapan praktik keperawatan di era modern. Chapter 5 membahas kolaborasi interprofesional dalam praktik keperawatan—konsep, landasan teoretis, peran perawat, bentuk implementasi, hambatan, hingga strategi penguatan dan dampaknya terhadap mutu pelayanan. Chapter 6 menguraikan pemanfaatan teknologi seperti tele-nursing, aplikasi mobile, dan peralatan klinis modern untuk meningkatkan kontinuitas asuhan dan efisiensi layanan. Chapter 7 menutup dengan pengembangan praktik keperawatan berbasis kompetensi klinis dan standar profesi, termasuk integrasi keduanya serta strategi penguatan agar praktik perawat semakin profesional dan terukur. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, perawat klinis, pendidik, dan pengelola layanan sebagai referensi ringkas namun komprehensif dalam mendorong praktik keperawatan yang inovatif dan bermutu.



Buku Bunga Rampai Inovasi Praktik Keperawatan di Berbagai Bidang: Medikal Bedah, Maternitas, Anak, Jiwa, Komunitas, dan Gerontik menyajikan rangkaian praktik keperawatan yang aplikatif dan berbasis bukti untuk menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang terus berkembang. Bunga rampai ini menekankan inovasi klinis, penguatan peran perawat dalam pengambilan keputusan, serta pemanfaatan kolaborasi dan teknologi untuk meningkatkan keselamatan pasien, efektivitas asuhan, dan mutu pelayanan di berbagai tatanan layanan.

Pembahasan dimulai dari inovasi praktik keperawatan pada bidang klinis utama. Chapter 1 membahas praktik keperawatan medikal bedah, meliputi inovasi perawatan luka, manajemen infus, dan perawatan pasca operasi sebagai upaya pencegahan komplikasi dan percepatan pemulihan. Chapter 2 mengulas praktik keperawatan maternitas yang mencakup Ante Natal Care (ANC), manajemen persalinan, serta dukungan laktasi berbasis bukti untuk memperkuat kesehatan ibu dan bayi. Selanjutnya, Chapter 3 menyoroti keperawatan anak melalui pendekatan family centered care dan manajemen nyeri pediatrik yang holistik, serta cara mengintegrasikan keduanya dalam praktik. Chapter 4 melengkapi spektrum layanan dengan praktik keperawatan jiwa yang menekankan terapi aktivitas kelompok, komunikasi efektif, dan manajemen krisis guna mendukung pemulihan dan fungsi sosial klien.

Bagian akhir buku memperkuat aspek sistem dan kesiapan praktik keperawatan di era modern. Chapter 5 membahas kolaborasi interprofesional dalam praktik keperawatan—konsep, landasan teoretis, peran perawat, bentuk implementasi, hambatan, hingga strategi penguatan dan dampaknya terhadap mutu pelayanan. Chapter 6 menguraikan pemanfaatan teknologi seperti tele-nursing, aplikasi mobile, dan peralatan klinis modern untuk meningkatkan kontinuitas asuhan dan efisiensi layanan. Chapter 7 menutup dengan pengembangan praktik keperawatan berbasis kompetensi klinis dan standar profesi, termasuk integrasi keduanya serta strategi penguatan agar praktik perawat semakin profesional dan terukur. Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, perawat klinis, pendidik, dan pengelola layanan sebagai referensi ringkas namun komprehensif dalam mendorong praktik keperawatan yang inovatif dan bermutu.

ISBN 978-634-7556-88-2



Penerbit:

**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

